小儿推拿图解

王道全　编著

-64

山东科学技术出版社

小儿推拿图解

王道全　编著

北京中医药大学图书馆
0153305

山东科学技术出版社

小儿推拿图解

王道全　编著

*

山东科学技术出版社出版
(济南市玉函路16号　邮编:250002)
山东科学技术出版社发行
(济南市玉函路16号　电话:2014651)
山东新华印刷厂潍坊厂印刷

*

850mm×1168mm　1/32 开本　7.5 印张　159 千字
1998 年 7 月第 1 版　　1998 年 7 月第 1 次印刷
印数：1—5000

ISBN 7—5331—2227—5
R·672　定价 12.50 元

前　言

小儿推拿又称小儿按摩，历史悠久，源远流长，自成体系，独具一格，是我国传统医疗方法中的一种。它具有简便易行，易于掌握，无副作用，安全可靠，疗效显著等优点，深受广大群众欢迎。为了进一步提高小儿推拿医疗技术水平，满足广大家长及推拿爱好者防治小儿疾病的需要，作者通过近20年教学、医疗、科研的体验，继出版《成人推拿图解》之后，又编著了这部《小儿推拿图解》，以飨读者。

该书主要介绍了小儿推拿的基本知识，40种小儿推拿手法，102个常用穴位，36种常见病症的治疗，典型验案24例，并插有手法穴位诊疗图201幅，为了便于学习运用，书末附有穴位、复合手法与穴位功用归类表。

该书全面系统，图文并茂，内容丰富，通俗易懂，切合实用，是一部学习小儿推拿疗法的入门书。本书特别适用于广大家长学习小儿推拿，防病治病；也可供从事推拿临床、教学、科研工作者及在校师生、基层医务人员、保育员学习参考。

编　者

于山东中医药大学附属医院

1997年5月

目　录

第一章　小儿推拿的基础知识 …… 1

第一节　小儿推拿简史 …… 1

第二节　小儿推拿疗法的特点 …… 2

第三节　小儿推拿注意事项 …… 3

第四节　小儿推拿常用介质 …… 4

第五节　小儿生长发育特点 …… 5

一、年龄分期 …… 5

二、生理常数 …… 8

第二章　小儿推拿手法 …… 13

第一节　单式手法…… 13

直推法…… 13

分推法…… 14

合推法…… 14

指摩法…… 14

掌摩法…… 15

拿法…… 15

掐法…… 16

指按法…… 17

指揉法…… 17

大鱼际揉法…… 18

掌根揉法…… 18

运法…… 19

捏法…… 20

捣法…… 21

搓法…… 22

擦法…… 22

挤捏法…… 23

摇法…… 24

捻法…… 25

扯法…… 25

推法…… 26

小推法…… 27

刮法…… 28

拍法…… 28
第二节　复合手法…… 29
打马过天河…… 29
黄蜂入洞…… 30
水底捞月…… 30
按弦走搓摩…… 31
猿猴摘果…… 31
按肩井（总收法）
…… 32
摇肘肘…… 33
飞经走气…… 33
二龙戏珠…… 35
苍龙摆尾…… 35
揉脐及龟尾并推
七节骨…… 36
赤凤点头…… 37
凤凰展翅…… 38
运土入水…… 38
运水入土…… 39
开璇玑…… 39
第三章　小儿常用穴位
…… 41
第一节　腧穴定位法
…… 41
一、骨度分寸定位法
…… 41
头部…… 41
胸腹部…… 44
背部…… 44
上肢部…… 45
下肢部…… 45
二、人体自然标志取
穴法…… 45
三、手指同身寸取穴法
…… 45
中指同身寸…… 45
拇指同身寸…… 45
横指同身寸…… 45
第二节　头颈部穴位
…… 46
攒竹（天门）…… 46
坎宫（眉弓）…… 46
太阳…… 47
耳后高骨…… 48
人中…… 48
百会…… 49
天柱骨…… 49
风池…… 50
印堂…… 50
囟门…… 52
山根…… 53
准头（素髎）…… 53

牙关（颊车）…… 54
迎香…… 54
承浆…… 55
耳门（风门）…… 55
桥弓…… 56
第三节　胸腹部穴位
…… 57
天突…… 57
膻中…… 57
乳旁…… 59
乳根…… 59
中脘…… 60
腹…… 61
胁肋…… 62
天枢…… 63
脐（神阙）…… 63
丹田…… 64
肚角…… 65
气海…… 65
关元…… 66
第四节　腰背部穴位
…… 66
肩井…… 66
大椎…… 67
风门…… 68
肺俞…… 68
脾俞…… 69
胃俞…… 70
肾俞…… 70
腰俞…… 70
脊柱…… 71
七节骨…… 72
龟尾…… 72
第五节　上肢部穴位
…… 73
脾经…… 73
肝经…… 74
心经…… 75
肺经…… 75
肾经…… 76
大肠…… 76
小肠…… 78
肾顶…… 78
肾纹…… 79
掌小横纹…… 79
小横纹…… 80
四横纹…… 80
运土入水…… 80
运水入土…… 81
胃经…… 82
板门…… 82
内劳宫…… 84

内八卦…… 84
小天心…… 85
总筋…… 86
大横纹…… 86
老龙…… 87
十宣…… 87
二扇门…… 88
二人上马（上马、二马）…… 89
外劳宫…… 90
五指节…… 90
威灵…… 91
精宁…… 91
左端正…… 92
右端正…… 93
合谷…… 93
外八卦…… 94
少商…… 94
商阳…… 95
中冲…… 95
关冲…… 96
少泽…… 96
一窝风…… 97
膊阳池…… 97
曲池…… 98
洪池…… 98
肘肘…… 99
拇腮…… 99
皮罢（肝记）…… 99
甘载…… 99
三关 …… 100
天河水 …… 100
六腑 …… 101
第六节　下肢部穴位 …… 102
箕门 …… 102
膝眼 …… 102
百虫窝 …… 103
三阴交 …… 104
解溪 …… 104
足三里 …… 105
前承山 …… 105
后承山 …… 106
委中 …… 106
昆仑 …… 107
涌泉 …… 107
仆参 …… 108
第四章　常见病症治疗 …… 109
第一节　消化系统病症 …… 109
腹泻 …… 109

呕吐 …… 112
厌食 …… 113
腹痛 …… 115
疳积 …… 117
便秘 …… 119
脱肛 …… 121
痢疾 …… 122
肠梗阻 …… 124
第二节　呼吸系统病症
…… 126
咳嗽 …… 126
哮喘 …… 128
支气管肺炎 …… 130
感冒 …… 131
顿咳 …… 133
第三节　泌尿系统病症
…… 135
遗尿 …… 135
尿潴留 …… 137
第四节　伤科病症 … 138
小儿桡骨头半脱位
…… 138
小儿肌性斜颈 …… 141
臂丛神经损伤 …… 143
髋关节扭伤 …… 145
踝关节扭伤 …… 147
第五节　五官科病症
…… 152
近视 …… 152
鹅口疮 …… 155
流涎症 …… 157
牙痛 …… 158
鼻炎 …… 159
第六节　其他病症
…… 160
发热 …… 160
夜啼 …… 163
落枕 …… 165
暑热症 …… 166
佝偻病 …… 168
解颅 …… 170
惊风 …… 171
痄腮 …… 174
小儿麻痹后遗症
…… 175
麻疹 …… 178
第五章　小儿保健 …… 182
第一节　喂养与保健
…… 182
一、提倡母乳喂养
…… 182
二、人工喂养与混合

喂养 …… 183
第二节　预防接种保健
…… 184
一、目前常用计划
免疫苗 …… 185
二、对接种疫苗后发
生反应的处理
…… 186
三、预防接种应注
意的几个问题
…… 186
第三节　健脾胃保健法
…… 187
第四节　眼睛保健法
…… 187
第六章　小儿推拿歌赋选
…… 190
小儿无患歌 …… 190
认色歌 …… 190
面部五位歌 …… 191
面色图歌 …… 191
分补泄左右细详
秘旨歌 …… 192
保婴赋 …… 192
手法同异多寡宜忌
辨明秘旨歌 …… 193
用汤时宜秘旨歌 … 194
推拿代药赋 …… 194
面部推拿次第歌 … 195
认虚实二症歌 …… 195
看食指定疾诀 …… 196
推拿三字经注释 … 196
附录 …… 214
一、常用穴位表 …… 214
二、复合手法（十三
大手法）表 …… 224
三、穴位作用归类
总结 …… 225

第一章　小儿推拿的基础知识

第一节　小儿推拿简史

小儿推拿又称小儿按摩，是古代劳动人民在长期与疾病做斗争的实践中不断发展、充实起来的一门学科。早在两千多年前春秋战国时期就有《黄帝岐伯按摩十卷》。晋代《肘后备急方》记载了用小儿捏脊疗法治疗卒腹痛、疳积、积滞；掐人中治突然昏厥等。隋唐时代在太医院设有按摩科，如唐代《千金要方》中运用膏摩治疗小儿鼻塞流涕、夜啼、腹胀、不能乳食。宋代《颅囟经》问世，是我国最早的一部儿科专著。明代形成了小儿推拿的独特体系，著有《小儿按摩经》，是现存最早的一部推拿专著，还有著名的《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》等著作，在当时设立的医疗机构“太医院”中医十三科中，又再次成立了按摩科，小儿推拿理论水平不断提高，临床上已积累了丰富的治病经验。到了清代“太医院”虽不设按摩科，但由于其疗效卓著，受到人民的欢迎，因此在民间仍有较大发展，并有大量的推拿专著问世，如《小儿推拿广意》、《幼科推拿秘书》、《厘正按摩要术》等，内容丰富，理论系统。新中国成立后，在党的中医政策指引下，小儿推拿蓬勃发展，有关推拿疗法的著作、论文胜于任何时代，治疗的病症也越来越广，且疗效甚佳。该疗法在国外也倍受欢迎。

第二节　小儿推拿疗法的特点

1．治疗范围广　治疗可涉及内、外、五官、神经、骨伤科等病症，如小儿腹泻、呕吐、疳积、厌食、便秘、腹痛、脱肛、痢疾、感冒、咳嗽、哮喘、支气管肺炎、发热、遗尿、尿潴留、夜啼、肌性斜颈、落枕、桡骨小头半脱位、臂丛神经损伤、婴儿瘫后遗症、近视、鹅口疮、鼻炎、牙痛、惊风、佝偻病等方面的治疗，均有独到的效果。

2．疗效显著　小儿推拿对常见病、多发病均有较好疗效，尤其是消化道病症疗效最佳，如婴幼儿腹泻等，一般1～3次即可治愈。对小儿某些慢性病及疑难病症均有显著效果。

3．安全可靠，无副作用　小儿推拿治病，只要辨证选用穴位与手法，耐心细致操作，一般不会发生不良反应和医疗事故。

4．经济简便　小儿推拿治病，不需要复杂的医疗设备，只要技术熟练，随时随地即可治病，在城市与广大农村均可推广应用，以防治疾病。

5．患儿易于接受　小儿推拿不用服药和打针，不会给孩子带来打针服药的恐惧感，因而易被小儿所接受。

6．提高免疫能力　推拿能增强人体的白细胞及网状内皮系统细胞的吞噬功能，具有抗炎、退热、提高免疫力的作用，对小儿的生长发育带来良好的影响。因此，小儿推拿无病可防，有病可治。

第三节　小儿推拿注意事项

1．医生的手指甲必须剪修圆滑，长短适宜，以不触痛患儿皮肤为宜。

2．天气寒冷时，医者先将手搓热，待其手暖时方可操作，以防刺激患儿不能很好地合作；室内保持一定温度，不可过冷或过热，空气要流通，环境要安静，避免风吹着凉。

3．医者态度和蔼，细心耐心，认真操作。

4．推拿手法要求轻快柔和，平稳着实，即手法用力宜轻，速度宜快，均匀着力，刚柔相济。

5．推拿顺序，在临床上一般有三种方法，可根据情况灵活运用。①其顺序从人体最上部开始，依次向下按穴操作，如先推头面部穴位，依次推上肢、胸腹、背腰、下肢部穴位。②先推主穴，后推配穴。③先推配穴，后推主穴。不管采用那种方法，无论主穴、配穴，运用掐、拿、捏等强刺激手法，应最后操作，以免刺激患儿哭闹，影响操作进行和治疗效果。

6．推拿的时间。每次推拿的时间，应根据患儿年龄的大小、病情的轻重、体质的强弱而定，一般婴幼儿治疗一次，约5～10分钟；若年龄大，病变部位多（如小儿麻痹症等）时间可适当延长，但一般不超过20分钟，通常每日或隔日1次，若某些急性病如高热等，每日可推拿2次。急性病一般3～6次为一疗程；慢性病一般12次为一疗程，休息3～5天后可进行下一疗程，也可连续治疗。

7．上肢部穴位，习惯只推左侧，无男女之分，如五经穴、八卦、小天心等；其他部位一般用双穴，如太阳、迎香、乳

根、天枢、脾俞、足三里、涌泉等。

8. 治疗时需要配用一些推拿介质，其目的是润滑患儿皮肤，防止擦伤，提高治疗效果。

9. 患儿骨折、皮肤病、出血等部位一般不宜推拿，急性传染病需治疗时应注意隔离。

第四节　小儿推拿常用介质

推拿时在手上沾适量粉末或油或水，以滑润皮肤，增强手法的治疗作用，这些粉末、油和水就叫介质。推拿常用的介质有以下几种。

1. 滑石粉　即医用滑石粉，一年四季皆可用之。主要起滑润皮肤的作用。

2. 薄荷水　取少量薄荷，用水浸泡后，滤汁去渣，即可应用。夏天小儿推拿时多用之。有滑润皮肤，清热解表的作用。

3. 姜水　把生姜捣烂，滤汁去渣，然后加入适量的水，便可应用，冬春季节多用之。有滑润皮肤，温阳散寒，发汗解表的作用。

4. 葱水　取葱白切碎，用适量酒精浸泡 24 小时后，滤汁去渣，即可应用，多在冬春季节用之。有滑润皮肤，散寒解表之作用。

5. 鸡蛋清　取鸡蛋 1 个，打一小洞，取其蛋清使用。有润滑皮肤、清热之作用。

6. 麻油（即芝麻油）　它是古代常用的润滑剂，我国民间多用于刮法推拿中。有滑润皮肤，温通经络的作用。

7. 冬青油　是醛类有机溶剂。产热力强，且较深透。也可将冬青油与凡士林、薄荷油等配成混合液，又称冬绿膏，常用比例如表 1。

表 1　　冬绿膏的配制比例

名　　称	冬　　天	夏　　天
冬青油	17%	15%
薄荷脑（油）	3%	5%
凡士林	80%	80%

第五节　小儿生长发育特点

生长发育是小儿时期不同于成人的最根本的生理特点。一般“生长”表示身体形态的增长；“发育”表示组织器官功能活动的进展。二者相互关联，故称为生长发育。因此，掌握有关生长发育的基本规律，熟悉健康小儿的正常标准，对于小儿疾病的防治与保健具有重要意义。

一、年 龄 分 期

1. 胎儿期　从受孕到分娩约 40 周，称胎儿期。孕期 28 周到出生 7 天止则称为围产期，这个时期关系着胎儿能否健康发育至成人的重要阶段，也就是先天禀气足与不足的阶段。此期应当注意胎教、护胎和养胎，所以孕妇要保证足够的休息时间和丰富的营养，孕期要心情舒畅，夫妻生活和谐。还要注意孕期卫生与防止得病，即使得了病也要忌服对胎儿有不良影响的药物，以防胎儿畸形。

2. 新生儿期（出生～满月）　胎儿离开母体由胎内生活转为胎外生活，主要特点是：

（1）中枢神经系统发育尚未完善，大脑皮层兴奋性较低，除吮乳时间外，几乎整日睡眠。

（2）各器官从组织结构到功能均未发育完善，体温调节能力差，易受外界温度影响。

（3）从母体获得部分免疫，对某些疾病如麻疹、脊髓灰质炎、白喉等有先天免疫；而后天免疫机能尚未形成，故防御力低，炎症易扩散。

（4）新生儿期有特殊生理状态，如生后2～3天出现生理性黄疸；5天左右出现乳腺肿大，以8～10天最为明显，有的还分泌少量乳汁，男孩女孩皆可出现，乳房肿胀可在2～3周内渐渐消退，有的延长1～1个半月降至正常；女孩出生1周左右可能会出现假月经或白带，此为生理现象，几天后会自然消失。有的新生儿在牙龈或上颚中线上长有黄白色的韧性颗粒，微微隆起，大小像芝麻粒，民间称为“马牙”，此由上皮细胞堆积而形成，一般2～3周后会自行消退，千万不可自行处理，以免引起感染。脐带结扎后，一般5～10天内脱落。若脐凹处潮湿或有分泌物时，应撒些消毒的滑石粉或用10%龙胆紫溶液涂患处，约2周左右脐带即可完全长好。

3. 婴儿期（满月～1周岁）　此期小儿生长发育迅速，代谢旺盛，其特点为：

（1）运动机能（如抬头、翻身等）发育很快，条件反射逐渐形成。

（2）各器官组织结构渐趋完善，但功能尚未成熟，如高热量的营养需要与不成熟的消化功能处于矛盾的统一状态，此期

消化功能有一定适应能力，但又处于紧张状态，故易引起消化营养紊乱。

（3）从母体获得的先天免疫逐渐消失（5～6个月），而后天免疫才开始形成但未健全。

（4）神经系统发育尚不完善，对于高热、毒素等耐受性和调节功能较差，易发生高热惊厥和中毒性脑病。

4．幼儿期（1～3周岁）　此期发育较慢于婴儿期，其特点为：

（1）开始行走，活动范围扩大，易招致外伤。

（2）与周围环境接触增多，丰富了许多概念，促进了语言思维的发育。

（3）营养的需要不断提高，此期乳齿已长出，对食物的质和量提出了新的要求。随着断乳和食物的急剧变更，消化和营养紊乱仍为常见疾病。

（4）在与外界的接触过程中，虽然提供了建立自动免疫的条件，但亦增加了感染的机会，故呼吸感染与急性传染病的发病率较高。

5．学龄前期（又称幼童期，3～7周岁）　此期体格发育减慢而智力发育增快。其特点为：

（1）能用语言表达自己的思想和要求；求知欲强；好提问题；模仿性强；记忆力与理解力逐渐增强。

（2）炎症易于局限，疾病的经过渐接近成人，可见大叶肺炎，出现变态反应性疾病如风湿病、肾炎、过敏性紫癜等。

（3）因小儿活动范围广，接触传染病的机会多，故易发生传染病。

6．学龄期（又称儿童期，7～12周岁）

(1) 此期开始上学，与社会接触增多，因此应注重对儿童德、智、体三方面的教育。

(2) 乳齿开始更换为恒牙，身体各器官组织发育日趋完善，对疾病的抵抗力增强，急性传染病逐渐减少。

(3) 疾病性质与表现接近成人，如变态反应性疾病增多。

二、生 理 常 数

生理常数是根据健康小儿生长发育规律总结出的标准。凡符合标准者，为健康小儿；反之则显示小儿患有某种疾病并影响正常发育。

1. 体重　体重可以推测小儿的营养状况。体重在婴儿期增长迅速，而同龄小儿的体重在正常情况下，允许有个体差异的±10%的波动，测定体重最好在清晨空腹排尿后进行。

新生儿体重平均为3公斤，低于2.5公斤称为未成熟儿，出生后3个月体重增长最快，以后随着年龄的增长而逐渐减慢，各阶段的年龄体重，可按下列公式计算：

1～3个月：体重(公斤)＝月龄×0.7＋3；

4～6个月：体重(公斤)＝月龄×0.6＋3；

7～12个月：体重(公斤)＝月龄×0.5＋3；

1岁以上：体重(公斤)＝年龄×2＋8。

2. 身长　身长是反映骨骼系统发育的重要标志。身高的显著异常都表示小儿在患病，应引起重视。

新生儿身长约50厘米，出生后第1年增长25厘米，第2年约增10厘米，2岁以上每年平均增长5厘米，一般2岁后身长可用下列公式推算：

身长(厘米)＝周岁数×5＋75

一般低于正常的30%以上为异常，多见于侏儒症、佝偻病、糖尿病、呆小病、营养紊乱及某些先天性疾病。

3. 头围与囟门　新生儿的头围约34厘米，比胸围大1～2厘米，随着脑的发育，头围在初生后半年增长约8厘米，后半年增长4厘米，2～5岁每年增长1厘米，以后每2年增长1厘米，7岁时达51厘米，已接近成人。过小常为脑发育不全、头小畸形等，过大可能为解颅、脑积水等疾病。

后囟门一般于生后3～4个月闭合，前囟门呈菱形，至1～1.5岁闭合（图1）。囟门早闭且头围明显小于正常者，为小头畸形。囟门闭迟及头围大于正常者，见于解颅或佝偻病。

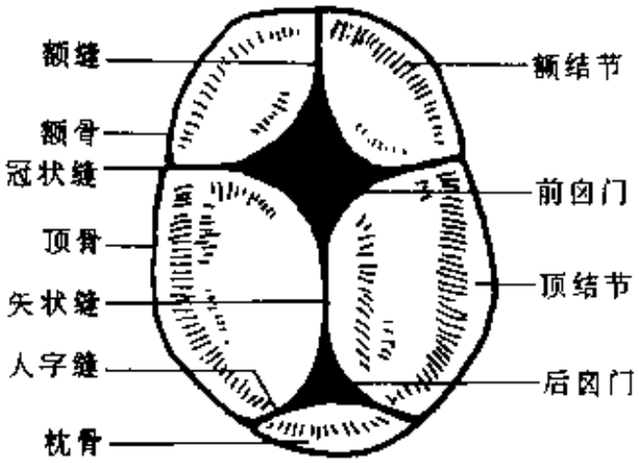

图1　小儿囟门上面观

4. 胸围　胸围出生时约32厘米，第1年增长约12厘米，第2年增长约3厘米。1岁内胸围常小于头围，1岁时几乎相等，2岁以后胸围超过头围。佝偻病和营养不良者则胸围较小。

5. 牙齿　小儿出生后5～10个月开始出乳牙，亦有早在4个月、晚至11个月出牙者，均属于正常范围。若出牙过晚，

多见于佝偻病患儿。一般于20～30个月出齐20颗乳牙，6～7岁乳齿开始脱落换为恒牙，6～24个月正常小儿的牙齿数可用下列公式计算：

牙齿数＝月龄－4（或6）。

6．呼吸、脉搏和血压

（1）呼吸　年龄越小，呼吸越快。1～3个月每分钟约45～60次；4～6个月每分钟约35～40次；6～12个月每分钟30～35次；1～3岁每分钟25～30次。

（2）脉搏　年龄愈小，脉搏愈快。1岁以内每分钟约120～160次；1～3岁每分钟约100～120次；3～5岁每分钟约90～100次；5～7岁每分钟约80～100次；7～12岁每分钟约70～90次。

（3）血压　年龄越小，血压越低。1岁以上小儿收缩压可按下列公式计算。

年龄×2＋10.7千帕（80毫米汞柱），舒张压约为收缩压的1/2～2/3。

7．运动、语言和智力的发育　小儿出生后仅有无条件反射（觅食、吞咽、吸吮等）和不自主活动。运动、语言、智力的发育是伴随着神经、骨骼、肌肉和各器官的发育，以及与外界事物不断的反复多次的接触而发展起来的，它是按着一定的规律即由上到下，由近及远，从不协调到协调，由低级到高级而逐渐发育的。民间谚语中把小儿运动和语言、智力的发育概括为："一哭二笑三认母，二抬四翻六能坐，七滚八爬周会走，四抓八语周逗人。"真实地反映出小儿的运动、语言、智力的发育规律（表2，图2）。

图2 婴幼儿运动、语言和智力的发育

表 2　　运动、语言和智力的发展规律

1 个月	无规律的动作。俯卧时试着要抬头，无意识的微笑
2～3 个月	抬头、俯卧时用肘支起前半身，能寻找声音的方向；两眼随光转移，能认母亲
4～5 个月	扶坐，翻身，会玩手及注视周围。"咿呀"作声，有意识的笑
6～7 个月	独坐，扶着两臂可站立，能抓玩具，能识别亲人与陌生人
8～9 个月	会爬，自己扶站，会拿小东西。无意识地发出"爸"、"妈"单音，听懂自己的名字
10～12 个月	独站，能弯腰捡东西，扶着会走。能用单词表达意思如"吃"、"要"等等
1～1.5 岁	独走，学跑，会蹲着玩，会拿匙吃饭但不准确
2～3 岁	会跑。能说短语，开始学着唱歌，白天能控制小便
3～4 岁	会跑，会跳，能自己穿衣、洗脸。好发问，能与成人对话，会唱短歌
5～6 岁	会做一些简单的劳动（如打地、擦桌子等）、会唱歌、会讲故事，学认字，能数几十个数

第二章　小儿推拿手法

第一节　单 式 手 法

直　推　法

【部位与操作】　用食、中指腹（图 3），或拇指桡侧或指腹（图 4）在穴位上做直线推动 100～300 次。操作时宜轻快柔和，平稳着实，不要用力按压穴位。

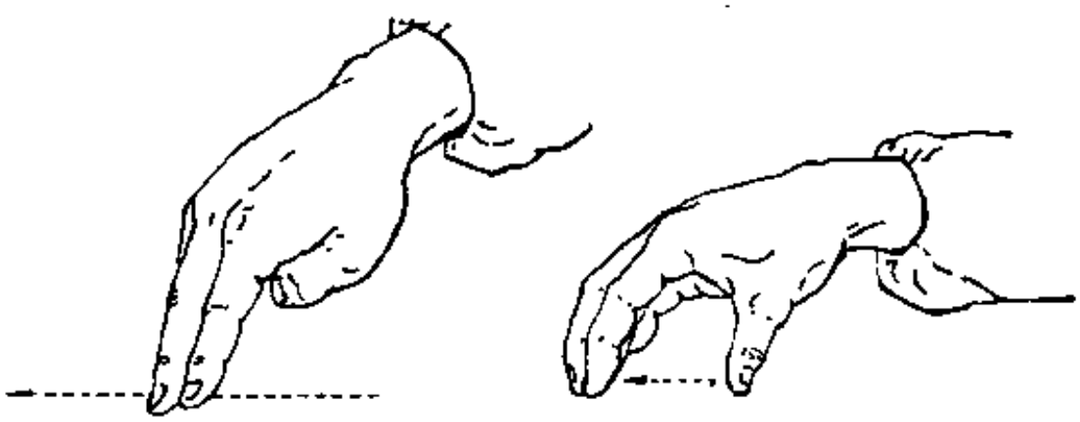

图 3　食、中指腹直推法　　图 4　拇指桡侧直推法

【作用与主治】　具有疏通经络、益气活血、调整脾胃、清热利尿等作用。主治腹泻、便秘、食欲不振、腹胀、呕吐、发热、头痛、咳嗽、小便短赤不利等病症。

分 推 法

【部位与操作】 用两手拇指桡侧或指腹，自穴位向两旁做分向推动（图 5），或做“Λ”形推动 50～100 次。

【作用与主治】 有降肺胃之气、调阴阳、止头痛等作用。主治咳嗽、哮喘、支气管炎、恶心、呕吐、寒热往来、感冒头痛等病症。

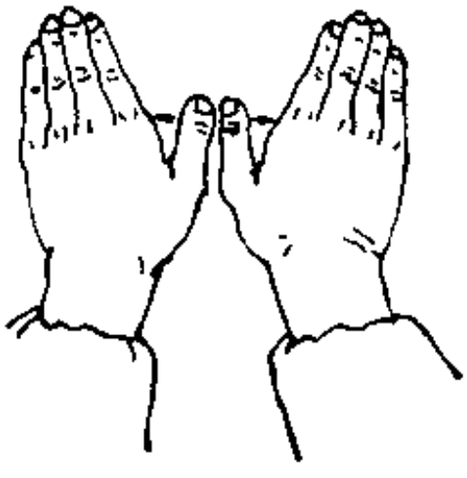

图 5 分推法

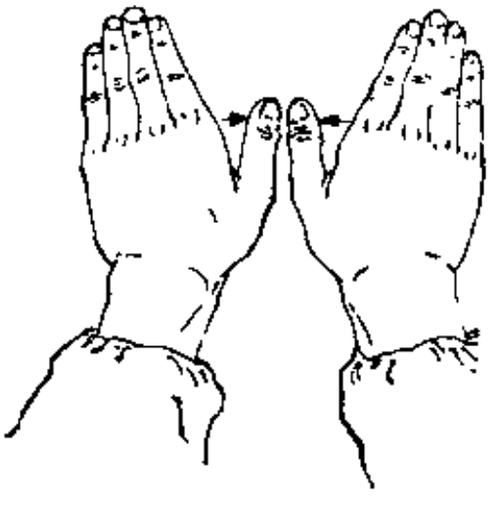

图 6 合推法

合 推 法

【部位与操作】 用两拇指腹或桡侧自穴位两旁向穴中间推（图 6）50～100 次。此法操作方向与分推法相反。

【作用与主治】 有行痰散结、宣肺理气等作用。主治痰结喘嗽、痰涎壅盛、胸闷不舒等病症。

指 摩 法

【部位与操作】 用一手食、中、无名和小指腹，附着于

腹部做环形运动（图 7）。本法主要用于腹部及胸部，多用于新生儿及婴儿期患儿。一般操作 50～100 次。

【作用与主治】　具有消食化滞、健脾止泻等作用。主治消化不良、腹胀、腹痛、厌食、腹泻、便秘等病症。

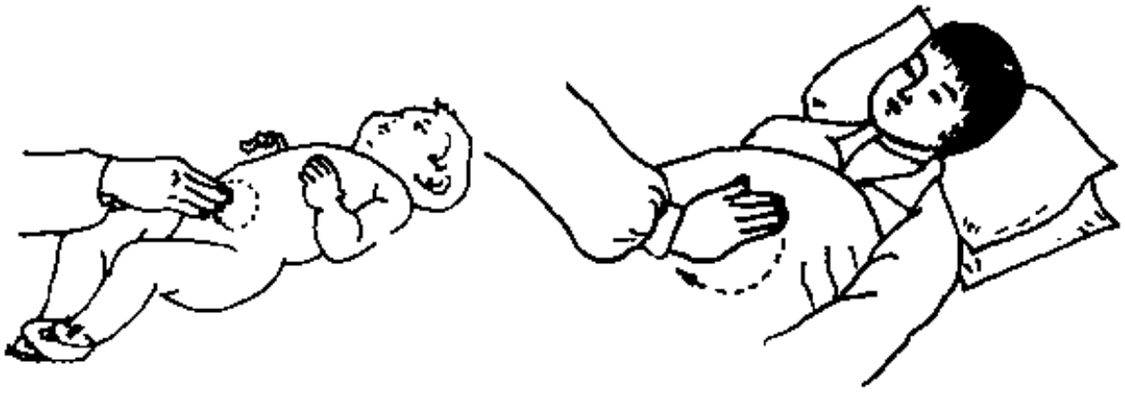

图 7　指摩法　　图 8　掌摩法

掌　摩　法

【部位与操作】　用掌面附着于一定部位，以腕关节为中心，连同前臂做节律性的环旋运动（图 8）。本法多用于幼童期患儿，多用于腹部及胸部。一般操作 100～300 次或每分钟 120 次左右。

【作用与主治】　具有调节胃肠蠕动、和中理气、消积导滞等作用。主治食积胀满、脘腹疼痛、疳积、气滞及胸胁屏伤等病症。

拿　法

【部位与操作】　用拇指与食、中指（图 9），或拇指与其

余四指（图 10）相对用力，在一定部位或穴位上进行有规律的提捏动作，称拿法。用于颈项、肩、四肢部时，一般操作 1～2 分钟；用于穴位时，一般拿 3～5 下。

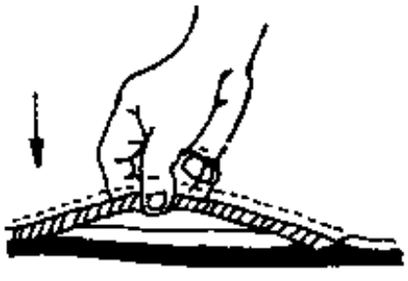

图 9　拇指与食、中指拿法

图 10　拇指与四指拿法

【作用与主治】　具有祛风散寒、舒筋通络、行气活血、开窍止痛等作用。主治感冒、颈项僵硬、背痛、四肢关节酸痛、麻木不仁、婴儿瘫后遗症、惊风抽搐等病症。

掐　法

【部位与操作】　用拇指甲重刺穴位，称掐法（图 11）。操作时手握空拳，伸直拇指，以拇指甲逐渐用力，垂直掐压穴位，注意不要掐破皮肤，掐后轻揉局部，以缓解不适之感。一般掐 3～5 下。

【作用与主治】　本法为强刺激手法之一，多用于急救。具有开窍醒神、定惊等作用。主治惊风抽搐、不省人事、窒息、惊厥等症。

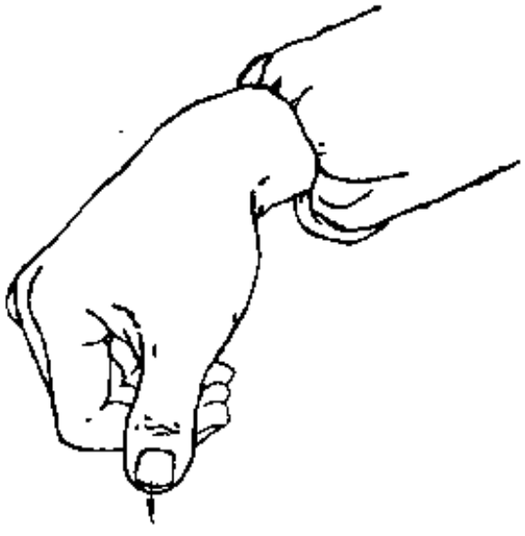

图 11　掐法

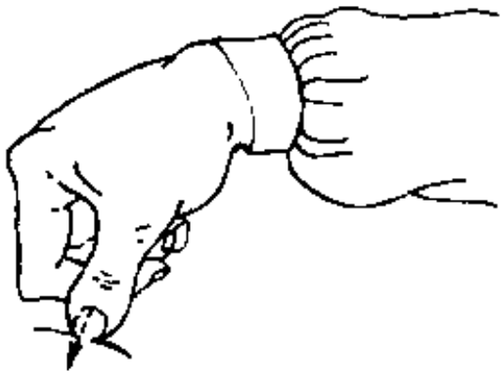

图 12　指按法

指　按　法

【部位与操作】　用拇指端或指腹按压体表、穴位，称指按法（图 12）。操作时着力部位要紧贴体表，用力由轻到重，不可突然暴力按压。一般施术半分钟。

【作用与主治】　具有通经活络、开通闭塞、放松肌肉、活血止痛之作用。主治头痛、胃脘痛、腰背痛、肢体酸痛等各种痛症。

指　揉　法

【部位与操作】　用中指端揉穴位，称中指揉法（图 13）。用拇指端揉穴位，称拇指揉法（图 14）。操作时用力宜轻柔，均匀着实，以腕关节和掌指关节为主，带动指端做顺时针或逆时针方向旋转运动，操作时使指下的皮下组织随着揉动而产生温热感。一般施术 30～50 次。

图 13　中指揉法

图 14　拇指揉法

【作用与主治】　本法具有祛风解表、理气消食、舒筋活络、活血止痛等作用。主治感冒头痛、腹胀腹痛、泄泻呕吐、颈项痛及胸背、四肢部疼痛与麻木不仁等病症。

大鱼际揉法

【部位与操作】　用手掌大鱼际附着于一定部位，做轻柔缓和的摆动，称大鱼际揉法（图 15）。操作时腕关节放松，以肘为支点，前臂做主动摆动，施术 1～2 分钟。

【作用与主治】　有理气消食化滞、活血祛瘀、消肿止痛等作用。主治脘腹胀痛、便秘、腹泻、头痛、头晕及外伤所致的红肿疼痛等症。

掌 根 揉 法

【部位与操作】　用掌根吸着于一定部位或穴位，以腕关节连同前臂做回旋运动，称掌根揉法（图 16）。腕关节放松，以肘为支点，腕部做主动摆动，用力先轻后重。常用于腰背及

下肢部。施术2～3分钟。

图15　大鱼际揉法

图16　掌根揉法

【作用与主治】　本法具有舒筋活血、通络止痛、放松肌肉、解除疲劳等作用。主治腰痛、背痛、肩痛、四肢酸痛、肢体麻木等症。

运　法

【部位与操作】　用拇指或中指端在一定穴位上，由此往彼做弧形或环形推动，称运法(图17)。操作时宜轻不宜重，宜缓不宜急，在体表旋绕摩擦推动，不带动深层肌肉组织。频率一般每分钟80～120次。

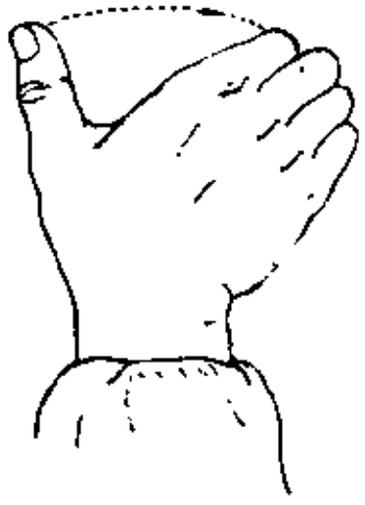

图17　运法

【作用与主治】　有疏通经络、止咳化痰、行滞消食、调整脾胃功能等作用。主治咳喘痰多、胸闷胸痛、腹痛腹胀、泄泻呕吐、食欲不振、发热、盗汗、惊惕不安等症。

捏　法

【部位与操作】　用拇指桡侧缘顶住皮肤，食、中指前按，三指同时用力提拿皮肤〔图 18 (1)〕，双手交替捻动向前〔图 19 (2)〕。或食指屈曲，用食指中节桡侧顶住皮肤，拇指前按，两指同时用力提拿皮肤，双手交替捻动向前〔图 20 (3)〕。操作时捏起皮肤多少及提拿用力大小要适当，不可拧转。捏得太少，不容易提起皮肤，捏多了则不易向前捻动推进，捻动向前时，需直线前进，不可歪斜。一般捏 3～5 遍。

图 18　捏法(1)

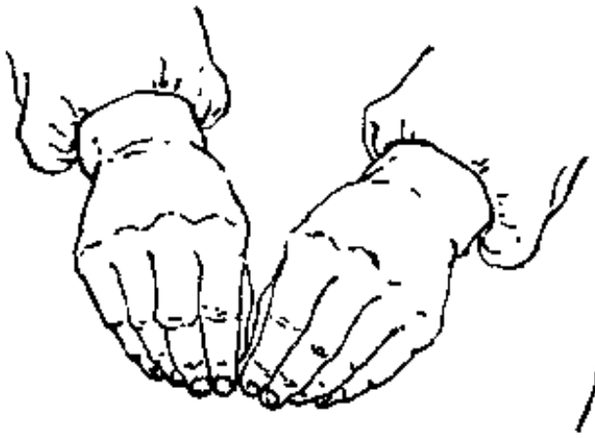

图 19　捏法(2)

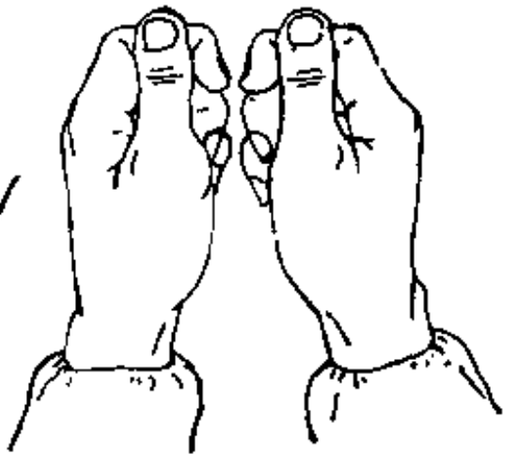

图 20　捏法(3)

【作用与主治】　具有通经络、培元气、调阴阳、和脏腑、壮身体等作用。主治先、后天不足的一切慢性虚弱病症，如肾虚遗尿、脾虚腹泻、惊风、疳积、呕吐、腹痛、夜啼、便秘等症。

捣　法

【部位与操作】　用中指端，或屈曲的食、中指的指间关节着力，做有节奏地叩击穴位，称捣法（图 21）。捣击时指端富有弹性，击后立即抬起。一般捣 5～20 次。

【作用与主治】　有镇惊安神、通络明目等作用。主治夜啼、烦躁不安、惊风眼翻、斜视等病症。

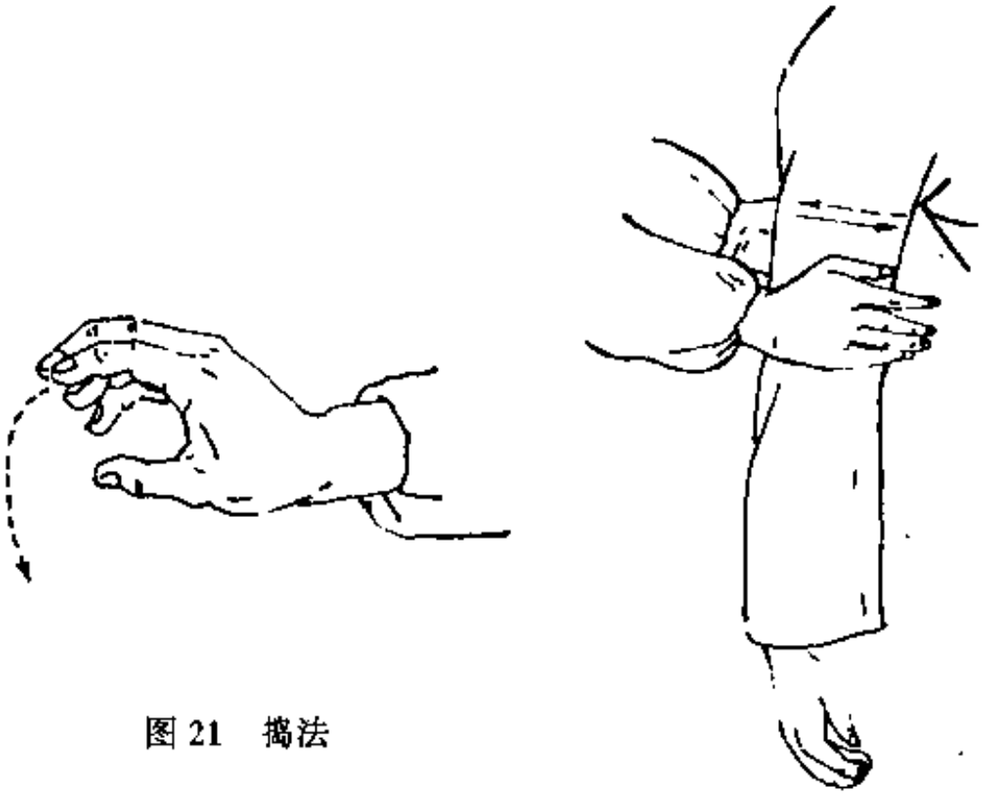

图 21　捣法

图 22　搓法

搓　法

【部位与操作】　用双手掌面挟住一定部位，相对用力做快速搓揉，同时做上下往返移动，称搓法（图 22）。操作时双手对称用力，搓动要快，移动要慢。一般操作 1～2 遍。

【作用与主治】　有舒筋通络、调和气血、放松肌肉的作用。主用于四肢，两胁肋部。治疗四肢关节痹痛、麻木不仁等症。常作为推拿治疗的结束手法。

擦　法

【部位与操作】　用手掌面附着于胸背部进行直线来回摩擦，称掌擦法（图 23）。用手掌大鱼际擦之，称大鱼际擦法（图 24）。用小鱼际擦之，称小鱼际擦法（图 25）。操作时着力部位要紧贴皮肤，压力不要太大，用力要稳，动作均匀连续，自然呼吸，不宜屏气；不论上下还是左右方向擦，都应直线往返，不可歪斜，往返距离要拉得长些；操作的部位要裸露，涂适量介质（如按摩乳等），以免擦破皮肤。一般使局部透热为佳。

【作用与主治】　具有温经通络、行气活血、消肿止痛、健脾和胃、提高局部温度、扩张血管、加速血液与淋巴液循环的作用。掌擦法主治胸胁及腹部病症，如脾胃虚寒所致的腹痛、消化不良等。大鱼际擦法主治上下肢、胸腹、背部病症，如外伤瘀血、红肿疼痛等症。小鱼际擦法主治腰背及下肢部病症，如风湿酸痛、麻木不仁、肢体伤筋等。三种方法可以配合变化使用，不可拘泥。

图 23　掌擦法

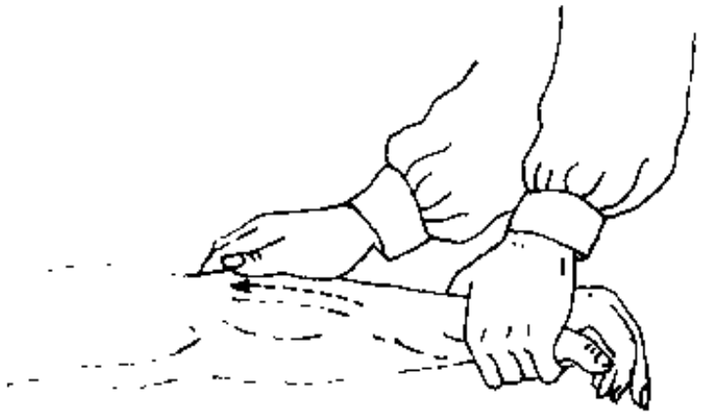

图 24　大鱼际擦法

图 25　小鱼际擦法

挤　捏　法

【部位与操作】　医者以两手拇、食指在选定的部位或穴

位处，固定捏住，然后使两手拇、食指一齐用力向里挤，再放松，反复操作，使局部皮肤变为红色或紫红色，甚至紫黑色为度，称挤捏法(图 26)。操作时两手捏住的皮肤要着实，动作要灵活，两手相距 1 厘米左右再向里挤。

图 26　挤捏法

【作用与主治】　有散发郁热、化痰、消积之作用。主治中暑、乳蛾肿胀、恶心呕吐及痰涎壅盛等病症。

摇　法

【部位与操作】　一手托扶关节近端，另一手扶其远端，做环转运动，称为摇法(图 27)。若一手扶住患儿头顶后部，另一手托住下颏，做向左或向右环转摇动，称颈项部摇法(图 28)。

图 27　摇法

图 28　颈项部摇法

【作用与主治】　有疏通经络、滑利关节、松解粘连、促使关节功能恢复的作用。主治关节疼痛、肿胀、活动障碍等症。

捻　法

【部位与操作】　用拇、食指螺纹面捏住一定部位，做对称搓揉动作，称为捻法（图29）。操作时拇、食指腹相对用力，捻动时要灵活，用劲不可呆滞。一般操作0.5～1分钟。

图29　捻法

【作用与主治】本法具有滑利关节、消肿止痛、舒筋活络之作用。常用于手（足）指（趾）小关节。主治指（趾）间关节扭挫伤而引起的疼痛、肿胀或屈伸不利等症。

扯　法

【部位与操作】　医者用一手拇、食指端捏住皮肤〔图30（1）〕，或食、中指中节夹住皮肤〔图31（2）〕，用力做一拉一放动作，至局部红紫为度。

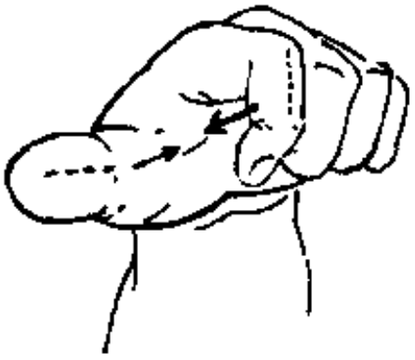

图30　扯法(1)

图31　扯法(2)

【作用与主治】　有解表祛邪、通经活络的作用。主治外感风热引起的头痛、目赤痛、中暑等症。根据不同的病情在印堂、鱼腰、天突、大椎等部位使用本法。

㨰　法

【部位与操作】　用手背近小指侧部或中指、无名指、小指的掌指关节部，附着于患儿体表一定部位，通过腕关节的屈伸运动和前臂的旋转运动复合而成〔图 32（1）、33（2）、34（3）、35（4）〕。操作时肩臂放松，肘关节微屈约 120°，以肘为支点，前臂做主动摆动；吸定部位要紧贴体表，不能跳动或拖动；压力、频率、摆动幅度要均匀、协调而有规律。一般每分钟施术 120～160 次。

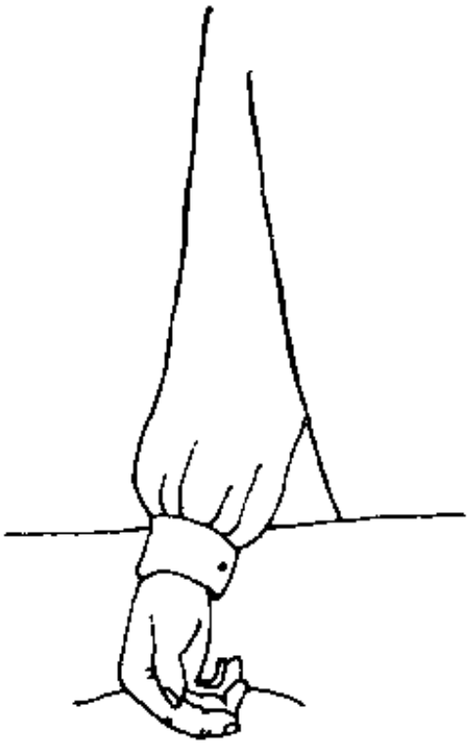

图 32　㨰法(1)

图 33　㨰法(2)

图 34　㨰法(3)

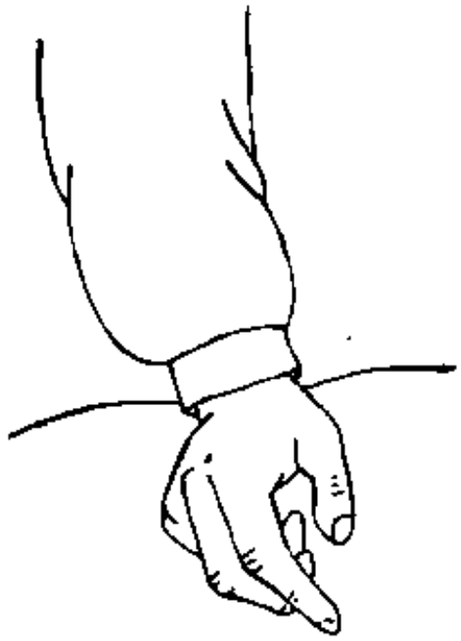

图 35　㨰法(4)

【作用与主治】　有舒筋活络、滑利关节、放松肌肉、促使血液循环、缓解肌肉韧带痉挛、增强肌肉韧带活动能力及解除疲劳等作用。常用于颈、肩、腰背及四肢部。主治肩背颈腰臀及四肢等部位的风湿肌肉酸痛、麻木不仁、婴儿瘫后遗症、肢体瘫痪、运动功能障碍等病症。

小　㨰　法

【部位与操作】　手握空拳，用手背小指、无名指、中指、食指第二指间关节突出部在体表来回㨰动，称为小㨰法（图36）。操作时腕关节放松，腕关节主动做屈伸摆动，压力、频率要均匀，每分钟约 120～160 次。

【作用与主治】　具有舒筋活血、放松肌肉、促使血液循环的作用。主治儿童期颈肩、腰背及四肢等部位的风湿酸痛、麻木不仁、肢体瘫痪等症。

图 36　小滚法

图 37　刮法

刮　　法

【部位与操作】　用拇指桡侧缘或食、中指腹或用器具的光滑边缘（如汤匙等），用力向一个方向推动（图 37），形似直推法，但较直推法用力较重。操作时可蘸汤水、油类，以润滑皮肤，避免破皮。一般刮至皮下瘀滞充血或皮肤红紫色为度。

【作用与主治】　有清热凉血、消积导滞、降逆止呕、活血散结的作用。多用于颈项部、脊柱两侧、腹部、上肢肘弯、下肢腘窝部位。主治高热中暑、外感发热、腹泻呕吐、胸闷等病症。

拍　　法

【部位与操作】　用虚掌拍打体表，称拍法（图 38）。操作时手指自然并拢，掌指关节微屈，平稳有节奏地拍打患处。局部充血为度。

【作用与主治】　具有舒筋活络、行气活血的作用。多用于肩背、腰臀及下肢部。主治风湿酸痛、局部感觉迟顿、肌肉痉挛等症。

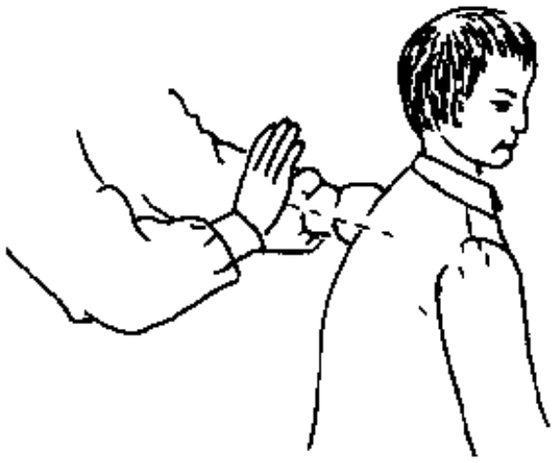

图 38　拍法

第二节　复 合 手 法

打马过天河

【部位与操作】　医者先用右手中指运内劳宫，然后屈患儿四指向上，以左手握住，再以食、中二指顶端自总筋、内关、间使，循天河向上一起一落地打至洪池为一次（图 39），或食、中二指由内关起，循天河弹到洪池。一般打 10～20 次。

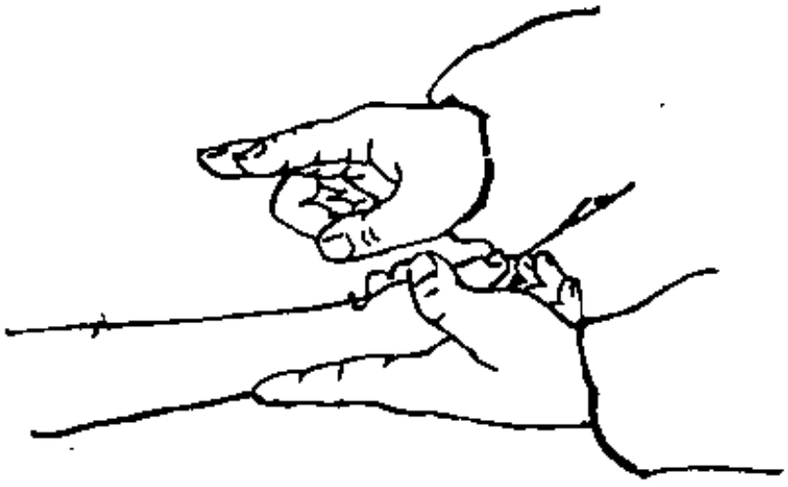

图 39　打马过天河

【作用与主治】　有清热、通经络、行气血的作用。主治高热神昏、发热恶寒、上肢麻木、抽搐、谵语等实热病症。

黄蜂入洞

【部位与操作】　医者以左手扶患儿头部，右手食、中二指轻入患儿鼻孔揉之，20～50次（图40）。

【作用与主治】　有宣肺通鼻窍、发汗解表的作用。主治外感风寒、鼻塞不通、发热无汗、急慢性鼻炎、鼻塞流涕等病症。

图40　黄蜂入洞

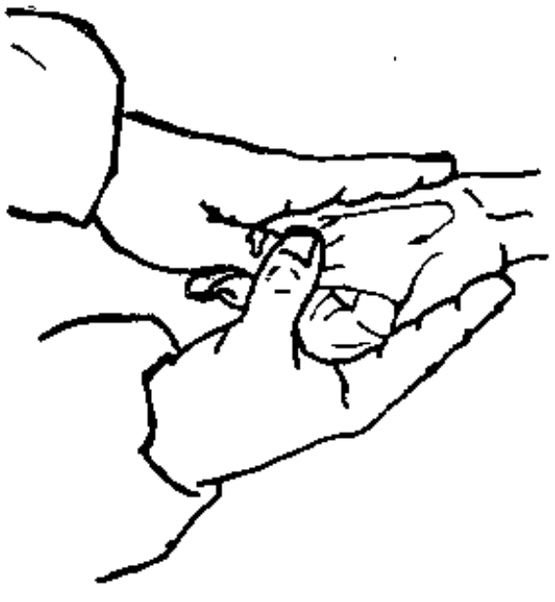

图41　水底捞月

水底捞月

【部位与操作】　医者以左手持患儿的四指；再以右手食、中二指固定患儿的拇指，然后用拇指自患儿小指根运至小天心处，再转入内劳宫为一遍。一般运20～50遍（图41）。

【作用与主治】　具有清热凉血、宁心除烦的作用。主治高热神昏、烦躁不安、口渴、衄血、热入营血的高热实症等。虚热症勿用。

按弦走搓摩

【部位与操作】　患儿取坐位。医者位于其前侧或身后，用双手掌从患儿两胁处自上而下搓摩至天枢处，50～100 次（图 42）。

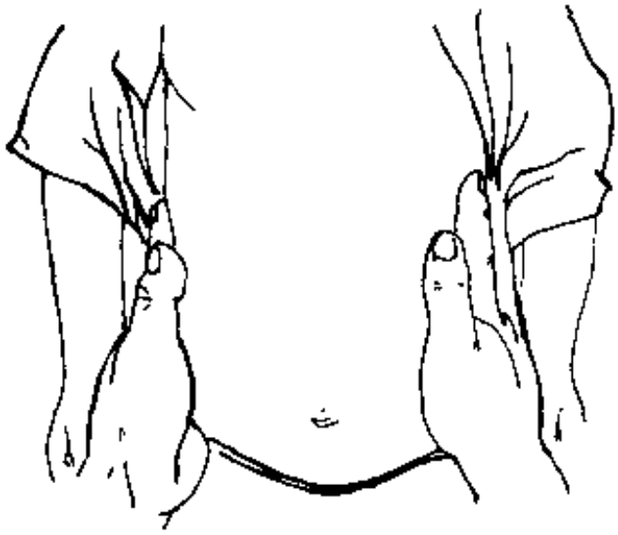

图 42　按弦走搓摩

【作用与主治】　具有顺气化痰、除胸闷、开积聚之作用。主治积痰积滞引起的胸闷不畅、咳嗽气急、痰喘积聚等症。

猿 猴 摘 果

【部位与操作】　患儿取坐位。医者以两手食、中二指夹住患儿两耳尖向上提 10～20 次，再捏两耳垂向下扯 10～20 次，如猿猴摘果之状（图 43）。

图 43　猿猴摘果

【作用与主治】　有健脾理气和胃、镇惊安神的作用。主治痰涎壅盛、食积、寒疾、疟疾、寒热往来等症。

按肩井（总收法）

【部位与操作】　患儿取坐位。医者以左手中指掐按患儿之肩井穴（在大椎与肩峰连线的中点，属足少阳胆经），再以右手拇、食、中三指紧拿患儿之食指与无名指，使患儿的上肢伸直摇之。摇 20～30 次（图 44）。

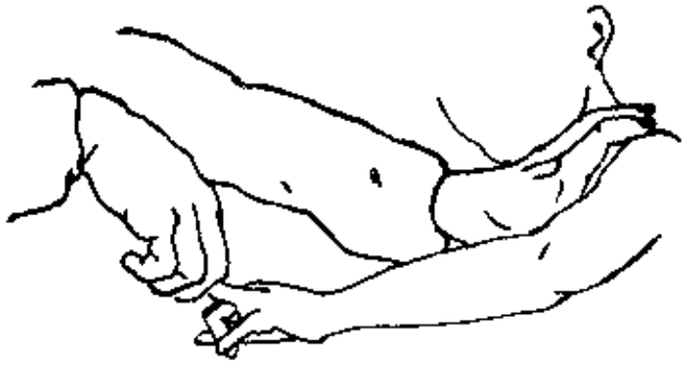

图 44　按肩井（总收法）

【作用与主治】　有通行一身之气血的作用。诸症推毕，均宜此法收之。主治感冒、昏厥、肩背疼痛、上肢活动欠利等病症。

摇 肘 肘

【部位与操作】　医者先以左手拇、食、中三指托患儿之肘肘，再以右手拇、食二指叉入虎口，同时用中指按定天门（兑、宫）穴，然后屈患儿之手上下摇之。一般摇 20～30 下（图 45）。

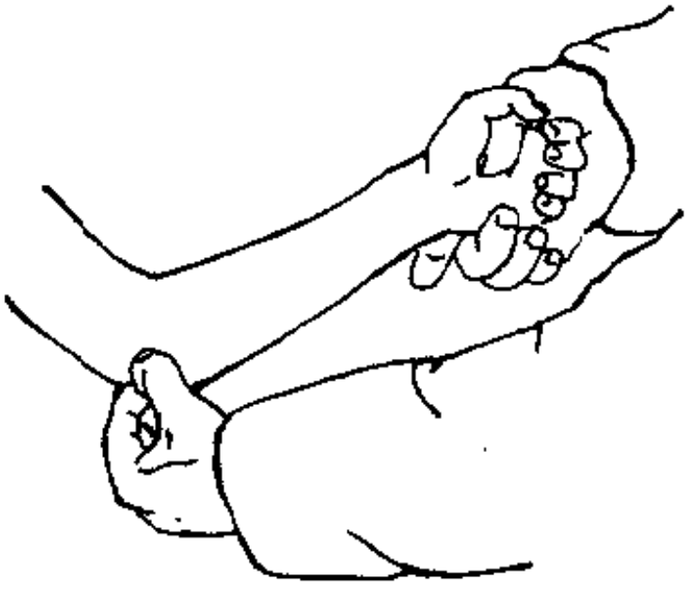

图 45　摇肘肘

【作用与主治】　有行气活血、通经活络之作用。主治痞块、疳积等病症。

飞 经 走 气

【部位与操作】　医者先用右手握住患儿左手四指，再用左手四指从曲池起，按之、跳之，至总筋处数次（图 46

(1)]。再以左手拇、中二指拿住患儿的阴池、阳池二穴不动，然后右手将患儿左手四指向上向外，一伸一屈，连续搓 20～50 次 [图 47 (2)]。

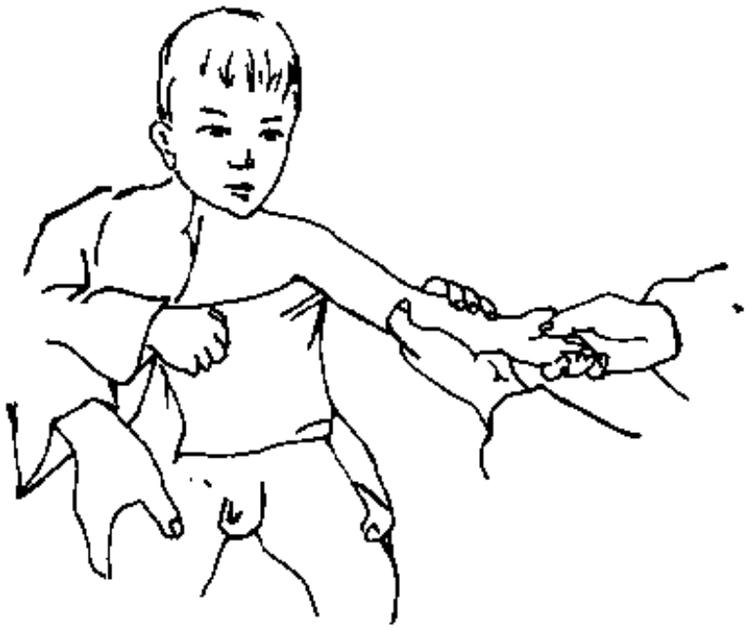

图 46　飞经走气 (1)

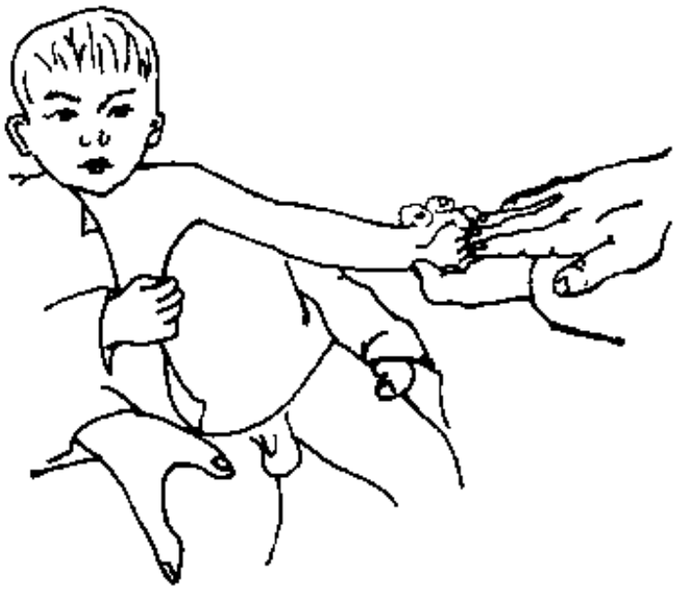

图 47　飞经走气 (2)

【作用与主治】　有行一身之气，清肺、化痰等作用。主治肺热咳喘，痰多胸闷及腹胀腹痛等病症。

二龙戏珠

【部位与操作】　医者以左手持患儿之手，使掌心向上，前臂伸直，右手食、中二指自患儿总筋处起，以指端交互向前按之，直至曲池为一遍（图 48）。按 20～30 遍。

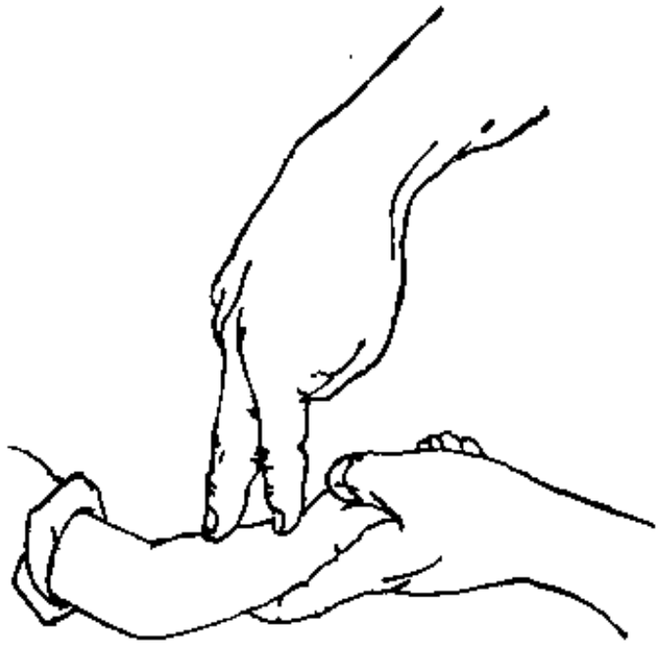

图 48　二龙戏珠

【作用与主治】　有镇惊定搐、调和气血的作用。该法性温和，能调理阴阳，通阳散寒，又能退热镇惊。主治四肢抽搐、惊厥等症。

苍龙摆尾

【部位与操作】　医者用左手托患儿的肘肘，右手握患儿食、中、无名、小指，左右摇动如摆尾之状(图 49)。一般摇 20～30 下。

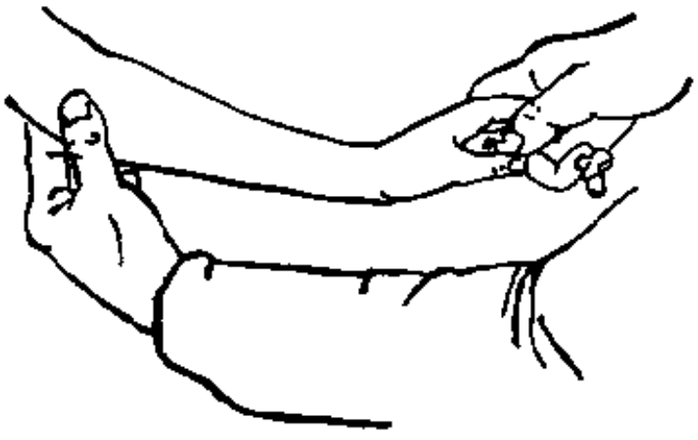

图 49　苍龙摆尾

【作用与主治】　具有退热、开胸、通便之作用。主治发热、烦躁不安。

揉脐及龟尾并推七节骨

【部位与操作】　患儿仰卧，医者一手揉脐，另一手揉龟尾（图 50）各 50 次；然后令患儿俯卧位，医者自龟尾推至七节骨为补，反之为泻（图 51），各 200 次。

图 50　揉脐及龟尾

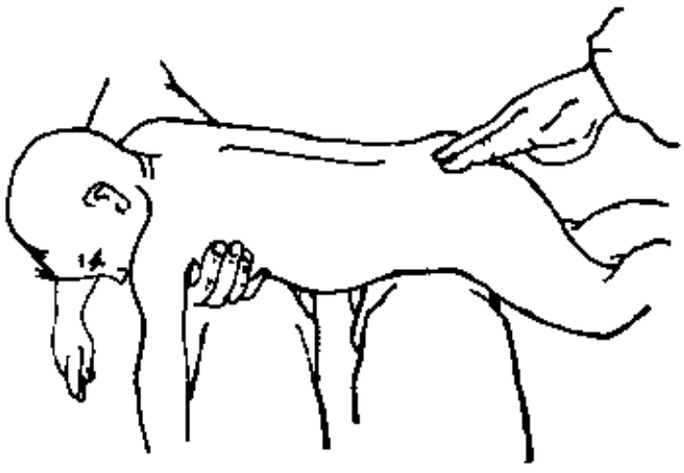

图 51　推七节骨

【作用与主治】有止泻止痢、升举阳气之作用。主治腹泻、痢疾、脱肛等病症。若治赤白痢疾，必先泻后补，首先去大肠热毒，然后方可补之。

赤 凤 点 头

【部位与操作】　医者左手托患儿的肘肘，右手捏患儿中指上下摇摆之，如赤凤点头状（图 52）。一般摇摆 20～30 下。

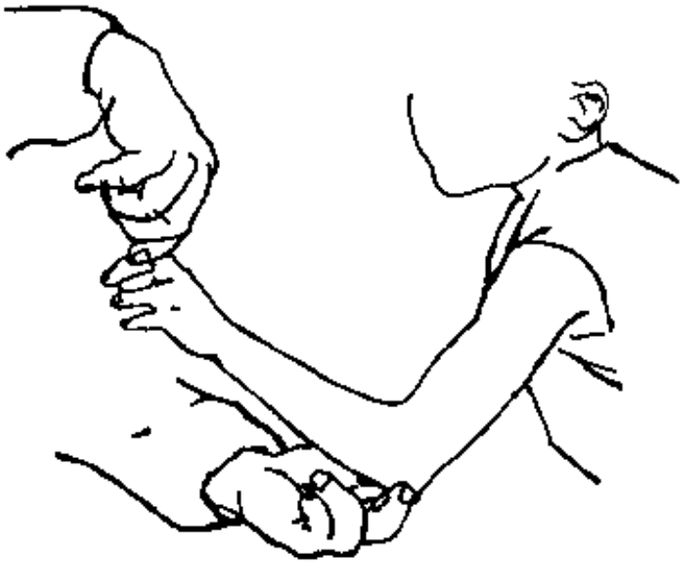

图 52　赤凤点头

【作用与主治】　有通关顺气、定喘息之作用。主治腹部膨胀、咳嗽气喘、惊风抽搐等症。

凤凰展翅

【部位与操作】　医者以两手食、中二指固定患儿的腕部，同时以拇指掐患儿之精宁、威灵二穴，并上下摇动如凤凰展翅状（图 53）。一般操作 20～50 下。

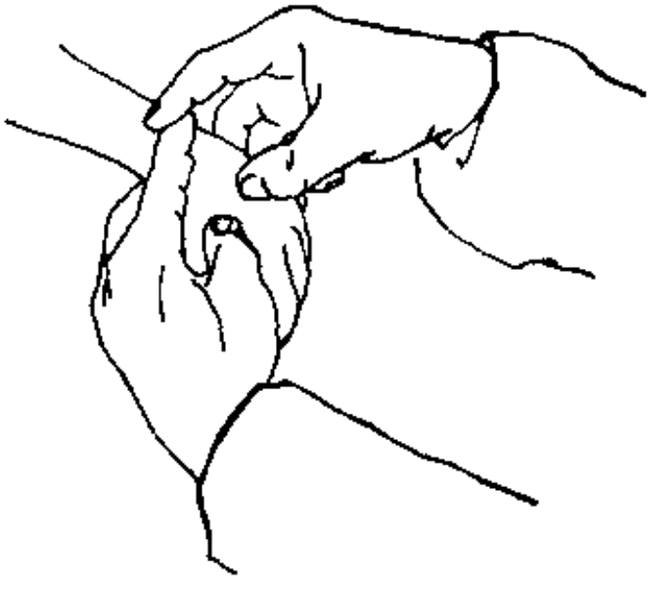

图 53　凤凰展翅

【作用与主治】　有祛寒解表、宣通气机之作用。主治寒症、寒喘、惊悸、噎膈、暴亡等症。

运土入水

【部位与操作】　医者用拇指端，自患儿拇指根沿手掌边缘，经小天心运至小指根，称运土入水（图 54）。一般操作 100～300 次。

【作用与主治】　有清脾胃湿热、利尿止泻之作用。主治

脾胃湿热而致腹胀腹泻、小便短赤、痢疾等病症。

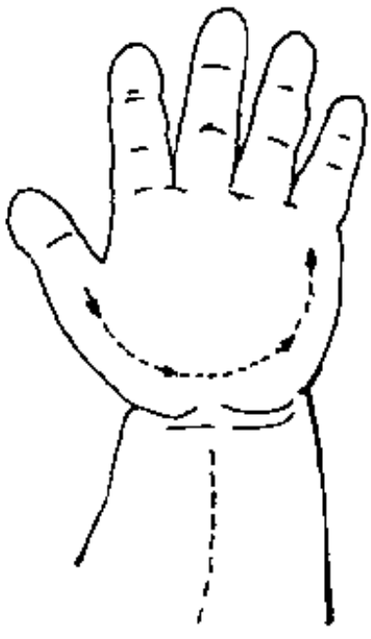

图 54　运土入水

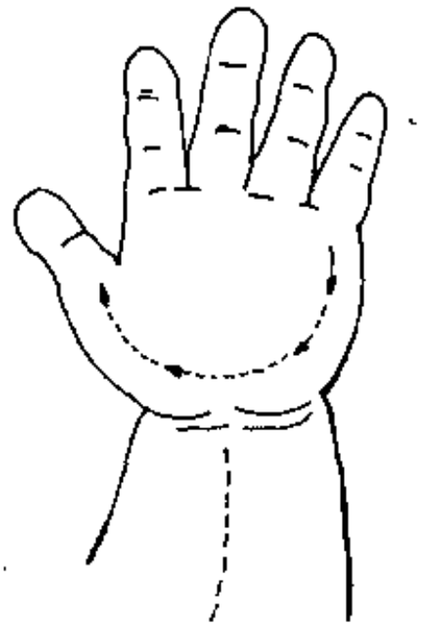

图 55　运水入土

运 水 入 土

【部位与操作】　医者用拇指端，自患儿小指根沿手掌边缘，经小天心运至拇指根，称运水入土（图 55）。操作 100～300 次。

【作用与主治】　有健脾助运、润燥通便之作用。主治脾胃虚弱而致完谷不化、腹泻、疳积、食欲不振、便秘等症。

开 璇 玑

【部位与操作】　医者以两拇指端先从璇玑穴（在胸骨正中线，平第 1 肋骨上缘）处，沿胸肋自上而下向左右两旁分推，再从鸠尾穴向下直推至脐部，再由脐部向左右推摩，最后从脐中推至小腹。一般操作 20～50 次。

【作用与主治】　本法具有开胸顺气、宣肺止咳化痰、行滞消食等作用。它包括分推璇玑膻中、推中脘、推摩神阙、推下神阙四种操作方法。主治胸闷气促、气息喘急、咳痰不畅、食积腹痛、积滞胀满、呕吐腹泻及发热不退等实热症。

第三章　小儿常用穴位

小儿推拿除了运用十四经穴及经外奇穴外，本身还有许多特定的穴位（图 56、57、58）。这些穴位不仅有“线”状，还有“面”状及“点”状，但以两手居多，正所谓“小儿百脉汇于两掌”。上肢穴位，一般不分男女，习惯推拿左手，其中“次数”一项仅作为 6 个月～1 周岁患儿临床治疗应用时参考。推拿的顺序一般是先头面，次上肢，再胸腹、腰背，最后是下肢。亦可根据病情轻重缓急，灵活掌握。

第一节　腧穴定位法

临床上常用的定位方法有三种，即骨度分寸定位法、手指同身寸取穴法、人体自然标志取穴法。

一、骨度分寸定位法

头　部

前发际至后发际折为 12 寸；前发际不明者，可从眉心向上加 3 寸；后发际不明者，可从大椎穴向上加 3 寸，即从眉心至大椎穴（第 7 颈椎棘突下）作为 18 寸。身后两乳突之间折为 9 寸。

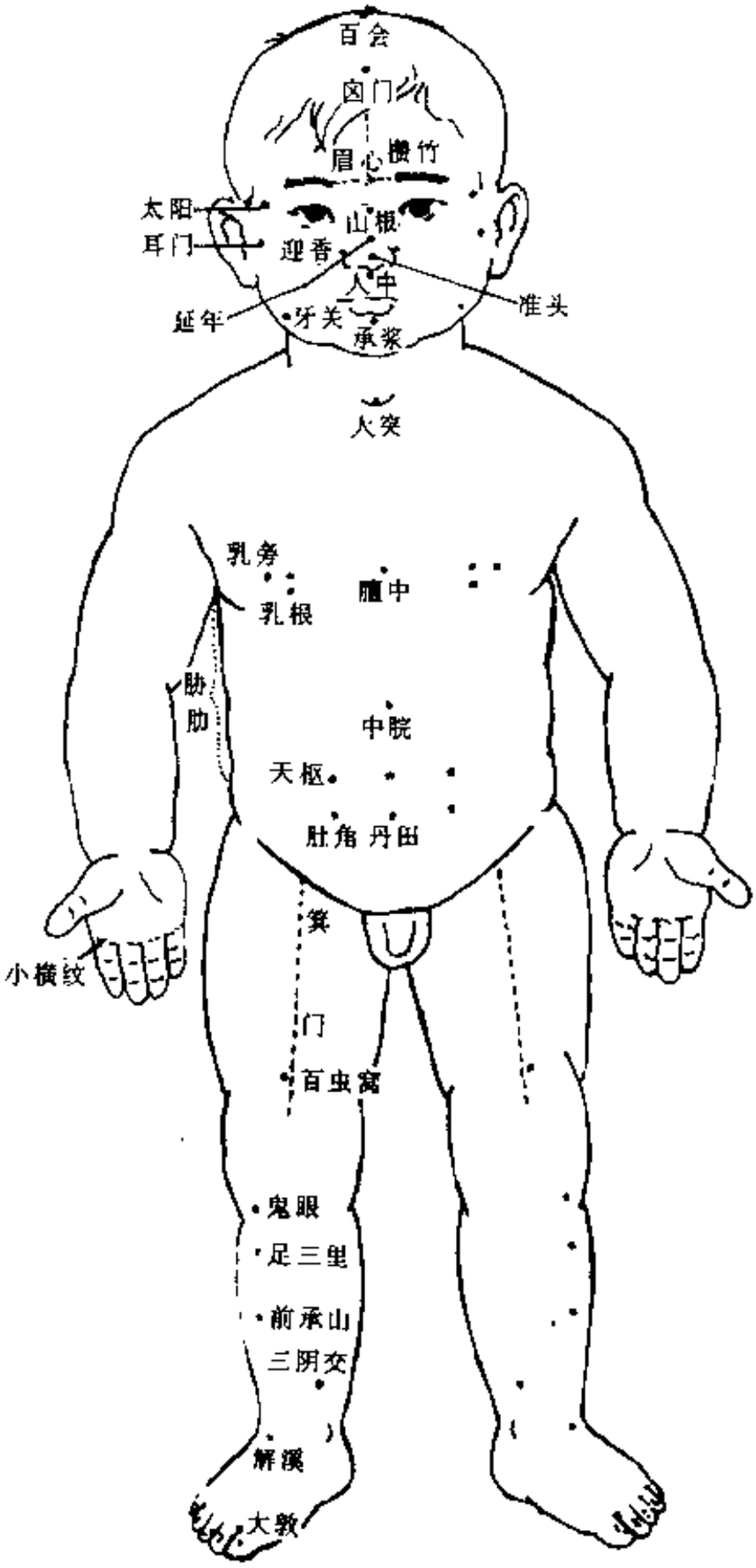
百会
囟门
眉心
攒竹
太阳
耳门
山根
迎香
人中
延年
牙关
承浆
准头
天突
乳旁
乳根
膻中
胁肋
中脘
天枢
肚角
丹田
箕
小横纹
门
百虫窝
鬼眼
足三里
前承山
三阴交
解溪
大敦

图 56　正面穴位图

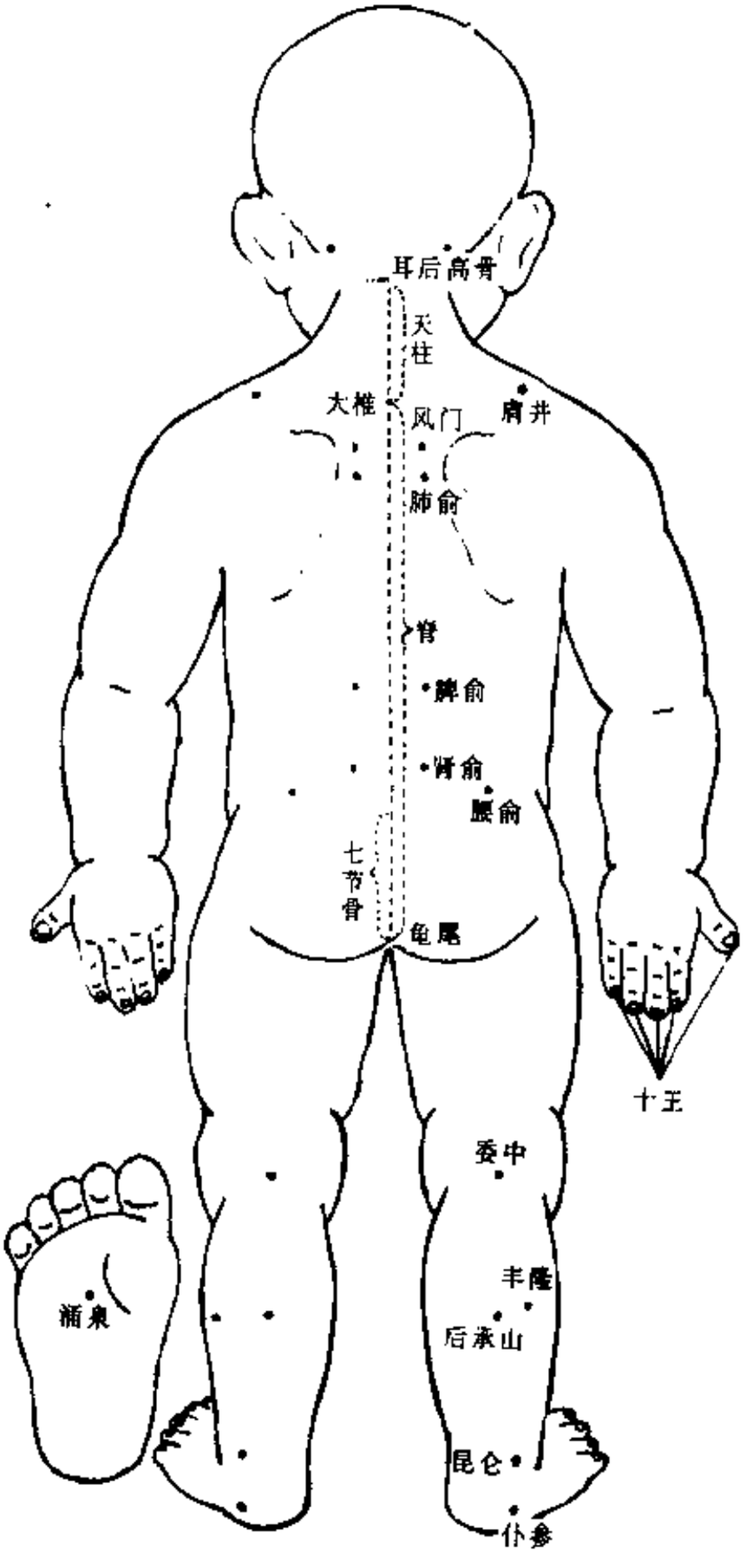

图 57　背面穴位图

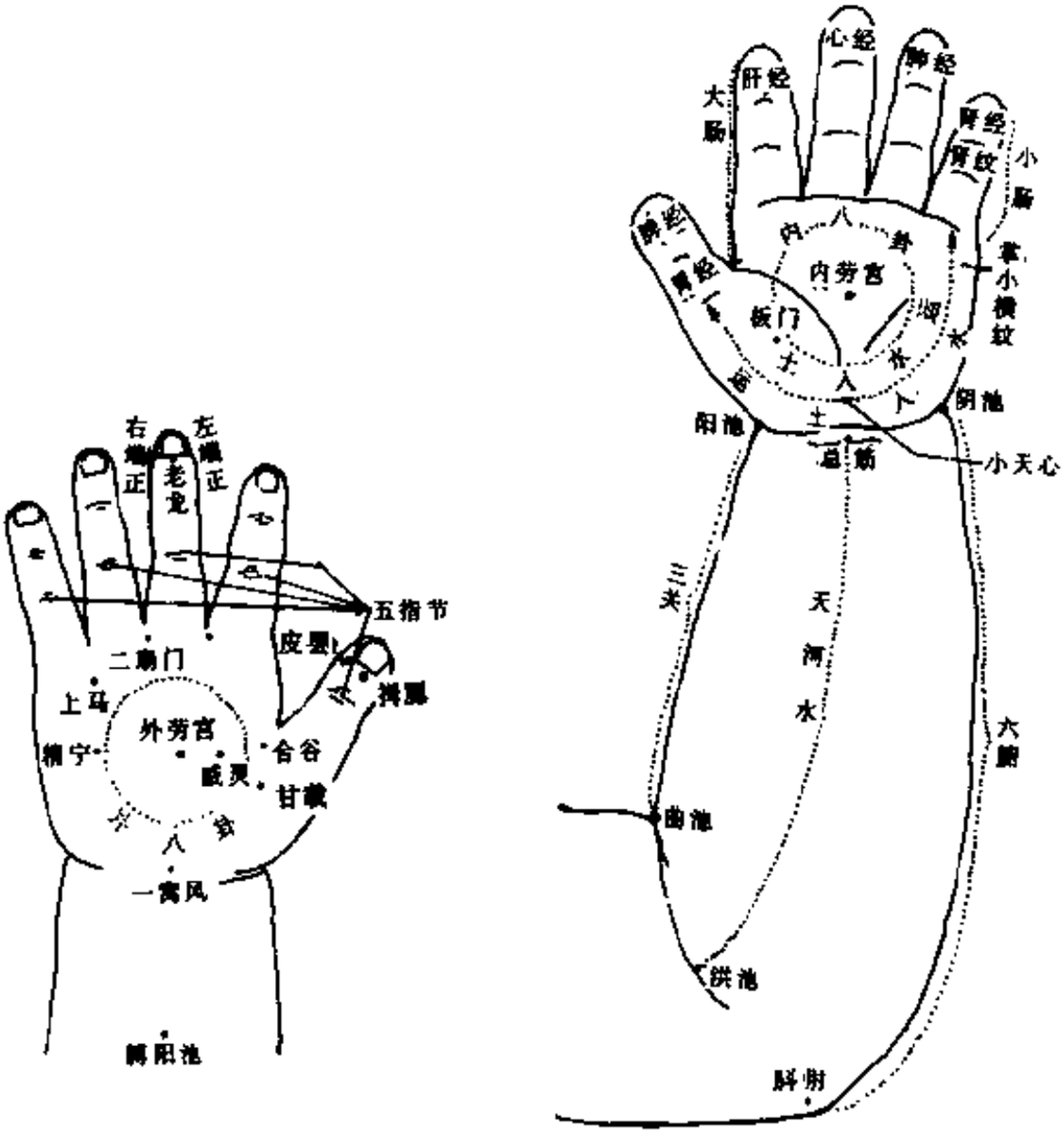

图 58　上肢穴位图

胸　腹　部

两乳头之间折为 8 寸；胸剑联合至脐中作 8 寸；脐中至耻骨联合上缘为 5 寸。

背　　部

大椎以下至尾骶折为 21 寸；从肩胛骨脊柱缘至背正中线

作3寸。

上 肢 部

腋前纹头至肘横纹作9寸；肘横纹至腕横纹为12寸。

下 肢 部

大腿内侧，从耻骨联合上缘至股骨内上髁作18寸；外侧，从股骨大转子至腘窝横纹作19寸。

小腿内侧，从胫骨内髁以下至内踝作13寸；外侧，从髌骨下缘至外踝作16寸。

二、人体自然标志取穴法

利用人体自然标志定位取穴，如眉心、发际、肚脐、乳头、爪甲等皆可作为取穴标记。

三、手指同身寸取穴法

中指同身寸

以病人中指节屈曲，取两端纹头距离为1寸。

拇指同身寸

以患者拇指关节的横度折为1寸。

横指同身寸

病人食指、中指、无名指、小指并拢，以中指中节横纹为准，四指宽度折为3寸。此法又称“一夫法”。

第二节　头颈部穴位

攒竹（天门）

【部位与操作】　两眉中间至前发际成一直线。医者以两拇指桡侧或指腹自下而上交替直推，称为推攒竹，又称开天门（图 59）。操作 30～50 次。

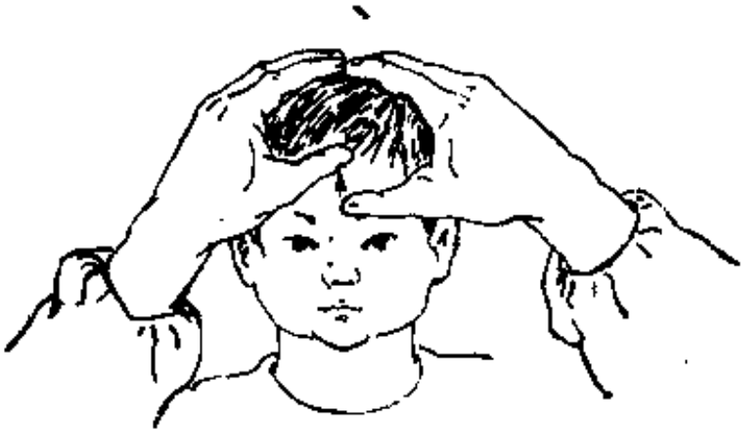

图 59　推攒竹

【作用与主治】　有发汗解表、开窍醒脑、镇静安神之作用。主治风寒感冒、发热无汗、头痛、惊惕不安、精神萎靡等病症。

坎宫（眉弓）

【部位与操作】　自眉头起沿眉向眉梢成一横线。医者先以两拇指端分别轻按鱼腰一下，再自眉头起向眉梢作分推，称推坎宫，又叫推眉弓（图 60）。一般操作 30～50 次。

【作用与主治】　有发汗解表、醒脑明目、止头痛的作用。主治外感发热、头痛无汗、目赤痛、惊风等症。

图 60　推坎宫

太　　阳

【部位与操作】　眉后凹陷处。医者用中指端揉该穴，称揉太阳或运太阳（图 61）。向眼前方向揉为补，向耳后方向揉为泻。以两拇指桡侧自前向后直推，称推太阳。揉 30～50 次。

图 61　揉太阳

【作用与主治】　具有疏风解表、清热、明目止头痛等作

用。主治感冒、发热、头痛、目赤痛、近视、惊风等病症。若外感表实症用泻法，外感表虚、内伤头痛用补法。推太阳主要用于外感发热。

耳后高骨

【部位与操作】　耳后入发际高骨下凹陷中。医者用两拇指端或中指端揉之，称揉耳后高骨（图 62）。操作 30～50 次。

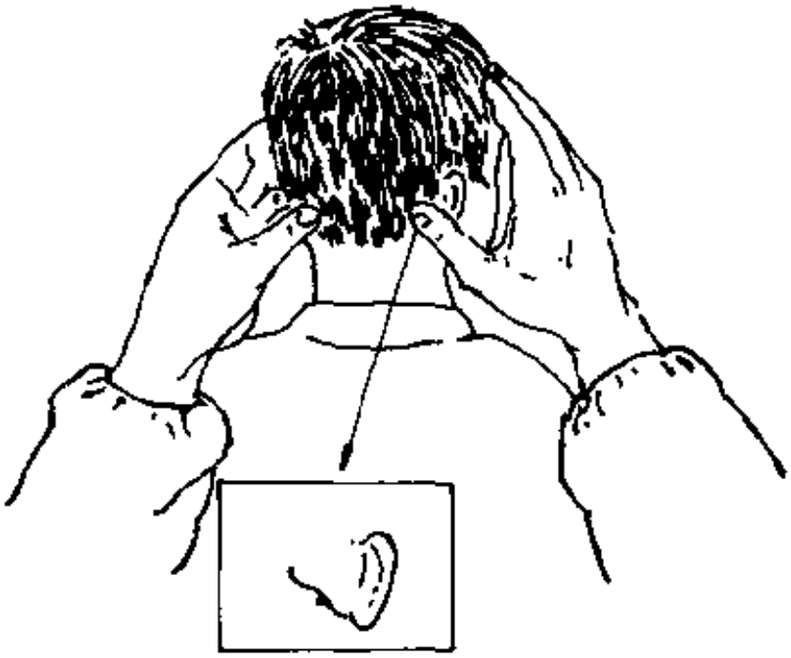

图 62　揉耳后高骨

【作用与主治】　具有发汗解表、除烦安神之作用。主治感冒头痛、烦躁不安、惊风等症。

人　中

【部位与操作】　人中沟正中线上 1/3 与下 2/3 交界处。用拇指甲掐该穴，称掐人中（图 63）。一般掐 5 下或醒后即止。

【作用与主治】　有开窍醒神之作用。主要用于急救，治疗不省人事、惊厥、抽搐、窒息等症。

图 63　掐人中　　图 64　揉百会

百　会

【部位与操作】　后发际正中直上 7 寸，从两耳尖直上，头正中线取之。医者一手扶患儿头部，另手拇指端按揉该穴，称揉百会（图 64）。30～50 次。

【作用与主治】　有安神镇惊、升阳举陷、止头痛等作用。主治头痛、目眩、惊风、遗尿、脱肛、夜寐不安等症。

天 柱 骨

【部位与操作】　颈后发际正中至大椎穴成一直线。医者一手食、中指并拢，用指腹由上而下直推，称推天柱骨（图

65)。或用汤匙边蘸水自上向下刮。一般推 100～500 次；刮至皮下轻度瘀血即可。

【作用与主治】 有降逆止呕、祛风散寒之作用。主治呕吐恶心、外感发热、颈项僵痛、后头痛、惊风、咽痛等症。

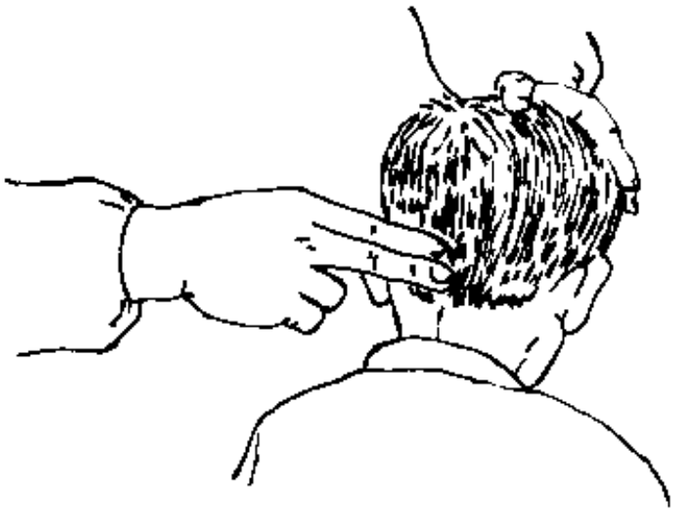

图 65 推天柱骨

风 池

【部位与操作】 后发际（颈项上部）两侧凹陷处。医者位于患儿身后，以两手之四指扶患儿头侧，两拇指端按揉本穴，称揉风池（图 66）。或用拇指拿之，称拿风池。揉 30～50 次；拿 3～5 次。

【作用与主治】 具有发汗解表、祛风散寒之作用。主治感冒头痛、发热无汗、颈项强痛等病症。

印 堂

【部位与操作】 两眉连线的中点处。医者左手扶患儿头部，右手拇指端自眉心向上推至天庭，称推印堂（图 67）。推

30～50 次。或以拇指甲掐之，称掐印堂。一般掐 3～5 下。

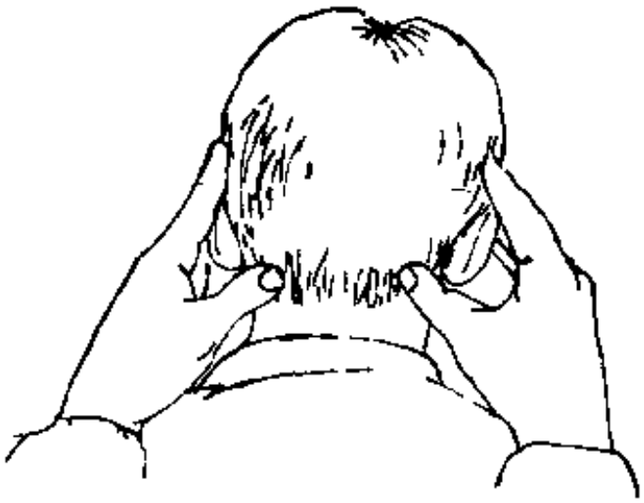

图 66　揉风池

图 67　推印堂

【作用与主治】　有醒脑提神、祛风通窍之作用。主治感冒头痛、昏厥抽搐、慢惊风等症。治疗头痛感冒用推法，治疗惊厥用掐法。印堂还可作为望诊用，如印堂处青色主惊、惊泻；赤主热症。

囟　门

【部位与操作】　前发际正中直上 2 寸，百会前骨陷中。医者以两手扶患儿头部，两拇指自前发际向上交替推至囟门（图 68），再自囟门向两旁分推（图 69）。若囟门未闭合时，仅推至边缘。操作各 30～50 次。

图 68　推囟门

图 69　分推囟门

【作用与主治】　有镇惊安神通窍之作用。主治头痛、惊

风、头晕、目眩、鼻塞、神昏、烦躁、衄血等。

山　根

【部位与操作】　两目内眦之中。医者一手扶儿头部，用另手拇指甲掐之，称为掐山根（图 70）。一般掐 3～5 下。

【作用与主治】　具有开窍、醒目、定神之作用。主治惊风、抽搐等症。本穴除治病外，常可作为望诊用于诊断疾病，如山根脉络青色为惊为痛，蓝色为喘为咳，赤灰一团为赤白痢疾，青黑之纹为病久，或缠绵难愈之疾。

图 70　掐山根

图 71　掐准头（素髎）

准头（素髎）

【部位与操作】　在鼻尖中央。医者以拇指或食指甲掐之，继以揉之，称掐准头（图 71）。掐约 3～5 下。

【作用与主治】　有开窍醒神、解表散结等作用。主治惊

风、抽搐、窒息、外感、鼻塞不通、鼻中瘜肉等症。另外作为望诊用以诊断疾病，如准头深黄色为内热便结，赤色光亮多生脓血。

牙关（颊车）

【部位与操作】　耳下1寸，下颌骨陷中。患儿取坐位，医者以两手中指端按揉之，称为揉牙关（图72）。揉15～20次。

【作用与主治】　有疏风、开窍、止痛等作用。主治牙关紧闭、口眼歪斜、牙痛等症。

图72　揉牙关

图73　揉迎香

迎　香

【部位与操作】　鼻翼旁0.5寸鼻唇沟中（图73）。医者用食、中二指或两拇指端按揉之，称揉迎香。操作20～30次。

【作用与主治】　有宣肺气、通鼻窍之作用。主治鼻塞不通、鼻流清涕、呼吸不畅、口眼歪斜、急慢性鼻炎等病症。

承　浆

【部位与操作】　在颏唇沟正中，属任脉。患儿取坐位，医者用食指或拇指甲掐之，继以揉之，称掐承浆（图 74）。一般掐 3～5 下。

【作用与主治】　具有祛风、开窍、醒神等作用。主治惊风、抽搐、口眼歪斜、面瘫、三叉神经痛、面肿、暴哑不语等症。

图 74　掐承浆

图 75　揉耳门

耳门（风门）

【部位与操作】　在耳屏上切迹之前方，张口凹陷处，属手少阳三焦经。患儿取坐位，医者以两手食指端或拇指端揉

之，称揉耳门或运耳门（图 75）。一般操作 20～30 次。

【作用与主治】　具有镇惊开窍、聪耳、止牙痛等作用。主治惊风抽搐、口眼歪斜、耳鸣耳聋、牙痛等症。还可作为望诊用以诊断疾病，如耳门穴色黑则为寒为疝，色青为燥为风。

桥　弓

【部位与操作】　在颈部两侧，沿胸锁乳突肌成一线。患儿取坐位，医者一手扶患儿头侧，另手拇、食指自上而下拿之，称为拿桥弓（图 76）；或用拇指推法自上而下推之，称推桥弓（图 77）；用抹法自上而下抹之，称为抹桥弓。拿约 3～5 下；推或抹约 30～50 次。

图 76　拿桥弓

图 77　推桥弓

【作用与主治】　具有舒筋活络、调和气血、平肝潜阳、降低血压的作用。主治先天性肌性斜颈、颈项强痛、高血压、惊风等病症。

第三节　胸腹部穴位

天　突

【部位与操作】　在胸骨上窝正中。医者一手扶患儿头侧，另手中指端按或揉，称为按天突或揉天突（图 78）。一般操作 10～30 次。

图 78　按天突

【作用与主治】　具有降逆平喘、理气化痰、止呕之作用。主治痰壅气急、咳喘胸闷、恶心呕吐等症。

膻　中

【部位与操作】　在胸骨中线上，平第 4 肋间隙，正当两乳之间。患儿取仰卧或坐位，医者以两拇指端自穴中向两旁分推至乳头，称为分推膻中（图 79）；用中指端揉之，称为揉膻中（图 80）。推、揉各 50～100 次。

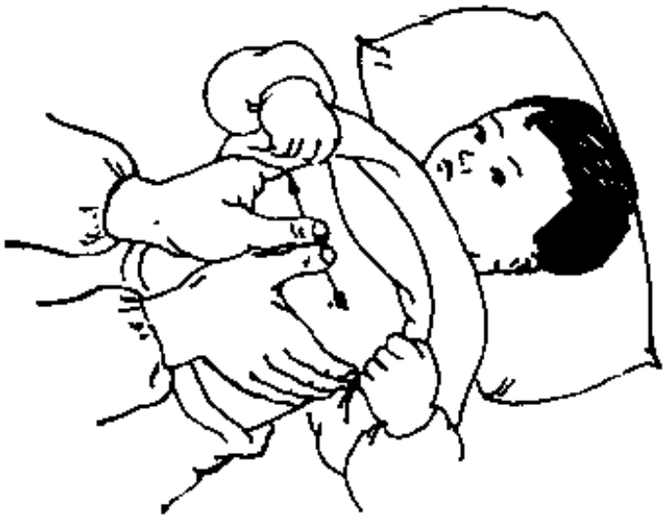

图 79　分推膻中

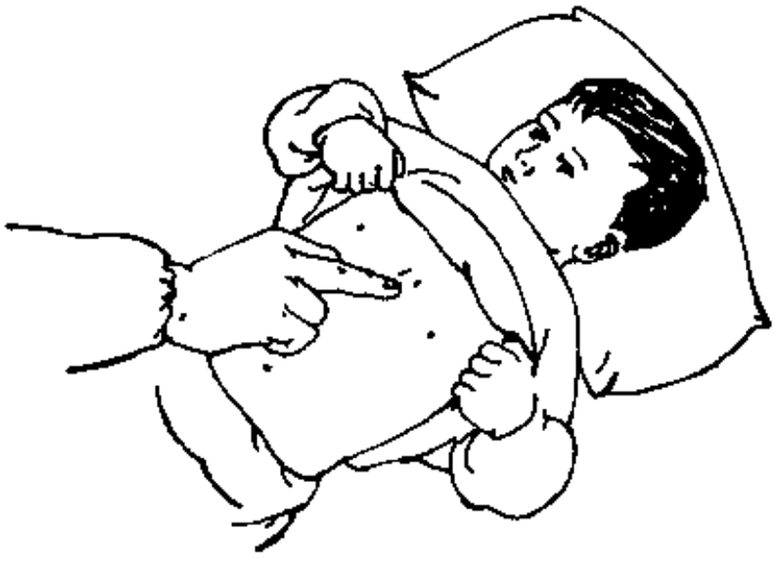

图 80　揉膻中

【作用与主治】　具有宽胸理气、宣肺止咳化痰之作用。主治胸闷、痰喘咳嗽、吐逆等症。

乳　旁

【部位与操作】　乳外旁开 0.2 寸。医者两手四指扶患儿之两胁，再以两拇指于穴位上揉之，称揉乳旁（图 81）。揉 30～50 次。

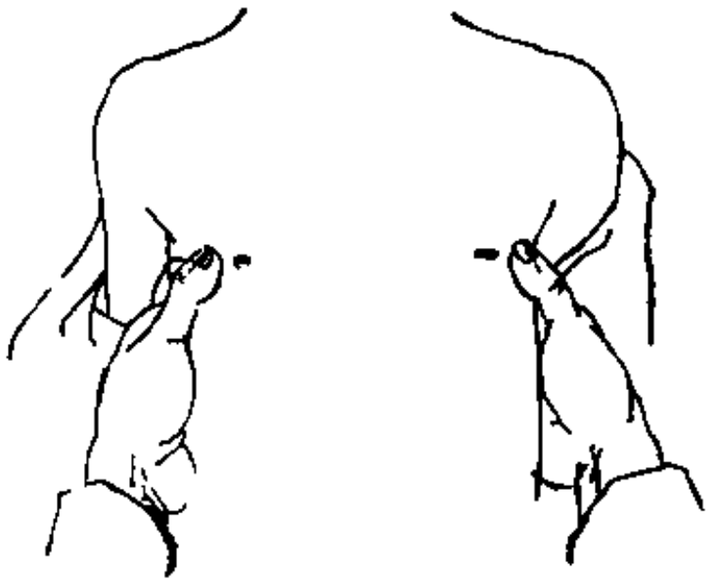

图 81　揉乳旁

【作用与主治】　有宽胸理气、止咳化痰之作用。主治胸闷、咳嗽、痰鸣、呕吐等症。

乳　根

【部位与操作】　乳下 0.2 寸。医者以两手四指扶患儿两胁，再以两拇指于穴位上揉之，称揉乳根。揉 30～50 次。

【作用与主治】　具有宣肺理气、止咳化痰之作用。主治咳喘、胸闷、痰鸣等症。临床上乳根常与乳旁同时运用，即两手食、中指端分别对准乳根、乳旁两穴，同时按揉之，称揉乳根乳旁。

中　脘

【部位与操作】　在前正中线上，脐上4寸处。用掌根按揉之，称揉中脘（图82）；用食、中指端自喉往下推至中脘或自中脘向上直推至喉下，称为推中脘，又称推胃脘（图83）；用掌心或四指摩之，称摩中脘。

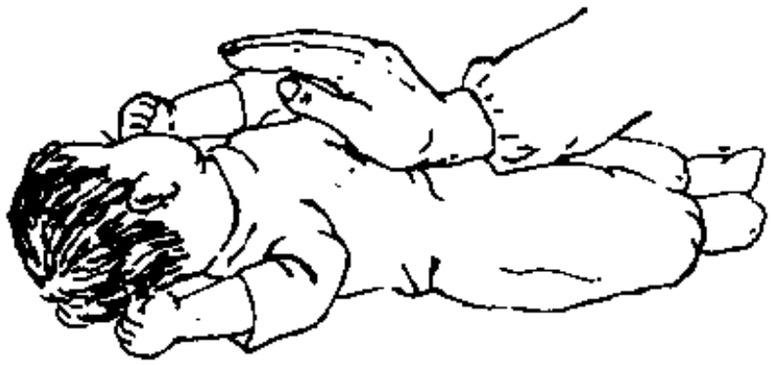

图82　揉中脘

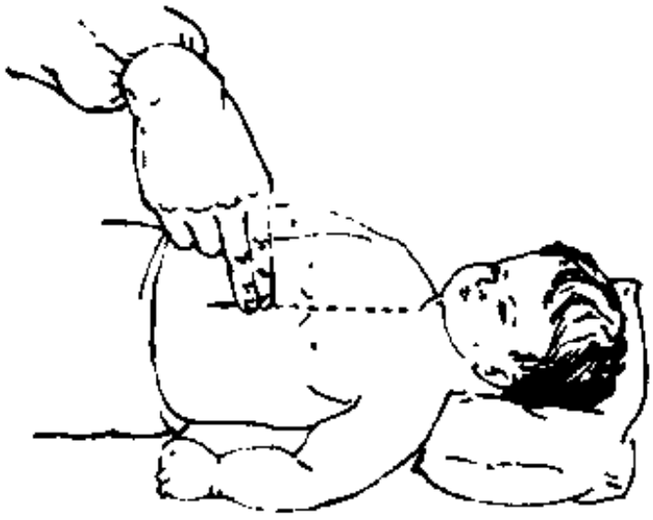

图83　推中脘

【作用与主治】　揉、摩中脘有健脾和胃、消食和中之作用。主治腹泻、呕吐、腹痛、腹胀、食欲不振等症。推中脘自

上而下操作，有降胃气作用，主治呕吐恶心；自下而上操作，有涌吐作用。

腹

【部位与操作】　在腹部。患儿取仰卧或坐位，医者用两拇指端沿肋弓角边缘或自中脘至脐，向两旁分推，称分推腹阴阳（图 84）；用掌面或四指摩之，称摩腹（图 85）。分推 100～200 次；摩腹 3～5 分钟。

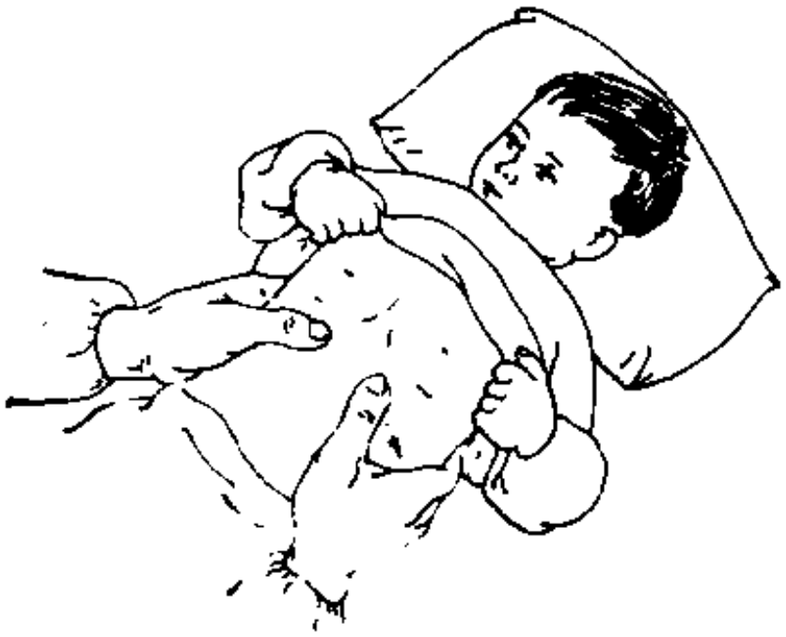

图 84　分推腹阴阳

图 85　摩腹

【作用与主治】　分推腹阴阳有降逆止呕、和胃消食之作用。主治伤食呕吐恶心、腹胀等症。顺时针（自右下腹向上向左方向）为泻，有消食和胃通大便的作用，主治腹胀、厌食、大便秘结等症；逆时针（自左下腹向上向右方向）为补，有健脾益气、止泻之作用，主治脾虚腹泻、腹痛、食欲不振、面黄肌瘦、乏力懒言等症。

胁　肋

【部位与操作】　从腋下两胁至天枢处。患儿取坐位，医者两手掌从患儿两腋下搓摩至天枢处，称为搓摩胁肋（图86）。搓摩50～100次。

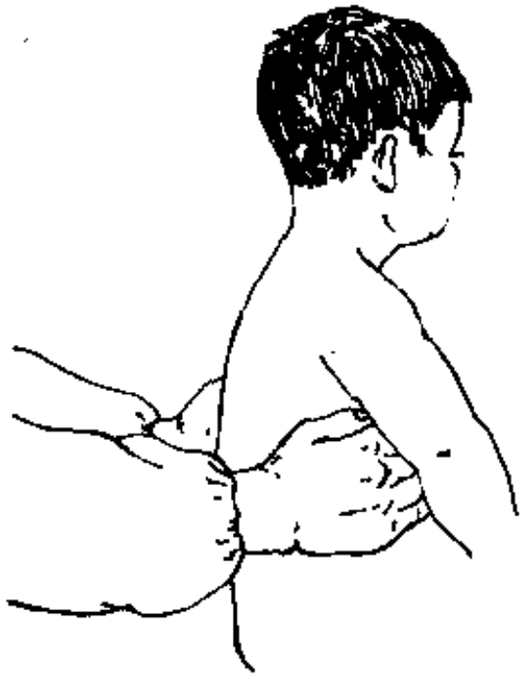

图86　搓摩胁肋

【作用与主治】　本穴性开而降，有顺气化痰、除胸闷、开积聚之作用。主治胸闷、腹胀、食积、痰喘气急、疳积、胁痛、肝脾肿大等症。本穴对中气下陷、肾不纳气者慎用。

天　　枢

【部位与操作】　肚脐旁开 2 寸。患儿取仰卧位，医者用食、中指端按揉之，称揉天枢（图 87）。一般操作 50～100 次。

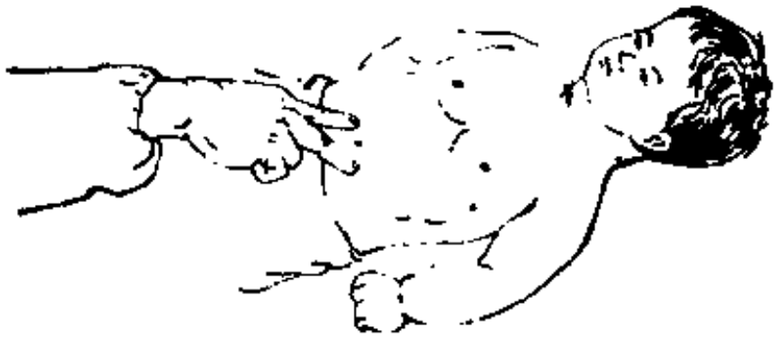

图 87　揉天枢

【作用与主治】　有疏调大肠、理气消滞之作用。主治腹泻、便秘、腹胀、腹痛、食积不化等症。

脐（神阙）

【部位与操作】　肚脐。患儿取仰卧位，医者用中指端揉之，称揉脐（图 88）。用掌或指摩之，称摩脐。揉 100～300 次；摩 3～5 分钟。

【作用与主治】　揉、摩肚脐具有温阳散寒、补益气血、健脾和胃、消食导滞的作用。主治腹泻、便秘、腹痛、疳积等症。

图 88　揉脐

丹　田

【部位与操作】　在小腹部脐下 2.5 寸。患儿取仰卧位，医者用掌摩之，称摩丹田（图 89）；用拇指或中指端揉之，称揉丹田；用指端按之，称按丹田。摩 2～3 分钟；揉 100～300 次；按 0.5～1 分钟。

图 89　摩丹田

【作用与主治】　有培肾固本、温补下元、泌别清浊之作用。主治小腹胀痛、癃闭（尿潴留）、小便短赤、遗尿、脱肛、便秘、疝气等症。

肚　角

【部位与操作】　脐下2寸（石门）旁开2寸大筋。患儿取仰卧位，医者用拇、食、中三指向深处拿之，称拿肚角，同时向偏内上方做一推一拉一紧一松的轻微动作为一次（图90）；用拇指或中指端按之，称按肚角。拿、按各3～5次。

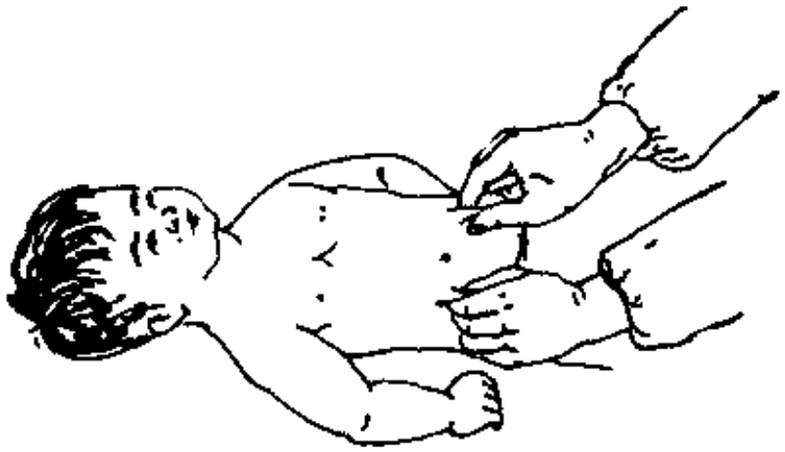

图90　拿肚角

【作用与主治】　本穴主要有止腹痛及健脾和胃、理气消滞之作用。主治受寒、伤食引起的腹痛、腹泻等症。

气　海

【部位与操作】　在腹正中线上，脐下1.5寸（图91），仰卧位取穴。医者以中指或拇指端揉之，称揉气海；以中指或拇指端按之，称按气海。揉100～300次；按0.5～1分钟。

【作用与主治】　有散寒止腹痛之作用。主治虚寒腹痛、腹泻、遗尿、脱肛、疝气等症。

关　元

【部位与操作】 腹正中线，脐下3寸（图91）处。患儿仰卧，医者用中指面或掌按揉之，称按揉关元。若用艾条灸之，称灸关元。揉100～300次；艾灸3～5分钟，或以局部红润为度。

【作用与主治】 有温肾壮阳、培补元气的作用。主治虚寒性腹痛、腹泻、痢疾、遗尿、五迟、五软等症。

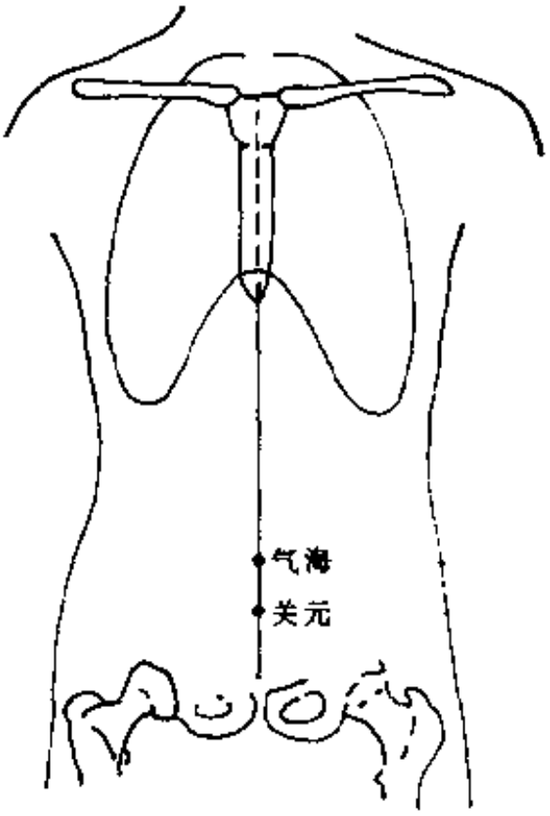

图91　气海　关元

第四节　腰背部穴位

肩　井

【部位与操作】 在大椎与肩峰连线的中点，肩部筋肉处。患儿取坐位，医者用拇指与食、中二指对称用力提拿本穴，称拿肩井（图92）。用指端按之，称按肩井。拿3～5次；按0.5～1分钟。

【作用与主治】 有宣通气血、发汗解表之作用。主治感冒、上肢痹痛、发热无汗、颈项强痛、肩痛、上肢抬举受限等症。本法为诸法推毕的结束手法，又称为总收法。

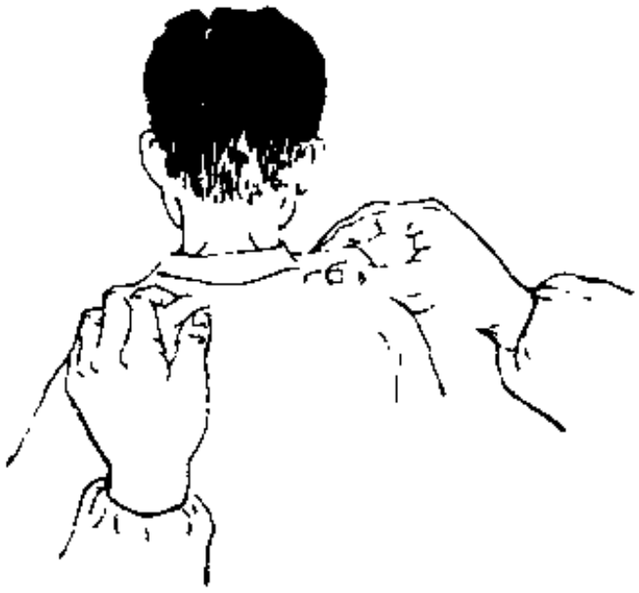

图 92　拿肩井

大　　椎

【部位与操作】　在第 7 颈椎棘突下。医者用中指或拇指端揉之，称揉大椎（图 93）。用双手拇、食指将其周围的皮肤捏起，向穴中挤去，称为捏挤大椎。揉 30～50 次；捏挤至局部皮肤充血或紫红瘀斑为度。

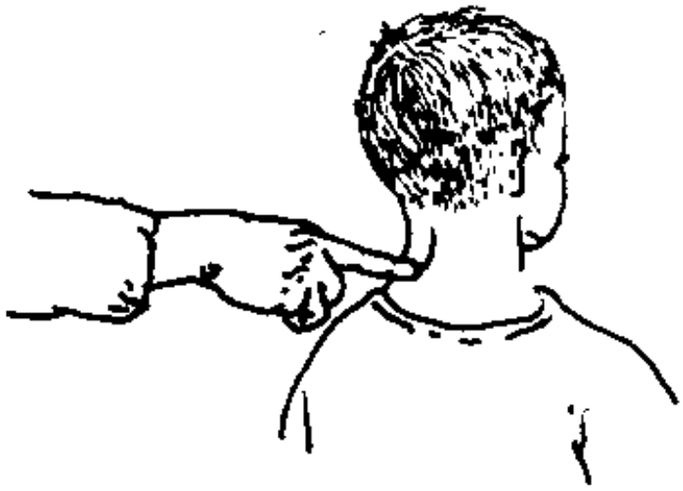

图 93　揉大椎

【作用与主治】　有清热解表、通经活络之作用。主治发热、感冒、项强、咳嗽、百日咳等。

风　门

【部位与操作】　第 2 胸椎棘突下旁开 1.5 寸（图 94）。以食、中指端揉之，称揉风门。揉 20～50 次。

【作用与主治】　具有疏风解表、宣肺止咳等作用。主治风寒感冒、咳嗽气喘、鼻塞、背腰部疼痛、项痛、骨蒸潮热及盗汗等病症。

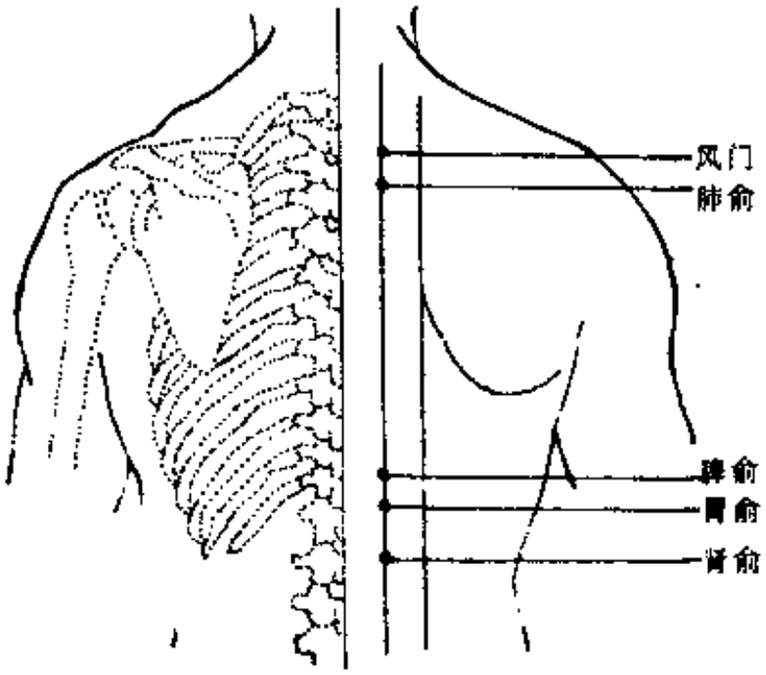

图 94　风门

肺　俞

【部位与操作】　在第 3 胸椎棘突下旁开 1.5 寸（见图 94）。医者以食、中指端或两拇指端揉之，称揉肺俞（图 95）；

用两拇指端分别自肩胛骨内缘由上向下做分向推动，称为分推肩胛骨（图 96）。揉 50～100 次；分推 100～200 次。

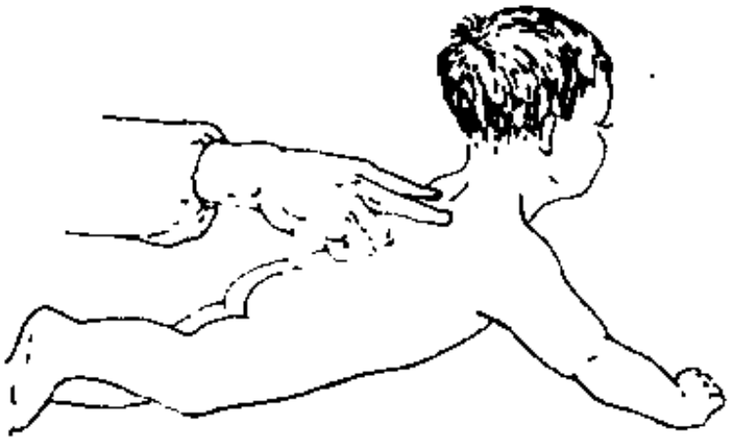

图 95　揉肺俞

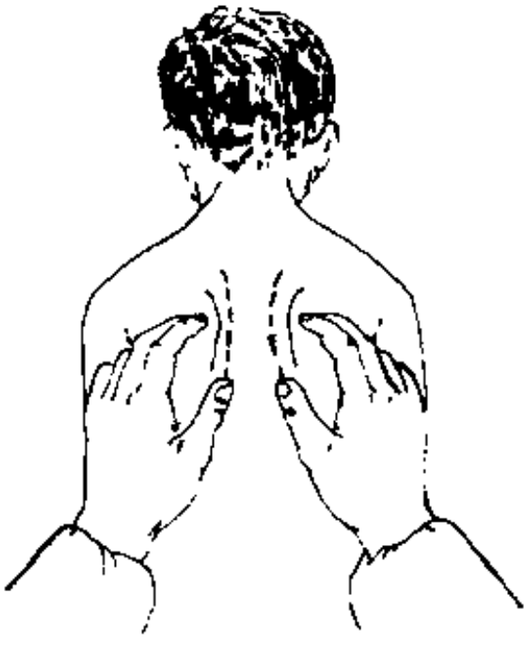

图 96　分推肩胛骨

【作用与主治】　有调肺气、补虚损、止咳嗽等作用。主治咳嗽气喘、久咳不愈、痰鸣、胸闷胸痛、发热等。

脾　　俞

【部位与操作】　在第 11 胸椎棘突下旁开 1.5 寸（见图

94)。医者以食、中指端或两拇指端揉之，称揉脾俞。揉 50～100 次。

【作用与主治】 具有健脾胃、助运化、祛水湿等作用。主治脾胃虚弱引起的呕吐、腹泻、食欲不振、疳积、四肢乏力、肌肉消瘦、慢惊风及水肿、黄疸等症。

胃 俞

【部位与操作】 在第 12 胸椎棘突下旁开 1.5 寸（见图 94)。医者以食、中指端或两拇指端揉之，称揉胃俞；用指端按之，称按胃俞。揉 50～100 次；按 0.5～1 分钟。

【作用与主治】 有和胃健脾、理中降逆之作用。主治胃脘疼痛、呕吐、腹胀、慢性腹泻、消化不良等症。

肾 俞

【部位与操作】 第 2 腰椎棘突下旁开 1.5 寸（见图 94)。用食、中指端揉之，或用两拇指端揉之，称揉肾俞。揉 50～100 次。

【作用与主治】 滋阴壮阳，补益肾气。主治肾虚腹泻、气喘、遗尿，阴虚便秘，少腹痛，下肢痿软乏力，慢性腰背痛。

腰 俞

【部位与操作】 在第 3 腰椎棘突下旁开 3.5 寸（即腰眼）凹陷中。以两拇指或食、中指端揉之，称揉腰眼。揉 20～30 次。

【作用与主治】 通经活络。主治腰痛、下肢瘫痪。

脊　柱

【部位与操作】　大椎至长强成一直线。医者用捏法自下而上捏之，称捏脊（图 97）；用食中指腹自上而下做直推法，称为推脊（图 98）。捏脊一般捏 3～5 遍，每捏三下再将脊背皮肤提一下，称为捏三提一法。在捏脊前先在背部轻轻按摩几遍，使肌肉放松。推脊一般操作 100～300 次。

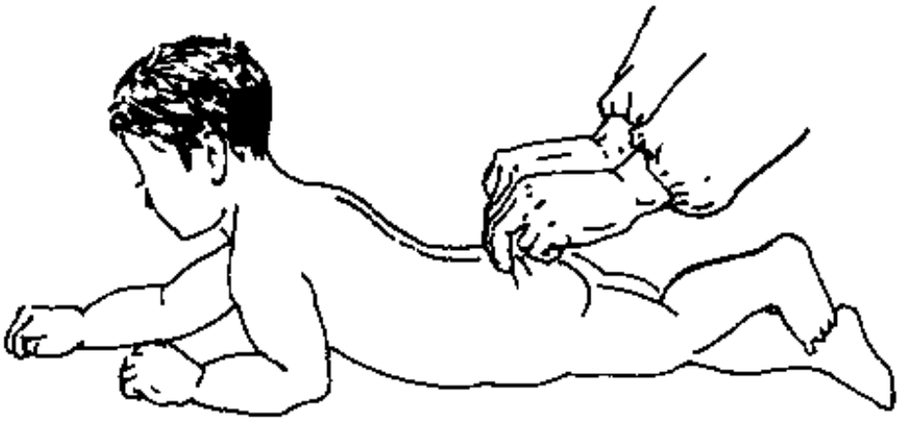

图 97　捏脊

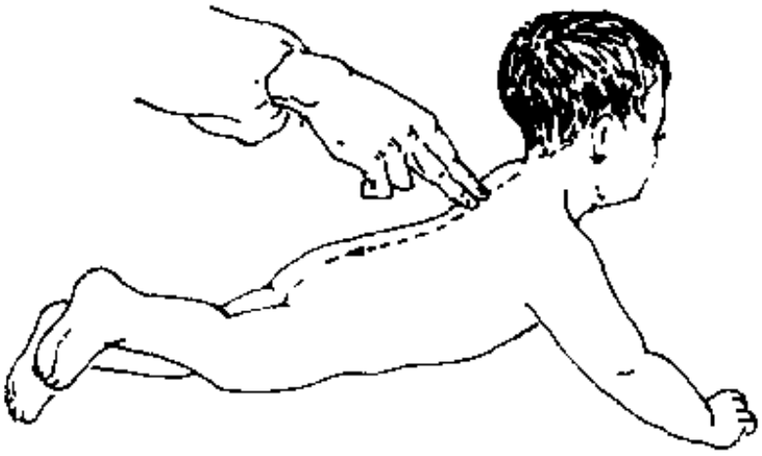

图 98　推脊

【作用与主治】　捏脊有调阴阳、理气血、和脏腑、通经络、培元气、强壮身体的作用。主治先、后天不足的一些慢性

病症，如疳积、腹泻、呕吐、便秘、惊风、夜啼等。还可用于成人胃肠病、失眠、月经不调等病症。临床运用时可根据不同的病情，重提或按揉相应的背部俞穴，以加强疗效。推脊有清热作用，主治小儿发热，多与清天河水、退六腑等合用。

七 节 骨

【部位与操作】 在第4腰椎与尾骨端（长强）成一直线。医者用拇指桡侧面或食、中指腹自下向上推之，称推上七节骨（图99），自上而下推，称推下七节骨。推100～300次。

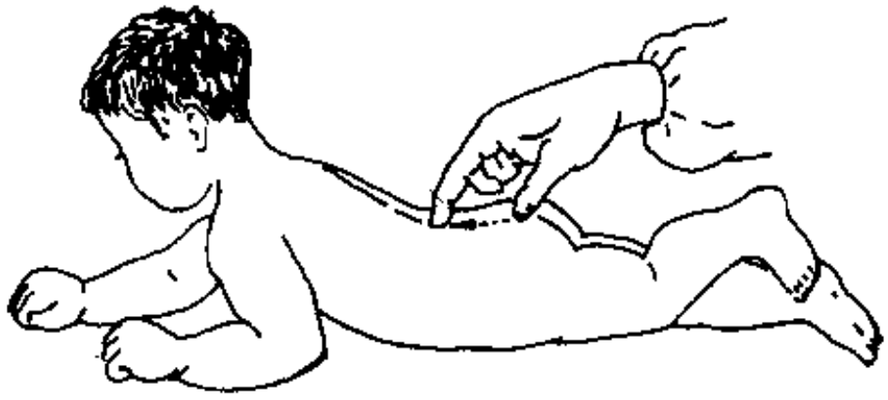

图99 推上七节骨

【作用与主治】 推上七节骨能温阳止泻。主治虚寒腹泻、久痢等症。多与补大肠、揉百会等合用。推下七节骨则泄热通便。主治肠热便秘、痢疾等症。若虚寒泄泻者不可用推下七节骨，以防滑泻。

龟 尾

【部位与操作】 尾椎骨端。医者用中指或拇指端揉，称揉龟尾（图100）。揉100～300次。

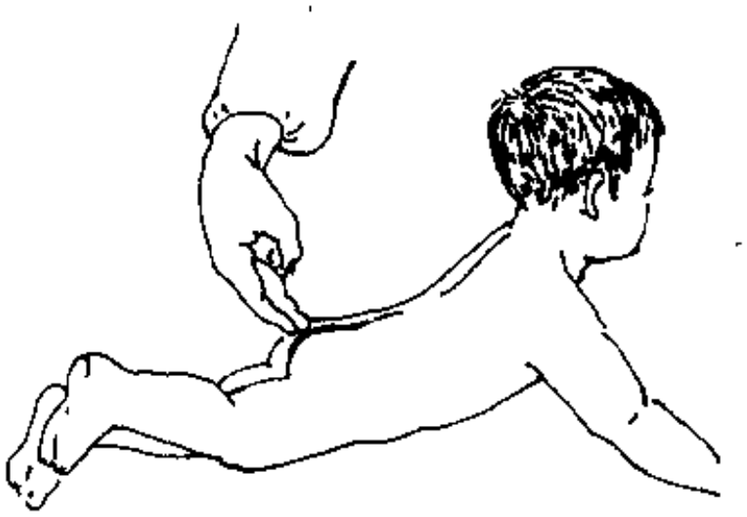

图 100　揉龟尾

【作用与主治】　统调督脉之经气，调理大肠之功能。既能止泻，又能通便。主治腹泻、便秘、脱肛等症。

第五节　上肢部穴位

脾　经

【部位与操作】　在拇指桡侧缘，指尖至指根成一线。医者用左手握患儿之左手，同时以拇、食二指捏住患儿拇指，使之微屈，再用右手拇指自患儿拇指尖推向拇指根，称为补脾经（图101）；若将患儿拇指伸直，自拇指根推向指尖，称为清脾经（图102）；若来回用力推之，称为清补脾经。一般操作100～500次。

【作用与主治】　补脾经能健脾胃，补气血。主治脾胃虚弱、气血不足引起的腹泻、食欲不振、肌肉消瘦、消化不良等病症。清脾经则清热利湿，化痰止呕。主治湿热熏蒸、皮肤发黄、恶心呕吐、腹泻、痢疾等症。清补脾经能和胃消食，增进食欲。主治脾胃不和引起的胃脘痞满、吞酸恶食、腹泻呕吐等症；若湿热留

恋，久不消退或外感发热兼湿者，可单用本法治之。

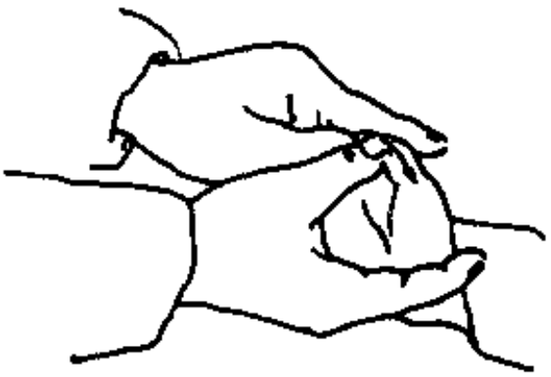

图 101　补脾经

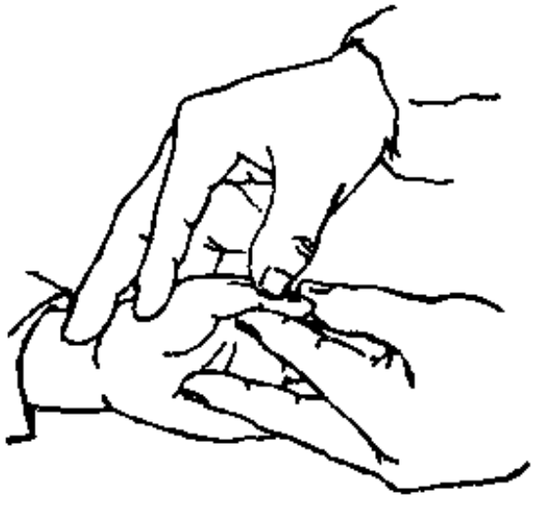

图 102　清脾经

肝　经

【部位与操作】　食指末节螺纹面。医者左手握住患儿之手，使其手指向上，手掌向外，然后再用右手拇指掌面由下而上直推，称清肝经（图 103），若由上而下直推之，称补肝经。100～500 次。

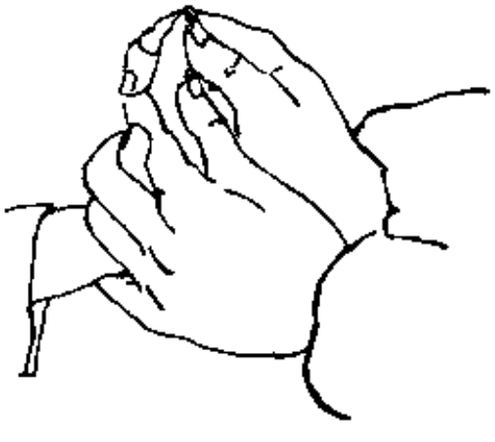

图 103　清肝经

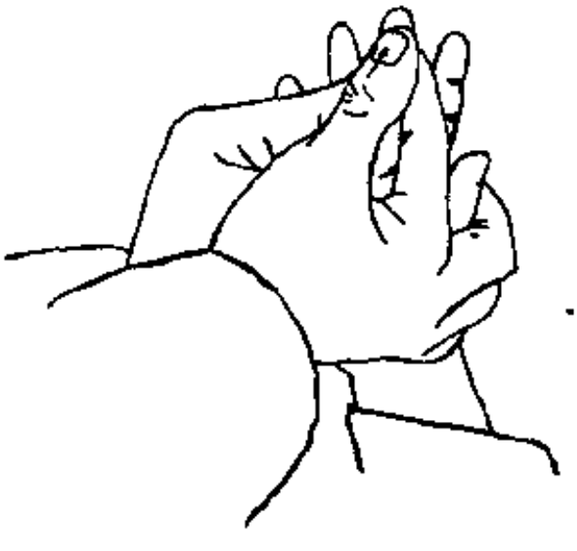

图 104　清心经

【作用与主治】　清肝经能平肝泻火，熄风镇惊，解郁除烦。主治惊风抽搐、烦躁不安、目赤肿痛、五心烦热等症。补肝经一般不常用，若肝虚应补时则需补后加清，或以补肾经代之，称为滋肾养肝法。

心　经

【部位与操作】　中指末节螺纹面。医者以左手握住患儿之手，使其中指向上，手掌向外，然后再以右手拇指自患儿中指末节向指尖方向直推，称清心经（图 104）；由指尖向指根方向直推，称补心经。100～500 次。

【作用与主治】　清心经能清热退心火。主治高热面赤、口舌生疮、小便短赤、惊风、惊吓。本穴宜清不宜补，以防动心火。若见气血不足而致睡卧露睛、慢脾风等症，需用补法时，可补后加清或以补脾经代之。

肺　经

【部位与操作】　无名指末节螺纹面。医者左手握住患儿之左手，使其无名指向上，手掌向外，然后用右手拇指腹，自无名指末节根部向指尖方向直推，称清肺经（图 105）；由指尖向指根方向直推，称为补肺经。100～500 次。

【作用与主治】　清肺经能宣肺清热，疏风解表，止咳化痰。主治感冒发热、咳嗽气喘、痰鸣、胸闷、鼻干、鼻流浊涕等症。补肺经则能补益肺气。主治肺气虚损、少气懒言、面白、自汗、遗尿、脱肛、畏寒、大便秘结。

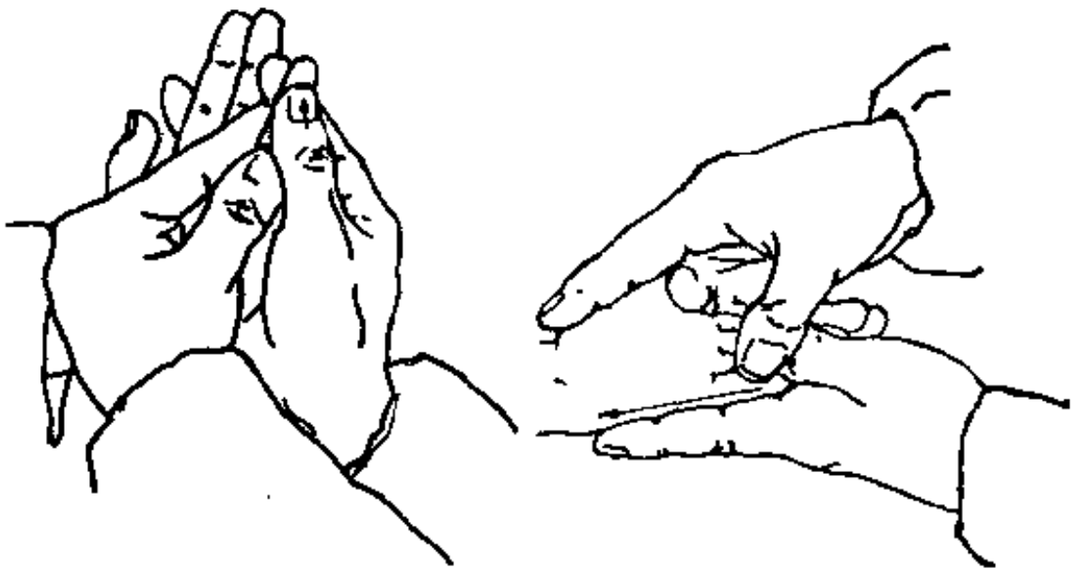

图 105　清肺经　　图 106　清肾经

肾　经

【部位与操作】　在小指掌面稍偏尺侧，自小指尖直至掌根成一线。医者先以左手握住患儿之左手，使手掌向上。再以右手拇指，从患儿小指尖推至掌根，称为清肾经（图 106）；由掌根直推至小指尖，称为补肾经（图 107）。一般操作 100～500 次。

【作用与主治】　清肾经能清利下焦湿热。主治膀胱蕴热、小便短赤、腹泻及小儿肾炎等病症。补肾经能滋肾壮阳，强筋健骨。主治先天不足、久病体虚、五更泄泻、遗尿、咳喘。

大　肠

【部位与操作】　在食指桡侧缘，由指尖至虎口成一直线。医者以左手握住患儿之左手，使掌侧置；再以右手食、中二指挟住患儿之拇指，然后用拇指桡侧面，自指尖直推至虎口

为补，称为补大肠（图 108）；反之为清，称为清大肠（图 109）；若来回推之，称为清补大肠。100～300 次。

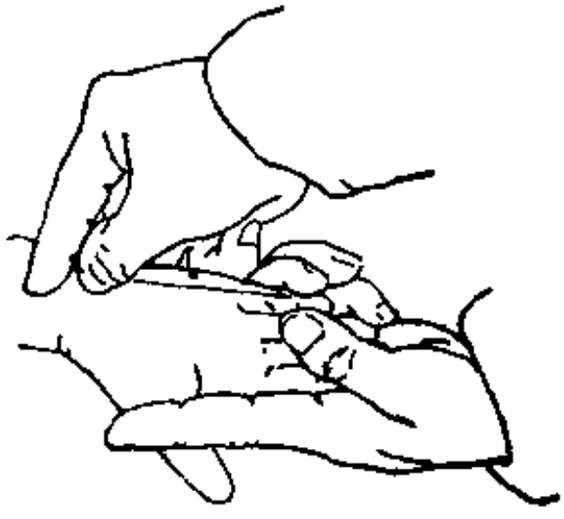

图 107　补肾经

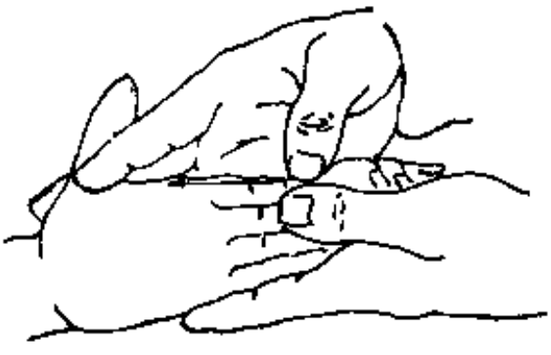

图 108　补大肠

【作用与主治】　补大肠能温中止泻，涩肠固脱。主治虚寒腹泻、痢疾、脱肛等症；清大肠能清热利湿导滞，退肝胆之火。主治湿热滞留肠道、身热腹痛，赤白痢疾、大便秘结等症。

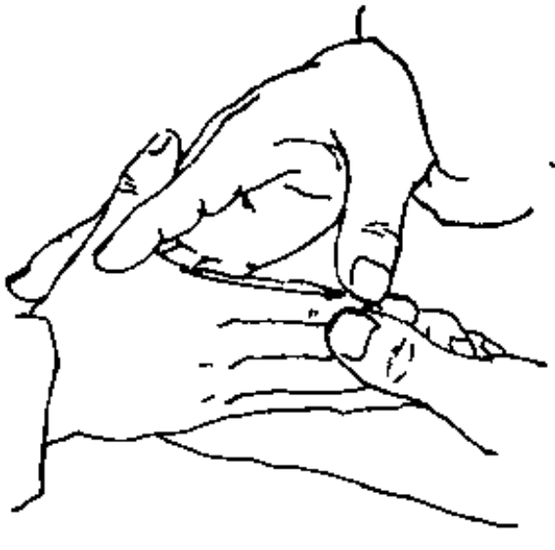

图 109　清大肠

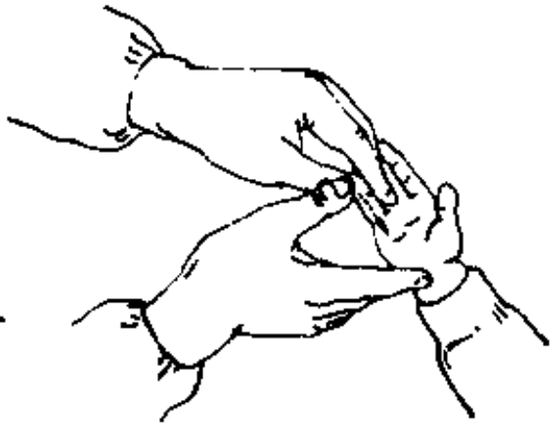

图 110　补小肠

在临床上治疗痢疾、便秘，常用大肠一穴，但需推30分钟左右，才能收到较好的效果。

小　肠

【部位与操作】　在小指尺侧边缘，自指尖至指根成一直线。从指尖向指根方向直推为补，称为补小肠（图110）；反之则为清，称为清小肠。操作100～300次。

【作用与主治】　补小肠能滋阴补虚。主治阴虚水亏、小便短赤、下焦虚寒多尿、遗尿等症。清小肠能清热利尿，泌别清浊。主治小便短赤不利、尿闭、水泻、口舌生疮等症。

肾　顶

【部位与操作】　在小指顶端。医者以拇指或中指端按揉之，称揉肾顶（图111）。揉100～500次。

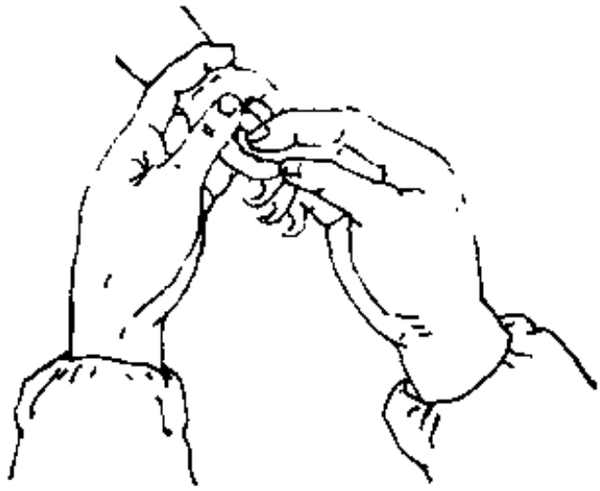

图111　揉肾顶

【作用与主治】　收敛元气，固表止汗。主治自汗、盗汗、解颅、大汗淋漓不止等症。

肾　纹

【部位与操作】　手掌面，小指第2指间关节横纹处。医者以中指或拇指端按揉之，称揉肾纹(图112)。揉100～500次。

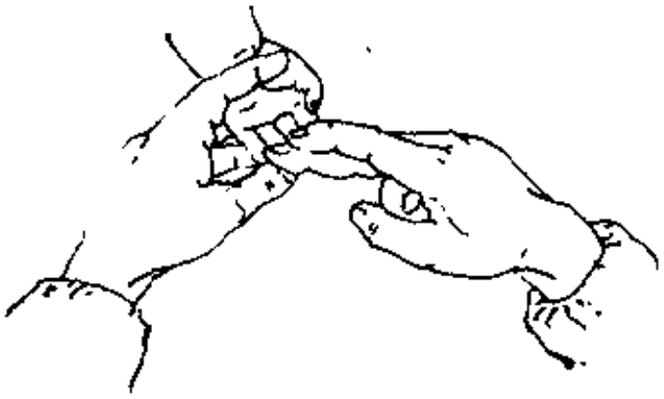

图112　揉肾纹

【作用与主治】　祛风明目，散瘀结。主治目赤肿痛及热毒内陷、郁热不散所致高热、呼吸气凉、四肢逆冷、鹅口疮等症。

掌小横纹

【部位与操作】　在掌面小指根下，尺侧掌纹头。医者以中指或拇指端按揉之，称揉掌小横纹(图113)。揉100～500次。

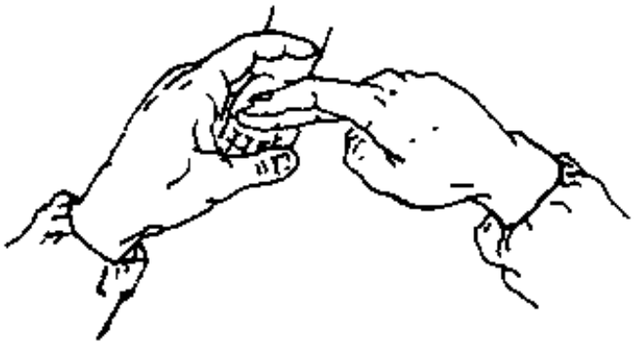

图113　揉掌小横纹

【作用与主治】 清热散结，宽胸宣肺，化痰止咳。主治痰热咳喘、口舌生疮、百日咳、肺炎。临床上用揉掌小横纹治疗肺部湿性罗音，有一定的疗效。

小 横 纹

【部位与操作】 在掌面食、中、无名、小指的掌指关节横纹处（见图 56）。医者用拇指侧自食指或小指的掌指关节横纹处，来回推之，称推小横纹；以拇指甲依次掐之，继以揉之，称为掐小横纹。推 100～300 次；掐 3～5 下。

【作用与主治】 退热，消胀，散结。主治脾胃热结、口唇破裂、口疮、腹胀、发热、烦躁等症。临床上推小横纹治疗肺部干性罗音，有一定疗效。

四 横 纹

【部位与操作】 掌面食、中、无名、小指的第一指间关节横纹处（图 114）。患儿四指并拢，医者以拇指端从食指横纹处推向小指横纹处，称推四横纹；以拇指甲依次掐揉之，称掐四横纹。推 100～300 次；掐 3～5 下。

【作用与主治】 退热除烦，散瘀结。主治疳积、腹胀腹痛、气血不和、消化不良、惊风、气喘、口唇破裂等病症。也可用毫针或三棱针点刺本穴出血以治疗疳积，效果也好。

运 土 入 水

【部位与操作】 手掌面，拇指桡侧经手掌边缘，小指掌面稍偏尺侧至尖端。医者以左手握住患儿之左手手指，使手掌向上，同时拇、食二指捏住患儿拇指，再用右手拇指侧面，自

患儿拇指端循手掌边缘，向上推运至小指端为1遍（图115）。100～300遍。

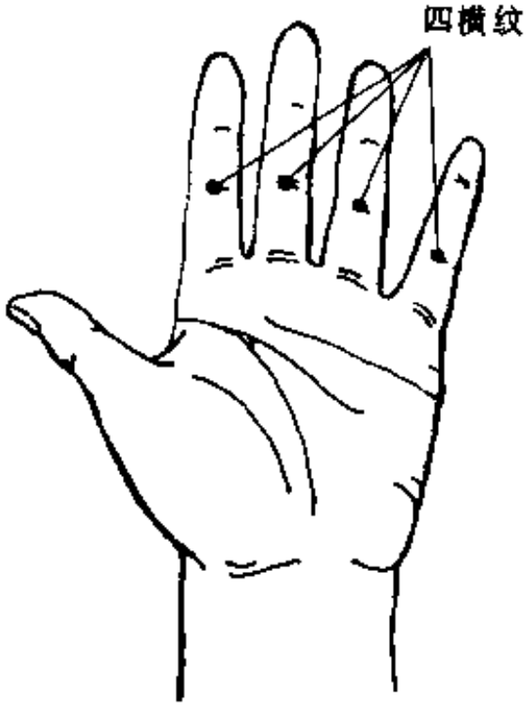

图114　四横纹

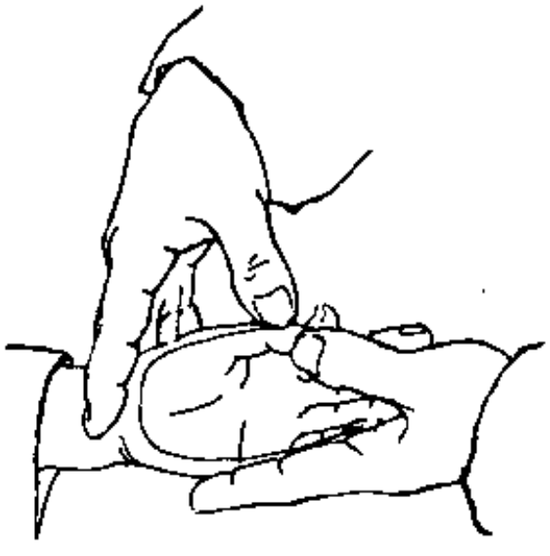

图115　运土入水

【作用与主治】　清脾胃湿热，利尿止泻。用于新病、实证，主治湿热内蕴、少腹胀满、小便短赤、呕吐泄泻、便秘、痢疾等症。

运 水 入 土

【部位与操作】　手掌面，小指尺侧缘沿手掌边缘至拇指桡侧尖端成一弧形曲线。医者左手握住患儿之左手手指，使手掌朝上，用右手拇指侧面，自患儿小指端循手掌边缘，向上推运至拇指端为1遍（图116）。100～300遍。

【作用与主治】　健脾助运，润燥通便。多用于久病、虚证。主治脾胃虚弱、肚大青筋、腹胀、食欲不振、泻痢等症。

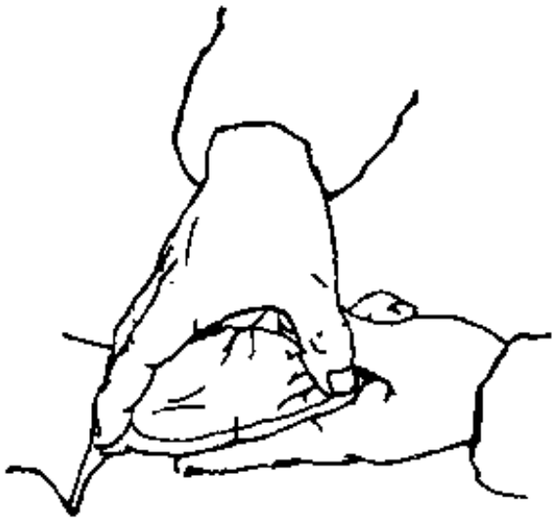

图 116　运水入土

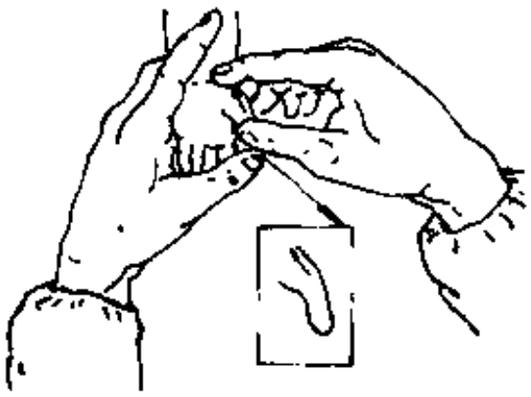

图 117　清胃经

胃　经

【部位与操作】　在大鱼际肌桡侧，赤白肉际处。用拇指或食、中指自掌根推向拇指根，称清胃经（图 117）。100～500 次。

【作用与主治】　清中焦湿热，和胃降逆，泻胃火，除烦止渴。主治恶心呕吐、烦渴善饥、呃逆、嗳气、吐血衄血、食欲不振、腹胀、口臭、便秘等症。

板　门

【部位与操作】　在手掌大鱼际平面。医者用左手托住患儿之左手，再以右手食、中指挟住患儿的拇指，然后用拇指端运之或揉之，称为揉板门或运板门（图 118）；用右手拇指侧面自板门推向大横纹，称板门推向横纹（图 119）；若以右手拇指侧面自大横纹推向板门，又称为横纹推向板门（图 120）。

揉、推各100～300次。

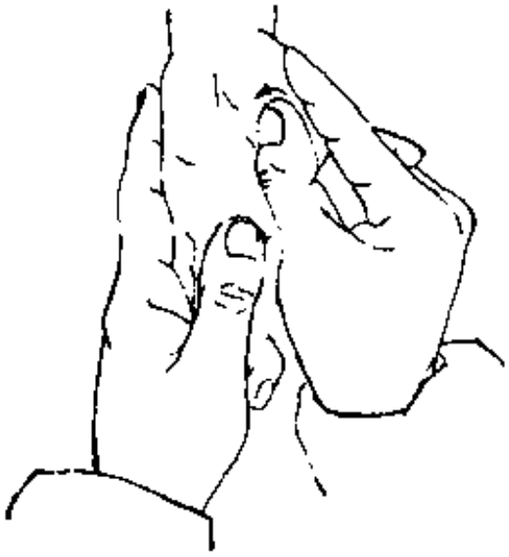

图118　揉板门

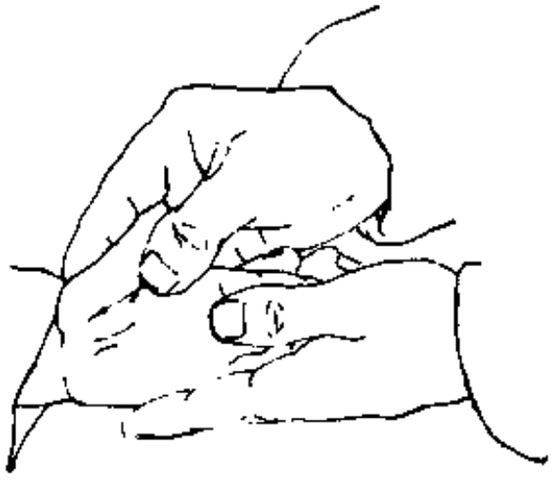

图119　板门推向横纹

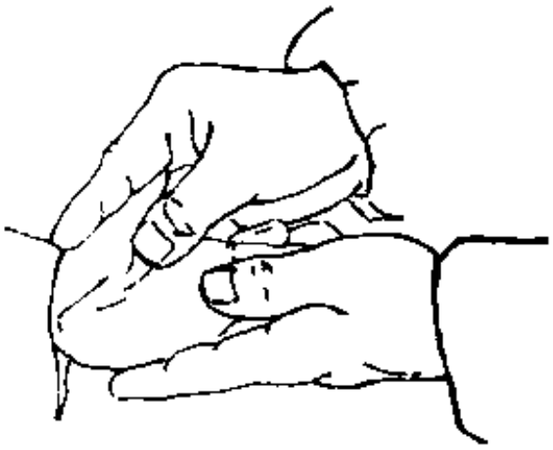

图120　横纹推向板门

【作用与主治】　揉板门能健脾和胃，消食化滞。主治乳食停积、腹胀腹泻、食欲不振、呕吐、嗳气等症。板门推向横纹能止泻。主治乳食停滞引起的腹泻及各种泄泻。横纹推向板

门则能止呕吐。主治胃气上逆而致的各种呕吐，多与推天柱骨配用，加强止呕吐疗效。

内 劳 宫

【部位与操作】 在掌心中，屈指当中指尖之中点。医者以左手握患儿之四指，使手伸直，再以右手食、中二指夹住患儿之拇指，然后以拇指甲掐揉之，称掐揉内劳宫（图 121）；以中指端运之，称运内劳宫。

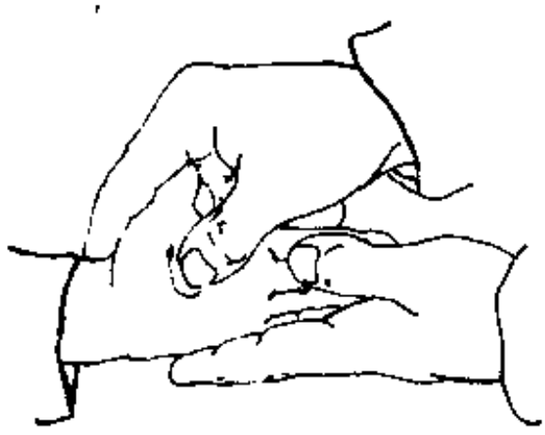

图 121 掐揉内劳宫

【作用与主治】 清热除烦，熄风凉血。主治发热、五心烦热、口舌生疮、烦渴、齿龈糜烂、便血等症。

内 八 卦

【部位与操作】 以掌中心为圆心，从圆心至中指根横纹约 2/3 处为半径，画一圆圈，八卦穴即在此圆圈上（对小天心者为坎，对中指者为离，在拇指侧离至坎半圆的中点为震，在小指侧半圆的中点为兑）共八个方位即：乾、坎、艮、震、巽、离、坤、兑。医者以左手持患儿左手之四指，使掌心向

上，同时拇指按定离卦，再以右手食、中二指夹住患儿之拇指，然后用拇指自乾卦运至兑卦为1遍，称顺运内八卦（图122）；若从兑卦运至乾卦称为逆运八卦（古人认为：在运至离宫时，应从左手拇指上运过，否则恐动离火——心火）。100～500次。

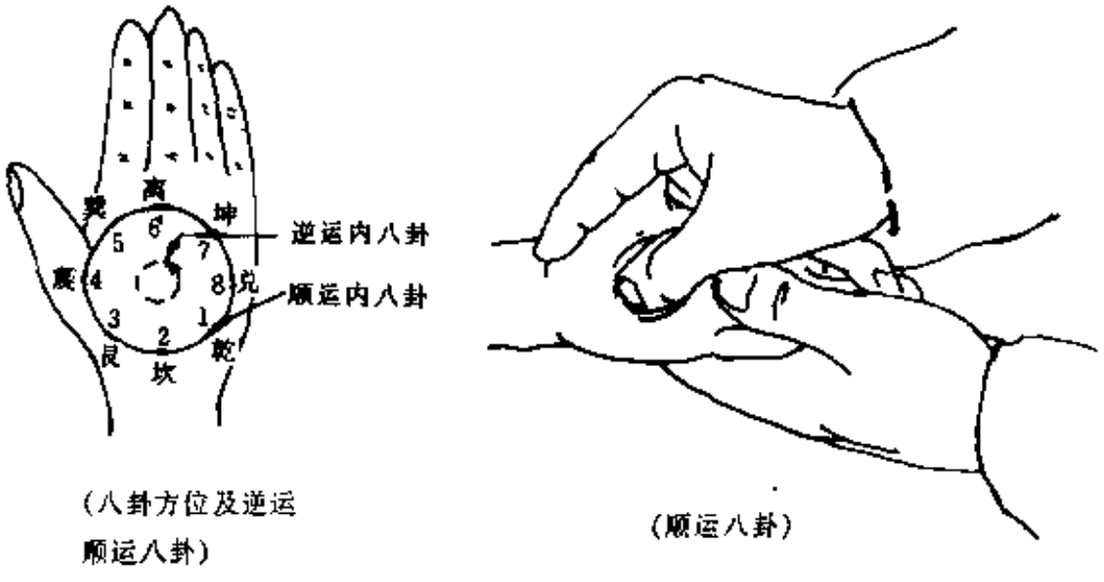

图122　顺运内八卦

【作用与主治】　顺运八卦能宽胸理气，止咳化痰，行滞消食。主治胸闷、咳嗽、气喘、呕吐、腹胀、腹泻、食欲不振等症；逆运八卦能降气平喘。主治痰喘呕吐等症。临床上分运八卦多与顺运或逆运八卦合用。乾震顺运能定魂；巽兑顺运能定魄；离乾顺运能止咳；坤坎顺运能清热；坎巽顺运能止泻；巽坎逆运能止呕；艮离顺运能发汗，揉艮宫能健脾消食。

小　天　心

【部位与操作】　在大小鱼际交接处凹陷中，以中指端揉之，称揉小天心（图123）；以拇指甲掐之，称掐小天心；以中指尖或屈曲的指间关节捣，称捣小天心。揉100～300次；

掐、揞各5～20下。

【作用与主治】 揉小天心有清热、镇惊、利尿、明目之作用。主治目赤肿痛，口舌生疮、惊惕不安、小便短赤等症。揞、掐小天心能镇惊安神。主治夜啼、惊风抽搐等症。若眼上翻者则向下掐、揞；右斜视者向左掐、揞；左斜视者则向右掐、揞。

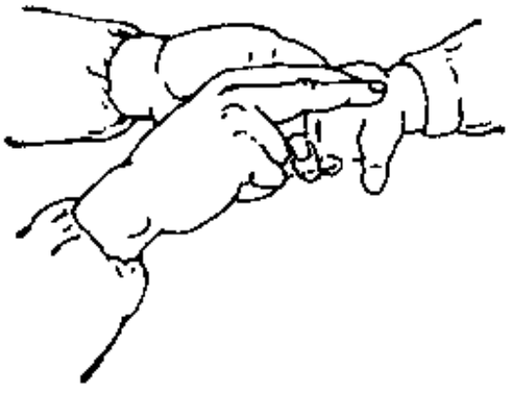

图123 揉小天心

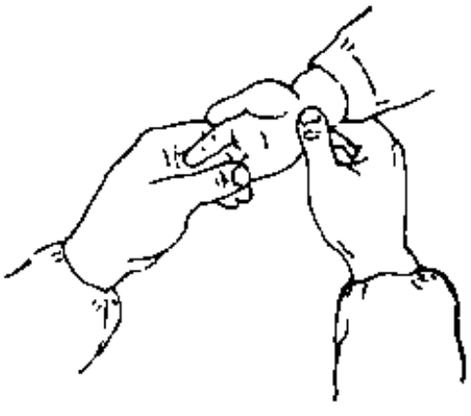

图124 揉总筋

总 筋

【部位与操作】 在掌后腕横纹中点。医者一手握患儿手指，另手拇指甲掐之，称掐总筋；以拇指或中指端揉之，称揉总筋（图124）。掐3～5下；揉100～300次。

【作用与主治】 揉总筋能清心热、散结，通调周身气机。主治口舌生疮、潮热、夜啼、牙痛等症；掐总筋能止痉定惊。主治惊风、四肢抽掣等症。

大 横 纹

【部位与操作】 仰掌，掌后横纹。近拇指端称阳池，近小指端称阴池。医者用两拇指自掌后横纹中（总筋）向两旁分

推，称分推大横纹，又称分阴阳（图 125）。自两旁（阴池、阳池）向总筋合推，称合阴阳。推 30～50 次。

【作用与主治】　分阴阳能平衡阴阳，调和气血，行滞消食。主治寒热往来、烦躁不安、乳食停滞、腹胀、腹泻、呕吐、痢疾等症。若实热证阴池宜重分，虚寒证阳池宜重分。合阴阳能行痰散结。主治痰结喘嗽、胸闷等症。

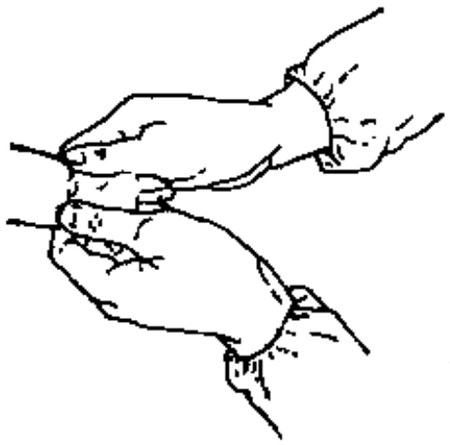

图 125　分推大横纹

图 126　掐老龙

老　龙

【部位与操作】　在中指甲后 1 分处。医者以拇指甲掐之，称掐老龙（图 126）。掐 5 下，或醒后即止。

【作用与主治】　开窍醒神。主要用于急救，主治急惊风，高热抽搐，不省人事。若急惊暴死，掐之知痛有声者易治，不知痛而无声者，一般难治。

十　宣

【部位与操作】　在十指尖端指甲内赤白肉际处（图 127）。医者以左手握患儿之手，使手掌向外，手指向上，再以

右手拇指甲先掐患儿中指，然后逐指掐之，称掐十宣（图128）。各掐3～5下，或醒后即止。

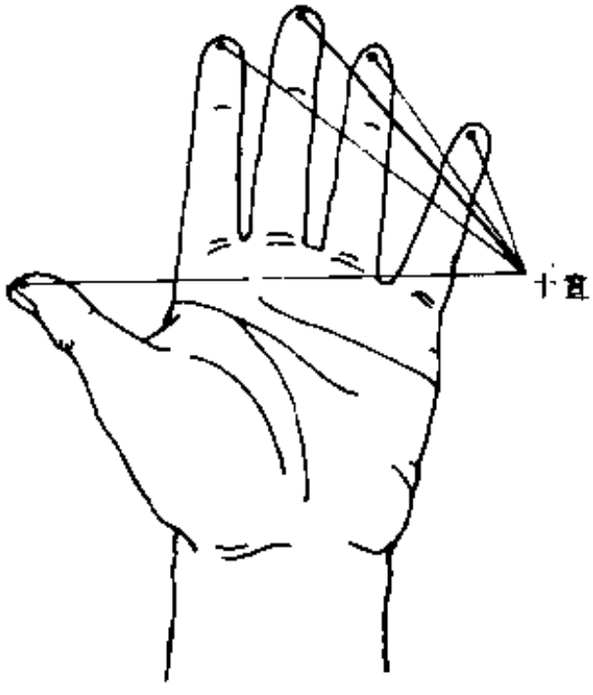

图127　十宣

图128　掐十宣

【作用与主治】　清热，醒神，开窍。主治高热惊风、抽搐、昏厥、两目上视、烦躁不安、神呆等症。多与掐人中、掐老龙、掐小天心等合用。

二　扇　门

【部位与操作】　在手背中指根本节两侧凹陷处。医者以食、中指端揉之，称揉二扇门（图129）；令患儿手掌向下，医者两手食、中二指固定患儿腕，无名指托其手掌，然后用两拇指甲掐之，继以揉之，称掐二扇门（图130）。揉100～500次；掐3～5下。

图 129　揉二扇门

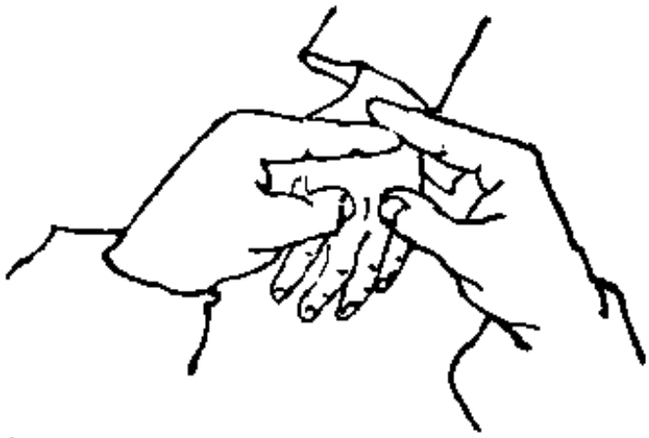

图 130　掐二扇门

【作用与主治】　掐、揉二扇门能发汗透表，退热平喘。主治伤风，感冒，发热无汗，痰喘气粗，呼吸不畅，急惊风，口眼歪斜。

二人上马（上马、二马）

【部位与操作】　在手背无名指及小指掌指关节后陷中。医者以左手握住患儿之左手，使手心向下，再以右手拇指甲掐之，称掐二人上马（图 131）；以拇指端揉之，称揉上马。掐 3～5 下；揉 100～500 次。

【作用与主治】　掐、揉二马能滋阴补肾，顺气散结，利

水通淋，为补肾滋阴之要法。主治虚热喘咳、小便短赤不利、遗尿、脱肛、腹痛、牙痛、睡时磨牙、消化不良等症。

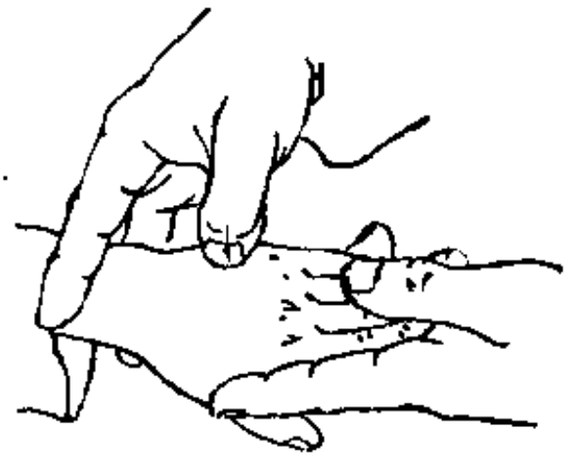

图 131　掐二人上马

图 132　揉外劳宫

外　劳　宫

【部位与操作】　在手背中，与内劳宫相对处。医者用中指端揉之，称揉外劳宫（图 132）；以拇指甲掐之，称掐外劳宫。揉 100～300 次；掐 3～5 下。

【作用与主治】　温阳散寒，升阳举陷，兼能发汗解表。主治腹痛肠鸣、腹泻腹胀、风寒感冒、鼻塞流涕、痢疾、脱肛、遗尿、疝气等症。

五　指　节

【部位与操作】　在手指背面，拇、食、中、无名、小指的第一指间关节处。医者以左手握患儿之左手，使掌面向下，然后用右手拇指甲由小指或从拇指依次掐之，继以揉之，称掐

五指节（图 133）；以拇、食指揉搓之，称揉五指节。掐各 3～5 下；揉搓 30～50 次。

图 133　掐五指节

【作用与主治】　掐、揉五指节能祛风痰，通关窍，安神镇惊。掐五指节主治惊风、惊惕不安；揉五指节主治胸闷、痰喘、咳嗽、风痰、吐涎等症。

威　灵

【部位与操作】　在手背第 2、3 掌骨歧缝间。医者以拇指甲掐之，继以揉之，称为掐威灵（图 134）。5～10 次，或醒后即止。

【作用与主治】　开窍醒神。主治惊风抽搐、昏迷不醒等急症。

精　宁

【部位与操作】　在手背第 4、5 掌骨歧缝间。医者以拇指

甲掐揉之，称掐精宁（图 135）。掐 5～10 次。

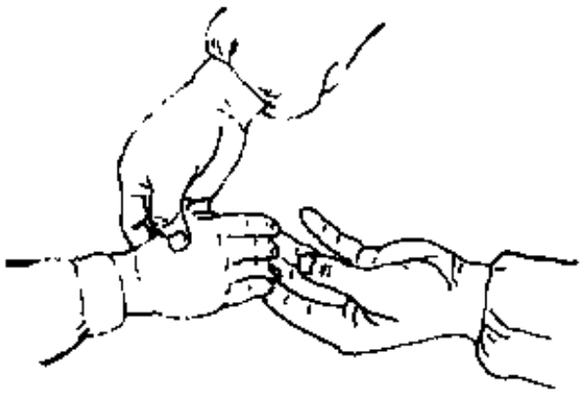

图 134　掐威灵

图 135　掐精宁

【作用与主治】　行气，破结，化痰。主治痰食积聚、气吼痰喘、干呕、痞积及急惊昏厥等症。本法多与掐威灵合用，用于昏迷不醒，以加强开窍醒神之作用。

左　端　正

【部位与操作】　在中指甲根桡侧、旁开 1 分处（见图 58）。以拇指甲掐之或揉之，分别称掐左端正或揉左端正。掐 3～5 下；揉 50～100 次。

【作用与主治】　升提中气，止泻。主治水泻痢疾等病症。

掐之则醒神开窍，主治惊风。

右 端 正

【部位与操作】 在中指甲根尺侧，旁开1分处（赤白肉际处）（见图58）。用拇指甲掐之或揉之，分别称掐右端正或揉右端正。掐3～5下；揉50～100次。

【作用与主治】 止呕吐，降逆，止血。主治胃气上逆而致恶心呕吐、鼻出血等症。临床上掐右端正，多用于小儿惊风，常与掐老龙、清肝经合用。本穴对鼻衄有良效，法用细绳由中指第3节横纹起扎至指端（不可过紧），扎好后患儿静卧。掐之则开窍醒神，用于急救。

合 谷

【部位与操作】 在手背第1、2掌骨之间，近第2掌骨中点的桡侧。医者先以左手握住患儿之左手，使其手掌侧置，桡侧在上，再以右手食、中二指固定患儿之腕部，然后用拇指甲掐之，继以揉之，称掐揉合谷（图136）。掐揉5～20次。

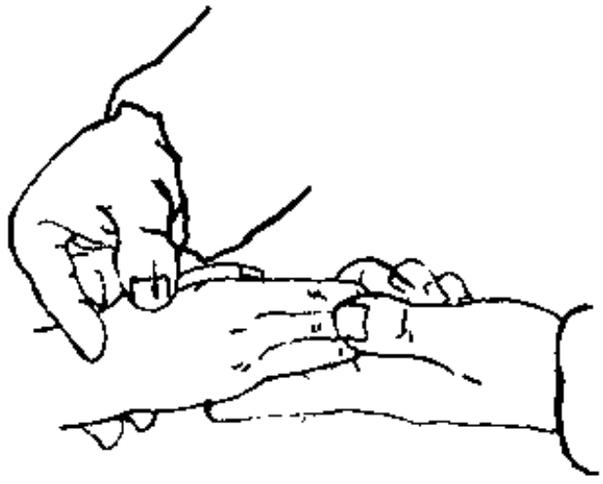

图136 掐揉合谷

【作用与主治】　清热、通络，止痛。主治发热无汗，头痛，项强，面瘫，眼、鼻、口、齿、咽喉痛，口疮，口噤不开，及上肢桡侧病症。

外　八　卦

【部位与操作】　在手背外劳宫周围，与内八卦相对处（见图 58）。医者以拇指做顺时针方向掐运，称运外八卦。100～300 次。

【作用与主治】　宽胸理气，通滞散结。主治胸闷、腹胀、便秘等症。

少　　商

【部位与操作】　在拇指桡侧缘，距指甲角约 0.1 寸。医者以左手握住患儿之左手，使掌面向上，再以右手拇指甲重掐之，称掐少商（图 137）。掐 5～20 下。

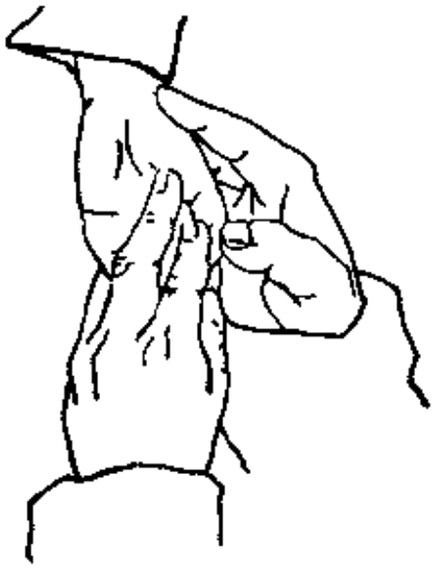

图 137　掐少商

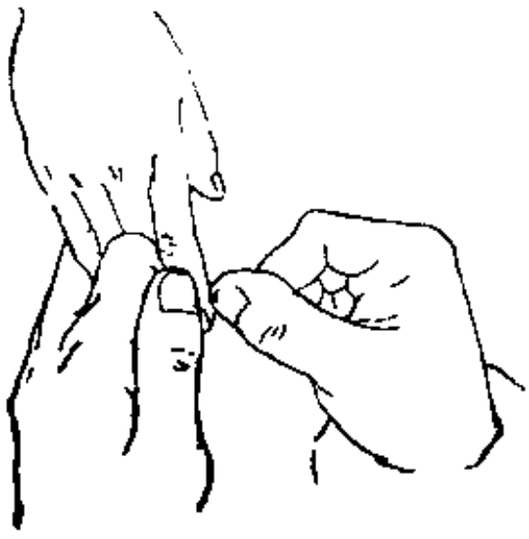

图 138　掐商阳

【作用与主治】　清热利咽，开窍。主治发热、咽喉肿痛、昏迷、呼吸衰竭、窒息、心烦口渴、口疮等症。

商　阳

【部位与操作】　在食指桡侧端，距指甲角约0.1寸。医者以左手握患儿之左手，呈侧掌位，以右手拇指甲重掐之，称掐商阳（图138）。一般掐5～20下。

【作用与主治】　有清热利咽作用。主治发热、咽喉肿痛、耳聋、面肿、口干、喘咳等病症。

中　冲

【部位与操作】　在中指尖端（图139）。医者以左手握住患儿之左手，使掌心向外，中指向上，再以右手拇指甲重掐之，称掐中冲（图140）。一般掐5～20下。

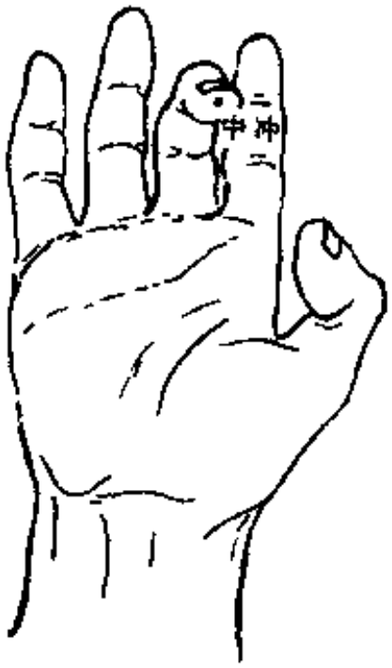

图139　中冲

图140　掐中冲

【作用与主治】　清热，通络，开窍。主治发热烦闷、五心烦热、口疮、弄舌、木舌、心绞痛、中暑、昏迷、舌强不语等症。

关　冲

【部位与操作】　在无名指尺侧端，距指甲角后约0.1寸，属手少阳三焦经。医者以左手握患儿之左手，使掌心向下，以右手拇指甲重掐之，称为掐关冲（图141）。掐5～20下。

【作用与主治】　清热，止头痛，利咽喉。主治发热、头痛、喉痛、结膜炎、语言不利、口干、食少等病症。

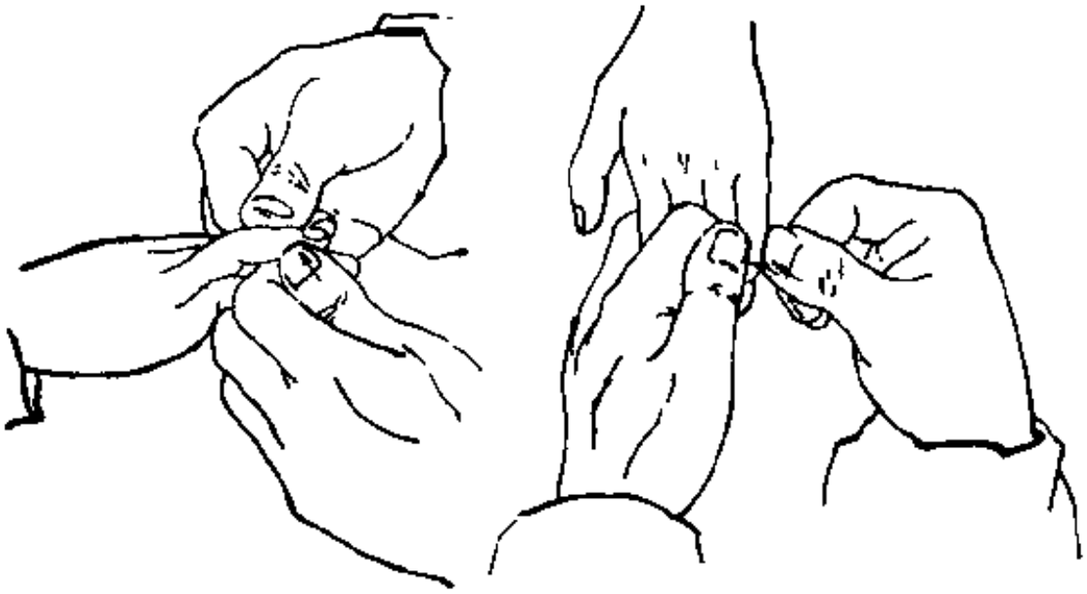

图141　掐关冲　　图142　掐少泽

少　泽

【部位与操作】　在小指尺侧，距指甲角约0.1寸处，属手太阳小肠经。医者以左手握患儿之左手，使掌心向下，以右

手拇指甲掐之，称为掐少泽（图 142）。掐 5～20 下。

【作用与主治】　退热，止惊，通络。主治身热无汗、瘛疭、乳痈、头痛、痰嗽、喉痹、口疮、木舌、重舌等症。

一窝风

【部位与操作】　在手背腕横纹正中凹陷处。医者以中指或拇指端按揉之，称揉一窝风（图 143）。揉 100～300 次。

【作用与主治】　温中行气，止痹痛，利关节。主治受寒、食积引起的腹痛肠鸣、关节痹痛、伤风感冒等症。

图 143　揉一窝风

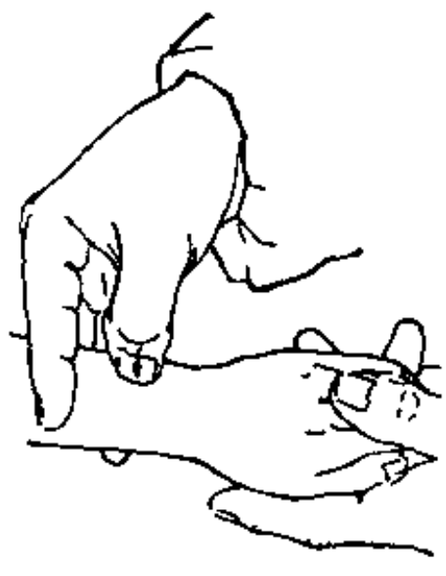

图 144　掐膊阳池

膊阳池

【部位与操作】　在手背一窝风后 3 寸处。医者以左手托住患儿之左手，使掌面向下，再以右手拇指甲掐之，继以揉之，称为掐膊阳池（图 144）；或以中指端揉之，称揉膊阳池。掐 3～5 下；揉 100～300 次。

【作用与主治】　止头痛，通大便，利小便。主治大便秘结、小便短赤、感冒头痛等症。

曲　池

【部位与操作】　屈肘，在肘窝桡侧横纹头至肱骨外上髁中点。属手阳明大肠经。先使患儿屈肘，医者一手托住其腕部不动，另手握住患儿之肘部，以拇指甲掐之，继以揉之，称掐揉曲池（图 145）。30～50 次。

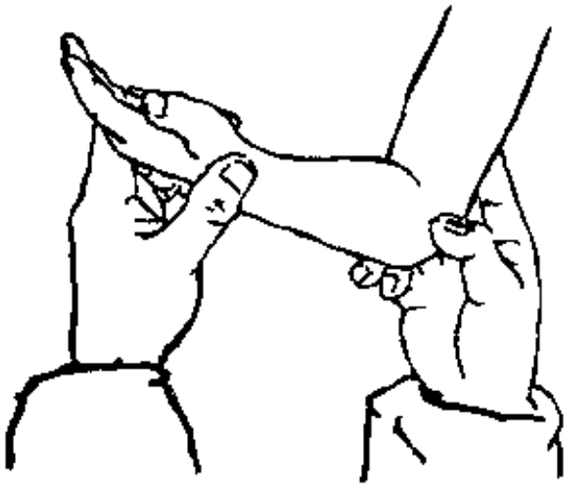

图 145　掐揉曲池

【作用与主治】　有解表退热、利咽等作用。主治风热感冒、咽喉肿痛、上肢痿软、抽掣、咳喘、嗳气、腹痛、呕吐泄泻等症。

洪　池

【部位与操作】　肘关节内侧，肘横纹中点。医者一手拇指按于穴位上，一手拿其四指摇之，称按摇洪池。摇 5～10 下。

【作用与主治】　调和气血，通调经络。主治气血不和、

关节痹痛等症。

肘　　肘

【部位与操作】　在肘关节、鹰嘴突处（见图 58）。医者以左手拇、食、中三指托患儿肘肘，以右手拇、食指二指叉入虎口，同时用中指按小鱼际中点（天门穴），然后屈患儿之手，上下摇之，称摇肘肘。摇 20～30 下。

【作用与主治】　通经活血，顺气生血，化痰。主治气血不和、痹痛、痞块、痰嗽、急惊等症。

拇　　腮

【部位与操作】　在拇指背，距指甲根中点约 1 分许（见图 58）。医者以拇指甲掐之，或以拇指端揉之，称为掐拇腮，或揉拇腮。掐 3～5 下；揉 50～100 次。

【作用与主治】　降逆止呕。主治恶心呕吐。本穴多与推天柱骨、横纹推向板门等合用。

皮罢（肝记）

【部位与操作】　在拇指尺侧，拇指甲根旁开约 1 分处（见图 58）。医者以拇指甲掐之，继以揉之，称掐皮罢。掐 3～5 下。

【作用与主治】　降气平喘，醒神。主治哮喘、神迷等症。

甘　　载

【部位与操作】　在手背合谷后，第 1、2 掌骨交接处凹陷中（见图 58）。医者以拇指端掐之，继以揉之，称掐甘载。掐

5～20 下。

【作用与主治】　开窍醒神。主治昏厥，不省人事，惊风抽搐。本穴多与掐人中、掐十宣等合用。

三　关

【部位与操作】　前臂桡侧，阳池至曲池成一直线。医者以食、中指腹，自腕推向肘，称推三关（图 146）。推 100～500 次。

【作用与主治】　温阳散寒，益气活血，兼发汗解表。主治腹痛腹泻、畏寒、四肢乏力、病后体虚、斑疹白痦、疹出不透及风寒感冒等一切虚、寒病证。

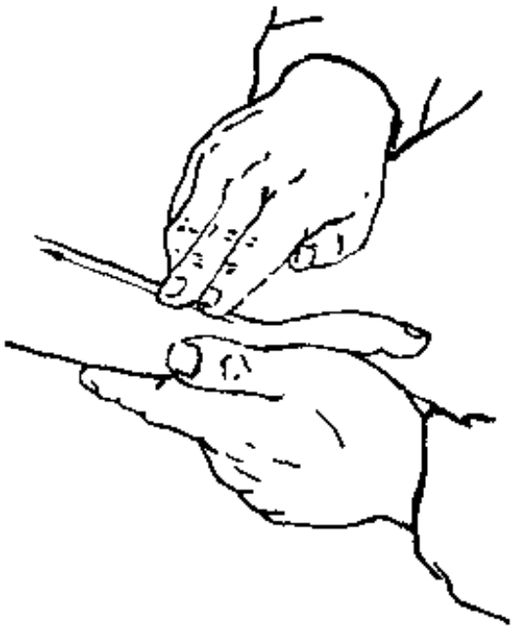

图 146　推三关

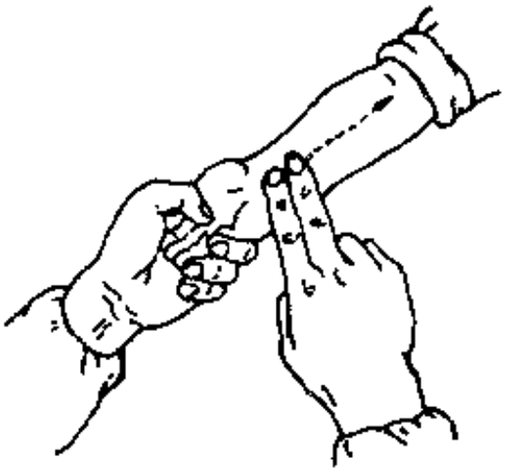

图 147　清天河水

天　河　水

【部位与操作】　前臂内侧正中，腕横纹至肘横纹成一直

线。医者以食、中指腹自腕横纹推向肘横纹，称为清天河水（图 147）。先以运内劳宫法运之，然后屈患儿四指向上，以左手握住，再以食、中二指顶端自内关、间使循天河向上一起一落地打至洪池，称为打马过天河（见图 39）；用食、中指腹，自内劳宫推向肘横纹，称为大推天河水；以凉水滴于大横纹处，用食、中二指腹慢慢推至洪池，再以四指拍之，并用口吹气于天河穴透之，又称为引水上天河。操作 100～500 次。

【作用与主治】　清热解表，泻心火，除烦躁，润燥结。主治一切热症、外感发热、内热、潮热、烦躁不安、口渴、弄舌、重舌、惊风、口舌生疮、咳嗽、痰喘、咽痛等症。

本穴性微凉，清热而不伤阴，虚、实热皆可用，善清卫分、气分之热。由于操作法不同，清热的作用也不同，大推天河水解热作用大于清天河水，引水上天河大于大推天河水，打马过天河清热之力最强。临床上清天河水最常用。

六　腑

【部位与操作】　前臂尺侧缘，腕横纹至肘横纹成一直线。医者以左手握其腕部，用另一手拇指腹或食、中指面自肘横纹推向腕横纹，称为推六腑或退六腑（图 148）。推 100～300 次。

【作用与主治】　清热凉血解毒。主治高热、烦渴、惊风、鹅口疮、木舌、重舌、咽痛、痄腮、大便秘结干燥等一切实热病症。

本穴性寒凉，善清营、血分之热。若患儿平素大便溏薄，脾虚腹泻者，慎用本法。

图 148　推六腑

第六节　下肢部穴位

箕　门

【部位与操作】　在大腿内侧，膝盖上缘至腹股沟成一直线。让患儿仰卧，将腿伸直，医者位于患儿身旁，一手扶儿之膝；另手食、中二指并拢，自膝关节内侧向上推至腹股沟，称为推箕门（图 149）。推 100～300 次。

【作用与主治】　有助于膀胱气化、利尿作用。主治尿潴留（癃闭）、水泻、小便赤涩不利等症。

膝　眼

【部位与操作】　在膝盖骨之下两旁凹陷中，让患儿下肢伸直，医者以右手拇、食二指相对用力拿之，继以揉之，称拿膝眼（图 150）。拿 5～10 次。

【作用与主治】　止惊，通络。主治惊风抽搐、下肢痿软、膝关节疼痛及功能障碍等病症。

图 149　推箕门

图 150　拿膝眼

百　虫　窝

【部位与操作】　膝上内侧，股骨内缘，血海穴上 1 寸处。医者以拇指按之，称按百虫；以拇指端揉之，称为揉百虫(图 151)；拿之称拿百虫。按 0.5～1 分钟；揉 30～50 次；拿 3～5 次。

【作用与主治】　有通经络、止抽搐之作用。主治下肢痿软、瘫痪、痹痛及四肢抽搐等症。

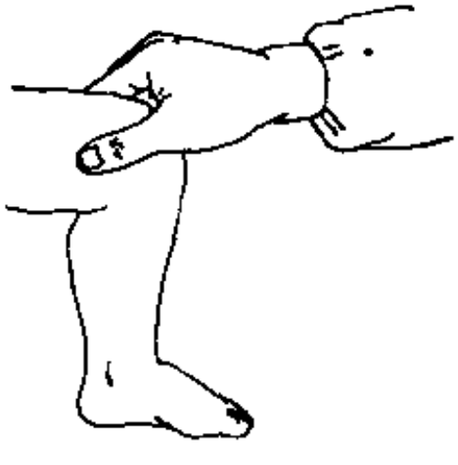

图 151　揉百虫

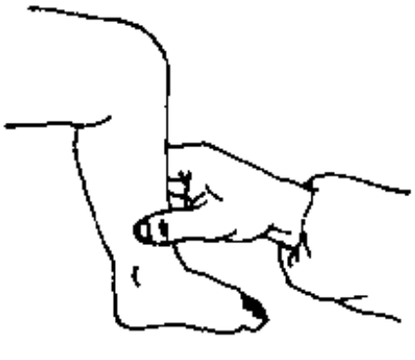

图 152　按揉三阴交

三 阴 交

【部位与操作】 内踝上 3 寸处。医者以拇指端或食指端按揉之，称按揉三阴交（图 152）。操作 100～200 次。

【作用与主治】 有疏利下焦、通调水道、通血脉、活经络、利湿热及健脾胃、助运化等作用。主治癃闭、遗尿、小便频数、短赤不利、下肢痹痛、惊风及消化不良等病症。

解 溪

【部位与操作】 在踝关节横纹之中点，两筋之间凹陷处，属足阳明胃经。医者以拇指端揉之，称为揉解溪（图 153）；以拇指甲掐之，称为掐解溪。揉 50～100 次；掐 3～5 下。

【作用与主治】 有舒筋活络、解痉、止吐泻等作用。主治踝关节伤筋、踝关节屈伸不利、惊风及吐泻等病症。

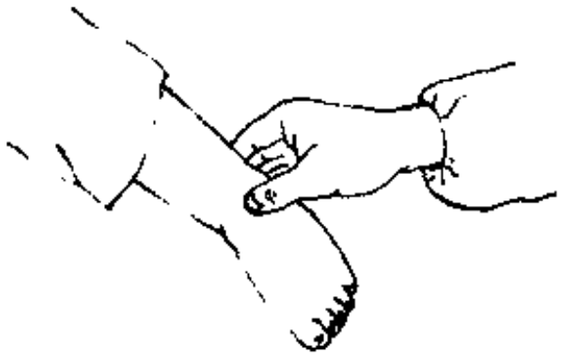

图 153 揉解溪

图 154 揉足三里

足 三 里

【部位与操作】 外膝眼（犊鼻穴）下3寸，胫骨前嵴外1横指处。医者以拇指端按揉之，称为揉足三里（图154）。一般揉30～50次。

【作用与主治】 有健脾胃、助运化、疏调胃肠功能、强壮身体等作用。主治脘腹胀满、腹痛肠鸣、呕吐腹泻、食欲不振、大便秘结、面黄肌瘦、慢脾风及喘促、痰多等病症。

前 承 山

【部位与操作】 外膝眼下8寸（上巨虚下2寸），距胫骨前嵴1横指处。医者以拇指甲掐之或拿之，称为掐前承山或拿前承山（图155）；以拇指端揉之，称揉前承山。掐3～5下；揉50～100次；拿0.5～1分钟或3～5次。

【作用与主治】 止惊，舒筋，通络。主治急惊、抽搐、角弓反张、腓肠肌痉挛及关节疼痛等病症。

图155 拿前承山

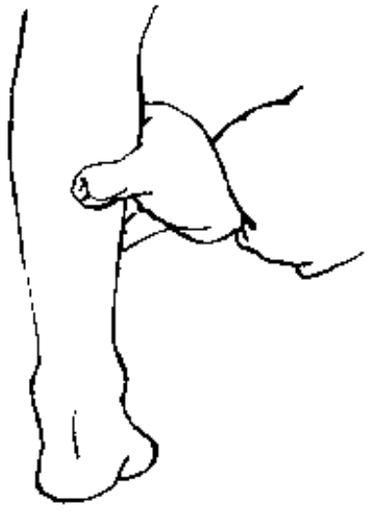

图156 拿后承山

后 承 山

【部位与操作】 在腓肠肌腹（腿肚）下凹陷中（人字纹处），与前承山相对。医者以右手拇指拿之，称拿后承山（图156）；以拇指端揉之，称揉承山。拿5～10次；揉50～100次。

【作用与主治】 止抽搐，通经络。主治惊风抽搐、腿痛转筋、下肢痿软、腰痛、痹痹、腘筋挛急、腹泻便秘等病症。

临床上患儿大便秘结时，可下推承山；腹泻者可上推承山。

委 中

【部位与操作】 在腘窝中央，两大筋中间。医者以拇、食指端提拿钩拨腘窝中筋腱，称拿委中（图157）。一般拿3～5次。

【作用与主治】 有止惊、通络等作用。主治惊风抽搐、下肢痿软及痹痛、腰背部疼痛等症。

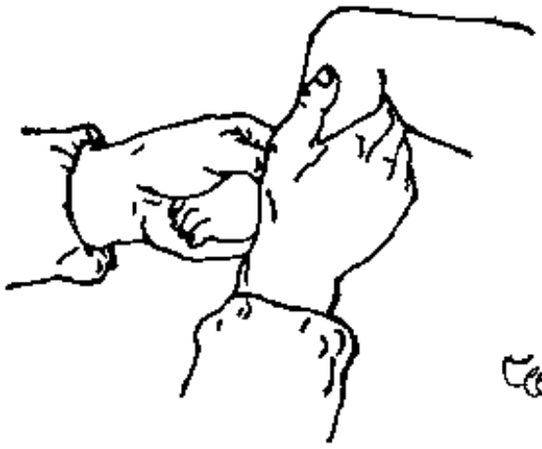

图157 拿委中

图158 拿昆仑

昆　仑

【部位与操作】　在外踝后缘与跟腱内侧的中间凹陷处。医者以拇指甲掐之，称掐昆仑；以拇、中指相对用力拿之，称拿昆仑（图 158）。掐 3～5 下，拿 0.5～1 分钟或 3～5 次。

【作用与主治】　止惊，通络。主治惊风，抽搐，项强及踝部疼痛等病症。

涌　泉

【部位与操作】　屈趾，足掌心前正中凹陷中。医者用拇指腹向足趾方向直推，称推涌泉；用指端揉，称揉涌泉（图 159）。推、揉各 50～100 次。

【作用与主治】　推涌泉能引火归元，退虚热。主治五心烦热、烦躁不安等症。揉涌泉能止吐泻。主治呕吐、腹泻等病症。

临床上左揉涌泉止吐；右揉止泻。

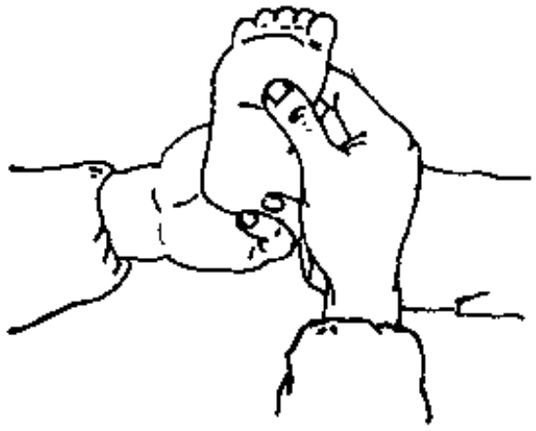

图 159　揉涌泉

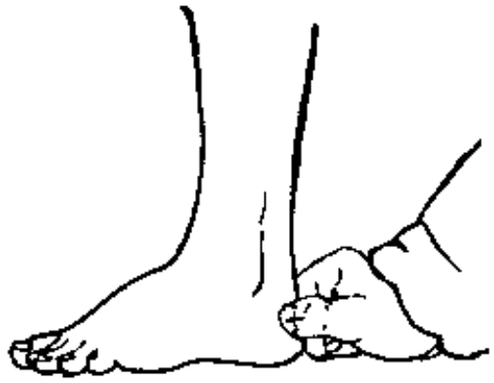

图 160　拿仆参

仆　参

【部位与操作】　在足跟外踝下凹陷中。医者用拿法拿之，称为拿仆参（图 160）。一般拿 3～5 次，或醒后即止。

【作用与主治】　有醒神开窍之作用。主治昏厥，惊风等病症。

第四章　常见病症治疗

第一节　消化系统病症

腹　　泻

腹泻是指小儿大便次数增多，粪便稀薄，甚至如水样便。尤以3岁以下的婴幼儿多见，多发于夏、秋季节。该病相当于现代医学的消化不良，年龄越小发病率越高，若腹泻日久不愈，常导致营养不良，影响健康发育。推拿治疗本病，疗效显著，一般1～3次即可全愈。

【病因病机】

该病主要是由于感受风、寒、暑、湿之邪，寒湿困脾，脾失健运，水谷下趋大肠；或内伤乳食，饥饱无度，脾胃损伤，不能腐熟水谷；或素体脾胃虚弱，水谷不得运化，水反而为湿，谷反而为滞，水谷留滞，下趋肠道而致腹泻。

【临床表现】

1. 寒湿泻　大便清稀多沫，色淡不臭，肠鸣腹痛，口不渴，小便清长，面色淡白。舌苔白腻或薄白，脉濡，指纹色红。

2. 伤食泻　腹泻腹胀，泻前哭闹，泻后痛减，大便量多味酸臭，伴纳呆，口臭，腹痛，呕吐酸馊。苔厚或垢腻，脉滑。

3. 湿热泻　腹痛即泻，急迫暴注，色黄褐热臭，伴身热，口渴，小便黄赤。舌苔黄腻，脉象滑数，指纹色紫。

4. 脾虚泻　久泻不愈，或经常反复发作，面色苍白，食欲不振，大便挟有不消化奶块及食物残渣，或食后即泻。舌质淡红，苔薄白，脉象细弱，指纹色淡。

5. 惊吓泻　受惊后即泻，便色青，昼则惊惕，夜则哭闹不安或紧依母怀，毛发竖立，山根色青。苔薄白，脉弦或乍来乍数，指纹色青。

【处方配穴】

1. 寒湿泻　治以温中散寒，化湿止泻。补脾经，补大肠，推三关，揉外劳宫，摩腹，揉脐（补法），推上七节骨，揉龟尾，揉足三里。

2. 伤食泻　消食导滞，和中助运。补脾经，揉板门，运内八卦，摩中脘，摩腹，按揉足三里，揉天枢，清大肠，揉龟尾。

3. 湿热泻　治以清热利湿，调中止泻。清脾经，清胃经，清大肠，清小肠，退六腑，推下七节骨、揉天枢，揉龟尾。

4. 脾虚泻　健脾益气，温阳止泻。补脾经，补大肠，摩腹（补法），揉脐（补），推三关，揉百会，推上七节骨，揉龟尾，捏脊。

5. 惊吓泻　治以止惊，健脾，止泻。平肝经，掐揉五指节，揉、掐小天心，补脾经，补大肠，摩腹（平补平泻），推上七节骨，揉龟尾。若久泻不止者，加揉脐及龟尾并擦七节骨。

每日治疗1次，3次为一疗程。

【病案举例】

例1　胡媛，男，1岁。1995年8月2日初诊。

主诉：大便稀薄，挟有奶块15天。

病史：患儿于半月前因过食鸡蛋后引起腹泻，每日6～7次，便稀，挟有大量奶块及不消化食物，泻前哭闹，泻后则安，伴嗳气，食欲不振。曾服用婴儿素等治疗，效果不佳来诊。

查体：发育营养佳，腹胀如鼓，大便量多，味酸臭，口臭，舌苔白厚腻。大便常规：脂肪球少许。

诊断：腹泻（伤食型）。

治疗：按伤食泻处方治疗1次后，次日大便1次，腹胀、嗳气等症状消失。1周后随访，病愈。未复发。

例2　王芳，女，7个月。1996年8月15日初诊。

主诉：腹泻1个月。

病史：患儿于1月前原因不明发生腹泻，日行5～8次，大便稀薄挟有不消化食物残渣及少量粘液，食后即泻，有时失气即泻。曾到市某医院就诊为“肠炎”，给予口服PPA、庆大霉素静滴5天后，效果不显，仍每日腹泻5～6次，伴食欲不振，睡眠不佳，前来就诊。

查体：体温正常，面色萎黄，肌肉消瘦，皮肤弹性可，轻度腹胀，指纹色淡红。化验大便：白细胞（++）。

诊断：腹泻（脾虚型）。

治疗：按拟定处方治疗1次后，大便每日2次，饮食好转；当连续治疗3次后，大便每日1次，余症消失，大便常规检查正常。1周后随访，病愈。未再复发。

呕　吐

呕吐是由于胃气上逆，胃或肠道呈逆行蠕动所致。本病为小儿常见症状，可见于多种疾病中。小儿胃脏娇嫩，贲门松弛，如果喂养不当，吸入过多空气，出现乳后有少量乳汁倒流口腔，从口角溢出，称为溢乳，不属病态。此外呕吐又是某些急腹症的先兆症状，消化道畸形也可发生呕吐，不属本病论述的范围。

【病因病机】

若乳母过食寒凉生冷之物，以致乳汁寒薄，或小儿过食瓜果冷食，凝滞胃脘；或过食辛热之品，感受温热暑湿之邪，蕴结于胃脘；或乳食不节，过食肥甘，积滞于中脘；或因跌扑惊恐，气机逆乱，以致损伤脾胃，运化失司，胃失和降，气逆于上而发生呕吐。

【临床表现】

1．寒吐　饮食稍多即吐，吐物酸臭不甚，时作时止，四肢不温，腹痛喜暖，面色苍白，伴大便溏薄，小便清长。舌质淡，苔薄白，指纹色红，脉迟或沉细。

2．热吐　食入即吐，呕吐物酸臭，身热口渴，烦躁不安，大便秘结或大便臭秽，小便短赤，唇干少津。舌红，苔黄腻，指纹色紫，脉象滑数。

3．伤食吐　吐物酸馊，腹胀腹痛，厌食胸闷，嗳气，口气臭秽，大便酸臭。舌苔厚腻，脉象滑。

4．惊恐吐　受惊后呕吐暴作，或频吐清涎，神态紧张，昼则惊惕，夜卧不宁，山根色青，指纹色青。脉乍来乍数。

【处方配穴】

1. 寒吐　温中散寒，和胃降逆。补脾经，摩、揉中脘，推天柱骨，横纹推向板门，掐揉右端正，揉外劳宫，推三关，掐揉拇腮。

2. 热吐　清热和胃，降逆止呕。清脾经，清胃经，清大肠，退六腑，清天河水，推天柱骨，横纹推上板门，推下七节骨。

3. 伤食吐　消食导滞，和中降逆。运板门，补脾经，运内八卦，揉中脘，分腹阴阳，揉足三里，推天柱骨，横纹推向板门，揉右端正。

4. 惊恐吐　镇惊止吐。揉小天心，清肝经，掐五指节，分手阴阳，补脾经，运内八卦，推天柱骨，掐右端正，横纹推向板门，按揉百会。

【病案举例】

李某，男，1岁。1996年7月22日初诊。

主诉：呕吐1天。

病史：患儿于昨日由于喂奶后又添加鸡蛋等食物，翌日清晨起床后发生呕吐2次，吐物酸腐臭秽，伴嗳气，纳呆，大便量多味酸臭，前来就诊。

查体：患儿发育营养一般，体温正常，神清，腹胀，舌苔白厚腻，指纹稍紫，脉象滑。

诊断：呕吐（伤食吐）。

治疗：按拟定方法治疗1次后呕吐停止，次日巩固治疗1次，病愈。未再呕吐。

厌　食

厌食是指小儿较长时期不欲食物，甚至拒食的一种病症。

日久则精神疲惫，体重减轻，抗病能力低下，影响小儿的生长发育，故应及时治疗。本病多发于1～6岁小儿。

【病因病机】

由于平素饮食不节，喂养不当，如片面强调给予高营养的滋补食品，养成偏食习惯，以致损伤脾胃。脾主运化，胃主受纳，脾虚则运化失职，胃虚则不思饮食。

【临床表现】

1．脾胃虚弱　不欲纳食，甚至拒食，面色萎黄，形体偏瘦，精神疲惫，全身乏力，倦怠懒言，易出汗，大便挟有不消化食物残渣。舌质淡，苔薄白，指纹色淡，脉象虚弱或细而无力。

2．胃阴不足　不欲进食，口干，手足心热，大便秘结，小便短而黄赤，皮肤干燥缺乏润泽。舌质红或光红少津，无苔或少苔，脉细或细数，指纹色淡紫。

【处方配穴】

1．脾胃虚弱　治宜健脾胃，助运化。补脾经，运内八卦，摩中脘，摩腹，按揉脾俞，揉胃俞，推三关，捏脊，揉足三里。

2．胃阴不足：治宜滋养胃阴。补脾经，补胃经，运板门，运内八卦，揉二马，运内劳宫，揉脾俞，揉胃俞，清大肠，清天河水。

每日治疗1次，3次为一疗程。可连续治疗1～3个疗程。

【病案举例】

白某，男，2岁。1995年8月17日初诊。

主诉：不思食物30天。

病史：患儿于1个月前因过食肥甘食物后，出现食欲不

振，伴腹胀，曾服消食片、山楂丸等治疗，效果不佳。近日来厌恶食物，口干欲饮，大便每隔两日1次，小便黄赤，睡眠不宁来诊。

查体：患儿体温正常，口唇干燥少津，腹部叩诊呈鼓音，手足心热。舌质红，少苔，脉象细数，指纹色淡紫。

诊断：厌食（胃阴不足型）。

治疗：给予补脾经，运板门，运内八卦，揉二马，摩腹，清天河水，清大肠，揉足三里，揉脾俞，揉胃俞，捏脊。每日1次，当治疗1次后，次日能食少量食物，腹胀减轻；治疗3次后，食物基本正常，腹胀消失，二便调，睡眠佳。为巩固疗效，又连续治疗3次，诸症消失，病愈。1月后随访，饮食正常，体重增加。

腹　痛

腹痛是临床上小儿常见症状，可见于多种疾病中。本节主要是指腹部受寒，乳食停滞所引起的腹部绞痛而言。小儿急腹症指征的腹痛除外。

【病因病机】

由于护理不当，气候突变，小儿腹部受风寒所侵；或乳食不节，暴饮暴食，过食肥甘，停滞中焦，气机受阻；或素体脾胃虚弱，久病脾虚，脾阳不振，寒湿留滞，气血不能濡养；或感染蛔虫，虫多扭结成团，气机阻滞而致腹痛。

【临床表现】

1. 寒痛　受凉或饮食生冷后发生腹痛，哭叫不安，遇冷痛甚，得热痛减，伴大便清稀，小便清长，手足不温。舌苔薄白，指纹色赤。

2. 伤食痛　腹部胀满作痛，伴嗳腐吞酸，食欲不振，矢气频作，大便量多或便秘。舌苔厚腻，脉象滑。

3. 虚寒腹痛　腹痛隐隐，喜温喜按，面色萎黄，形体消瘦，乏力懒言，食欲不振，或便稀。舌淡，苔薄白，指纹色淡，脉象虚弱。

4. 虫痛　腹痛突然发作，以脐周为甚，时作时止，或嗜食异物，夜间磨牙，有时在腹部摸到蠕动之块状物，时隐时现，面部有虫斑，巩膜有蓝点或蓝斑，有便虫病史。甚至蛔虫窜到胆道则痛如钻顶，时作时止，伴有呕吐。

【处方配穴】

1. 寒痛　温中散寒，理气止痛。补脾经，揉外劳宫，推三关，揉一窝风，摩腹，拿肚角。

2. 伤食痛　消食导滞，和中止痛。补脾经，运板门，运内八卦，揉中脘，摩腹，揉足三里，揉天枢，清大肠，分腹阴阳，拿肚角，揉一窝风。

3. 虚寒腹痛　宜温补脾肾，理气止痛。补脾经，补肾经，推三关，揉外劳宫，揉中脘，揉足三里，揉一窝风，捏脊。

4. 虫痛　温中行气，安蛔止痛。揉一窝风，推三关，揉外劳宫，摩腹，揉脐，拿肚角，按脾俞，按胃俞，按足三里。

每日1～2次，3～6日为一疗程。

【病案举例】

许某，男，4岁。1996年4月5日初诊。

主诉：腹部隐隐作痛3天。

病史：患儿平素饮食不佳，偏食，3日前腹部疼痛，痛时喜按，时作时止，每日发作5～6次，每次持续3～5分钟。曾到省某医院就诊，给予口服颠茄酊、普鲁本辛等治疗，效果不

佳，症状如故。前来就诊。

查体：患儿面色萎黄不华，精神疲惫，乏力懒言，肌肉偏瘦，腹软，肝脾无肿大，上腹部正中轻度压痛。舌质淡，苔薄白，指纹色淡，脉象细弱。

诊断：腹痛（虚寒型）。

治疗：按拟定方法，每日施术1次，嘱其停服西药，当治疗2次后，腹痛减轻，每日发作1～2次，又连续治疗2次，腹痛停止。1周后随访，病情稳定，未复发。

疳　积

疳积是疳症和积滞的总称。积滞与疳症有轻重程度的不同，在临床中往往二者并见。

积滞是指小儿内伤乳食，停滞不化而形成的一种慢性消化功能紊乱的综合征。以不思饮食、肌肉消瘦、大便不调为特征。

疳症是指小儿饮食失调，喂养不当，脾胃损伤，运化失职，病程缓慢的一种病症。以形体消瘦、毛发枯疏、腹大青筋、神疲乏力为特征。

积滞进一步发展而成疳，所以古人有“无积不成疳，积为疳之母”之说。

疳积与现代医学所说的“小儿营养不良”相类似。多由于小儿摄食不足或摄入食物不能充分吸收的结果。

【病因病机】

小儿乳食不节，过食肥甘，伤及脾胃，脾胃失司，受纳运化失职，升降失调，乃成积滞。积滞日久，脾胃更伤，转化为疳。或小儿脾胃虚寒薄弱，则乳食难于腐熟，使乳食停积中

焦，阻碍气机，日久致使营养失调，患儿羸弱，气液虚衰，发育障碍。另外，感染虫积和某些慢性疾病，也可导致本病。

【临床表现】

1．积滞伤脾　形体消瘦，体重不增，腹部胀满，纳食不香，精神不振，夜寐不安，大便不调常有恶臭。舌苔厚腻，脉象滑，指纹色淡略紫。

2．气血两亏　面色萎黄或㿠白，毛发枯黄稀疏，骨瘦如柴，精神萎靡，睡卧不宁，啼声低弱，四肢不温，腹部凹陷，大便溏泻，发育障碍。舌质淡红，苔薄白，指纹色淡，脉象沉细无力。

【处方配穴】

1．积滞伤脾　宜消积导滞，调理脾胃。补脾经，运板门，推四横纹，运内八卦，揉中脘，分腹阴阳，揉天枢，揉足三里，猿猴摘果。

2．气血两亏　补益气血，温中健脾。补脾经，推三关，揉外劳宫，运内八卦，掐揉四横纹，按揉足三里，揉中脘，揉脾俞，揉胃俞，捏脊，摇肘肘（见图 43）。

每日 1 次，6 次为一疗程。可连续治疗 2～3 个疗程。

本病也可单用捏脊法配合针刺四横纹治疗，隔日 1 次，或每周治疗两次，亦有很好的效果。

【病案举例】

杨某，男，2 岁半。1995 年 5 月 2 日初诊。

主诉：不思饮食，肚大青筋显露，形体消瘦年余。

病史：患儿于 1 年前开始出现食欲不振，大便稀伴腹胀，夜卧不宁，曾服用婴儿素、王氏保赤丸等药治疗，无明显效果。近来形体逐渐消瘦，体重不增，头发稀疏，来诊。

查体：患儿发育、营养欠佳，面色萎黄，口唇、指甲淡白无华，手足不温，腹部胀大，青筋显露，肝脾未及，肌肉瘦削，骨瘦如柴，精神萎靡，身高、体重均低于同龄儿。舌质淡红，苔薄白，指纹淡红，脉象沉细无力。

诊断：疳积（气血两虚型）。

治疗：按拟定方法每日治疗1次，治疗2次后，饮食较前进步，腹胀减轻，大便已不稀，睡眠佳。当连续治疗12次后，饮食明显改善，体重增长1.5公斤，二便调。为巩固疗效，继守法隔日1次，共治疗24次后，面色红润有光泽，精神佳，饮食培增，余症基本消失。再单用捏脊法，每日1次，每次施术5～6遍，又连用1个月停止治疗。半年后随访，体重、身高、智商均达到同龄健康儿童水平。

便　秘

便秘是指大便秘结不通，排便时间延长，或欲解大便而坚涩不畅，排便困难，或2～3天以上不大便者，皆称为便秘。

【病因病机】

饮食不节，过食辛热厚味，以致肠胃积热，气滞不行，或热病后耗伤津液，导致肠道燥热，津液失于输布而不能下润，则排出困难；或先天不足，身体虚弱，病后体虚，气血亏损，气虚则大肠传送无力，血虚则津少不能滋润大肠，以致大便难以排出。

【临床表现】

1．实秘　大便干结，面赤身热，口臭唇赤，胸胁痞满，纳食减少，腹部胀痛，小便短赤。舌质红，苔黄腻或黄燥，脉象滑数，指纹色紫。

2. 虚秘　大便努挣难下，面色㿠白无华，形瘦乏力，神疲懒言，颜面汗出或自汗。舌质淡红，苔薄白，指纹色淡，脉象沉细无力。

【处方配穴】

1. 实秘　清热通便，顺气行滞。清大肠，运内八卦，退六腑，按揉膊阳池，摩腹（泻法），揉天枢，揉足三里，推下七节骨，搓摩胁肋。

2. 虚秘　益气养血，滋阴润燥。补脾经揉二马，清大肠，推三关，按揉膊阳池；揉肾俞，按揉足三里，捏脊。

每日1次，3～6次为一疗程。

【病案举例】

张某，女，3岁。1995年9月4日诊。

主诉：大便秘结10天。

病史：患儿于10天前出现大便干结难下，伴腹胀腹痛，食欲不振，每隔2～3日排便1次，且便质坚硬难排，色黑。曾在家口服蜂蜜等治疗，效果不佳，症状如故，来诊。

查体：体温37.3℃，扁桃体无肿大，咽部轻度充血，心肺（－），腹部胀，左下腹可触及条状移动的类块物，腹部叩诊呈鼓音，伴口气臭秽，小便黄赤。舌质红，苔黄腻，脉象滑。指纹色紫至气关。

诊断：便秘（实秘）。

治疗：按拟定方法治疗1次，当日下午排便1次，经推拿3次后，大便每日1次，排出顺利，余症亦随之消失。嘱其多食新鲜蔬菜瓜果（如香蕉及菠菜等），少吃辛辣肥甘食物。2月后随访，病愈，未复发。

脱　肛

脱肛是指肛管直肠脱垂的一种症状，是小儿常见症状之一。多见于1～3岁小儿。若脱出日久不复位，脱出的肠管会肿胀、充血、发炎，不及时治疗，可使脱出组织坏死。因此应及时治疗，至为重要。

【病因病机】

素食肥甘，过食辛辣，大肠积热，湿热下注，大便干结，大便用力增加腹腔压力，可迫肛外脱；或因病后体弱，泻痢日久，耗伤正气，气虚下陷，统摄升提无力导致本病。

【临床表现】

1．实热脱肛　肛门直肠脱出，色鲜红，有少量鲜红渗出液，红肿刺痛瘙痒，兼有口干唇燥，大便秘结，小便黄赤。舌质红，苔黄腻或黄燥，脉象滑数，指纹色紫。

2．气虚脱肛　肛门直肠脱出不收，脱出的直肠色淡红，有少量粘液，肿痛不堪，伴面色㿠白或萎黄，形体消瘦，精神萎靡，四肢倦怠，懒言乏力。舌质淡红，苔薄白，脉虚弱。指纹淡红。气虚较轻者，每逢大便用力时直肠粘膜脱出肛门外，便后能自动回缩；较重者需用手揉托方能复位；严重者不仅大便时脱出，甚至啼哭、咳嗽、打喷嚏用力时也可脱出。

【处方配穴】

1．实热脱肛　治以清热利湿通便。清脾经，清大肠，清小肠，退六腑，按揉膊阳池，揉天枢，推下七节骨，揉龟尾。

2．气虚脱肛　补中益气，升提固脱。补脾经，补肺经，补大肠，推三关，按揉百会，推上七节骨，揉足三里，揉龟尾，捏脊。

每日1次，6次为一疗程。

【病案举例】

刘某，男，5岁。1982年5月3日诊。

主诉：肛门直肠外脱7天，加重2天。

病史：患儿于1周前因饮食过度，复感寒邪引起腹泻，日行6～7次，泻下清稀挟有泡沫，每逢大便时直肠脱出，开始便后能自动回缩，近两日来，便后需用手托方能上去。曾服补中益气丸治疗，效果不佳来诊。

查体：患儿面色㿠白，语声低微，乏力倦怠，肌肉消瘦，肛门直肠脱出，色淡红，脉沉细弱。

诊断：脱肛（气虚下陷）。

治疗：按拟定处方治疗1次后，大便次数减少，直肠脱出后能自动回缩，每日施术1次，当治疗6次后，症状完全消失，恢复正常。

痢　疾

痢疾，古称肠澼。是小儿常见的一种肠道传染病，多流行于夏、秋季节，以2～7岁儿童发病率较高。本病以腹痛、腹泻、便脓血、里急后重为主要症状。

【病因病机】

本病主要由于饮食不洁之物，进食生冷，外感暑湿、风寒、疫毒之邪，侵入胃肠，与肠内气血相博，湿热郁蒸，气机壅阻，蒸腐气血而致病。

【临床表现】

1. 寒湿痢　腹痛隐隐，便下白色粘冻，白多红少，伴畏寒腹胀，面黄消瘦，神疲乏力，食欲不振。舌苔白腻，指纹色

红，脉象沉弦或沉细。

2. 湿热痢　腹痛即泻，泻下赤白，量少而频，里急后重，便时哭闹不安，肛门灼热，发热口渴，小便短赤。舌红唇干，苔黄腻，脉象滑数，指纹色紫。

3. 久痢　痢疾日久或后期，下痢赤白粘稠，里急后重，量少难下，腹痛绵绵，午后潮热或低热，心烦口干，手足心热，形体消瘦，小便短赤。舌红，少苔，脉象细数，指纹淡紫。

4. 虚寒痢　便下稀薄，混有粘液，或滑泻不禁，面色㿠白，形寒肢冷，神疲乏力，小便清长。舌质淡，苔薄白，指纹色淡，脉象沉细。

【处方配穴】

1. 寒湿痢　散寒化湿，温中健脾。补脾经，补大肠，揉外劳，推三关，摩腹，按揉足三里，推上七节骨，清胃经。

2. 湿热痢　清热利湿止痢。清脾经，清胃经，清大肠，清小肠，退六腑，清肺经，运内八卦，分手阴阳，揉天枢，按揉足三里，推下七节骨。

3. 久痢　清热养阴，和血止痢。清补大肠，分手阴阳（阴池重，阳池轻），揉小天心，清天河水，清心经，补脾经，补肺经，补肾经，揉上马，推三关，退六腑，揉三阴交，揉涌泉。

4. 虚寒痢　温补脾肾，涩肠固脱。补脾经，补肺经，补肾经，清补大肠，运内八卦，推三关，摩腹，推上七节骨，揉龟尾，按揉百会，揉足三里。

每日1次，6次为一疗程。可连续治疗1～3个疗程。

【病案举例】

耿某，男，3岁。1996年7月30日诊。

主诉：腹痛，腹泻，便脓血半个月。

病史：患儿于半月前因食用酸奶后引起腹泻，便下赤白样粘冻，量少而频，每日10余次，便时哭闹；伴发热（体温38℃），食欲不振，曾到市某医院化验大便常规：WBC^{++}，RBC^{-+}，脓细胞+及巨噬细胞。诊为“急性痢疾”，给予静滴庆大梅素，口服PPA、复方新诺明等治疗5天，无明显效果。大便每日8～10次，便下赤白，泻前哭闹，来诊。

查体：患儿体温37.9℃，口唇干燥，左下腹胀甚，压痛+，肛周赤，小便黄赤。舌质红，苔黄腻，指纹紫。大便常规报告：WBC^{++}，RBC+，巨噬细胞。

诊断：痢疾（湿热痢）

治疗：清热利湿止痢。清脾经，清胃经，清大肠，退六腑，运内八卦，分手阴阳，清肺经，揉天枢，推下七节骨，揉足三里。每日治疗1次，当治疗2次后，便下脓血消失，每日腹泻3～5次，腹胀大减。化验大便常规仅见WBC+。上穴改补脾经，推上七节骨，每日1次，当连续治疗6次后，大便每日2次，大便常规正常。唯食量较前减少，伴面黄乏力，继以捏脊3～5遍，补脾经300次，摩腹（补法）200次，揉足三里（双）各30～50次，每日1次，连用1周，以调善后。1月后随访，病愈。

肠 梗 阻

肠腔内容物的正常运行发生障碍，不能顺利通过肠道，称为肠梗阻。早期的肠套叠、肠扭转及肠蛔虫性肠堵塞，均可采用推拿治疗，严重者常危及患儿生命，故需要及时正确处理。

【病因病机】

该病多由于气、血、寒、热、湿、食、虫等因素造成大、小肠通降功能失常，使肠道气血痞结，滞塞上逆而发病。肠为六腑之一，司消化、吸收与排泻，以下行通降为顺，如因种种原因使肠腑气机闭塞，下行通降失职而致本病。

现代医学认为，先天性肠道异常、炎症、肿瘤使肠腔狭窄，肠管以外粘连或肿瘤压迫，异物堵塞及绞窄性疝、肠套叠、肠扭转、肠蛔虫等皆可发生本病。肠梗阻按发生的部位，可分为高位性小肠梗阻与低位性小肠梗阻；根据梗阻的程度，又可分为完全性与不完全性梗阻。

【临床表现】

本病以痛、呕、胀、闭为主要特征。

1. 肠套叠　发病突然，呈阵发性腹痛，由于患儿不能自述，表现为突然大哭，面色苍白，下肢蜷曲，出汗。发作一阵后间歇，幼儿又恢复活动或安静入睡，反复发作后精神渐差，嗜睡，面色青白，呕吐初为胃内容物，在发病 4～12 小时后，往往出现便血或排出粘液样物，腹胀，右上腹部或升、横结肠处有腊肠型包块。晚期可出现脱水，电解质紊乱，精神萎靡，腹胀，发热，甚至休克。

2. 蛔虫性肠梗阻　突然发生阵发性腹痛，呕吐，便秘，可扪及可移动的条状肿块，表面不平，有粗绳团样感觉，可随肠管收缩面改变形状与部位；没有腹肌抵抗及血便；钡剂灌肠可看到成团的虫体阴影；体温与白细胞计数正常或轻度增高，但嗜酸性粒细胞可增多，并有排蛔虫或呕蛔虫病史，即可明确诊断。

3. 粪块堵塞性肠梗阻　腹痛，腹胀，大便秘结不通，呕

吐，左下腹可触及粪块，该型多见于腹部手术后肠粘连的患儿。

【处方配穴】

1. 肠套叠　调理肠腑，通滞启闭。摩腹，分腹阴阳，掐揉五指节，掐揉四横纹，揉小横纹，揉一窝风，揉外劳宫，运内八卦，按揉八髎。

2. 蛔虫性肠梗阻　理肠驱蛔，通滞开闭。摩腹，揉脐，横纹推向板门，揉一窝风，按揉脾俞、胃俞、大肠俞，揉足三里。

3. 粪块堵塞性肠梗阻　润肠通腑。清大肠，清脾经，补肾经，退六腑，拿肚角，揉龟尾，推下七节骨，推下承山。

肠扭转患儿可采用颠簸疗法，即取胸膝俯卧位，用于做顺时针或逆时针方向摩腹，即双手置于患儿腹部两侧，由上而下或左右震动，手法宜轻快，每次5～6分钟，反复几次。肠梗阻原因复杂，因此儿童饱食后不宜做剧烈运动，腹部手术后应早期起床活动，并要经常摩腹，预防肠粘连；婴幼儿注意饮食有节，不宜突然更换饮食；有蛔虫史的要积极治疗蛔虫。

第二节　呼吸系统病症

咳　嗽

咳嗽是肺系疾患的一个常见症候，无论外感、内伤而致肺气宣发肃降失职，均可发生咳嗽。该病多见于3岁以下的婴幼儿。“咳嗽谓有声有痰……咳谓无痰而有声，肺气伤而不清也；嗽谓无声而有痰，脾湿动而有痰也。”（《病机式要》）咳与嗽的含义虽异，但临床上二者并见，故通称“咳嗽”。

【病因病机】

风寒或风热之邪从皮毛或口鼻入侵，卫外机能不固，以致肺失宣降，肺气郁闭不宣，肺气上逆；或外感咳嗽久治不愈，久咳伤阴，肺失濡润，肺气上逆；或脾胃虚寒，脾失健运，湿聚生痰，上扰肺络而致咳嗽。

【临床表现】

1. 风寒咳嗽　咳嗽痰稀，鼻塞流涕，头身疼痛，恶寒无汗，苔薄白，脉浮紧。指纹色淡红。

2. 风热咳嗽　咳嗽痰稠，鼻流浊涕或黄涕，口渴咽痛，头昏汗出，便秘，小便黄，苔薄黄，脉浮数。指纹色鲜红或紫红。

3. 阴虚咳嗽　久咳，午后咳甚，低热或潮热，干咳少痰，咽喉痒痛，面色潮红，五心烦热，食欲不振，形体消瘦，舌红少苔，脉细数。指纹淡紫。

【处方配穴】

1. 风寒咳嗽　疏风散寒，宣肺止咳。推攒竹，推坎宫，运太阳，揉耳后高骨，清肺经，运内八卦，推揉膻中，揉乳根，揉乳旁，揉肺俞，分推肩胛骨，推三关，掐揉二扇门。

2. 风热咳嗽　疏风清热，宣肺止咳。推攒竹，推眉宫，揉太阳，揉耳后高骨，清天河水，清肺经，推揉膻中，揉乳根，揉乳旁，揉肺俞，分推肩胛骨，推脊，揉丰隆。有干性罗音加揉小横纹；湿性罗音者揉掌小横纹；伴腹胀、咳甚者加运内八卦、赤凤点头（见图 52）。

3. 阴虚咳嗽　养阴清肺，润燥止咳。补脾经，补肺经，补肾经，运内八卦，揉二人上马，推揉膻中，揉乳根，揉乳旁，揉肺俞，捏脊，按揉足三里。

每日治疗1次，3～6次为一疗程。连续治疗1～3个疗程。

【病案举例】

杨苗，女，5个月。1996年8月19日诊。其母代述。

主诉：咳嗽3天，加重1天。

病史：患儿于3天前开始咳嗽，喉中痰鸣，伴鼻塞流白色粘涕，伴大便稀，日行2～3次，曾服用婴儿素，川贝末等治疗，效果不佳。近日来咳嗽加重，夜则咳甚，影响睡眠。来诊。

查体：患儿精神佳，发育营养一般，体温37.6℃，呼吸音略粗，心肺（-），腹软，手足不温，舌尖红，苔薄黄。指纹稍紫于风关内。

诊断：咳嗽（风热型）。

治疗：按拟定方法治疗1次后，咳嗽减轻，流涕消失，夜能熟睡。当连续治疗3次后，咳嗽等症状消失。1周后随访病愈。

哮　喘

哮喘是小儿时期常见的一种呼吸道疾病。它以呼吸急促，喘鸣有声，甚至张口抬肩，难以平卧为特征。哮是指呼吸时喉中的哮吼声，喘是指呼吸急促。由于哮必兼喘，二者并见，故通称“哮喘”。

该病包括现代医学的支气管哮喘和哮喘性支气管炎。是常见的慢性疾病，多数患儿经过积极的治疗，随生长发育到成熟期后，方能逐渐康复。

【病因病机】

1. 内因　素体肺脾肾三脏不足，表卫不固，体湿内盛，是发病的内在因素。肺气不足，卫外不固，腠理空虚，易为外邪所侵；脾虚不能为胃行其津液，则积湿蒸痰，上贮于肺；肾阳虚不能蒸化水液，使湿蕴积成痰。

2. 外因　寒温失调，气候转变，感受外邪，及接触某种物质（如花粉、绒毛、烟尘、鱼虾、油漆、煤气、细菌、寄生虫、螨虫等），都可成为本病的诱发因素。若饮食不节，过食生冷或过咸过酸也能诱发本病。

【临床表现】

1. 寒喘型　咳嗽气促，喉中有哮鸣音，痰多白沫，恶寒无汗，面色㿠白，四肢不温，口不渴或喜热饮，舌苔薄白或白腻，脉象浮紧。指纹色淡红。

2. 热喘型　咳喘哮鸣，咳痰黄稠，发热，面红，胸膈满闷，口渴喜冷饮，大便秘结，小便黄赤，舌质红，苔黄腻，脉象滑数。或指纹色紫红。

3. 缓解期　平素畏寒自汗，发作前喷嚏，鼻塞，流清涕，或常因饮食不节而引发本病。患儿静息时也有气短，动则加甚，伴倦怠乏力，懒言，舌质淡红，苔薄白，指纹色淡红，脉象虚弱或沉细。

【处方配穴】

1. 寒喘　温肺平喘豁痰。补肺经，补脾经，揉外劳宫，揉板门，逆运八卦，揉掌小横纹，分推膻中，揉乳根，揉乳旁，揉天突，黄蜂入洞，掐揉皮罢。

2. 热喘　清肺降逆平喘。清肺经，揉天突，捏挤天突，揉掌小横纹，顺运内八卦，逆运八卦，揉肺俞，分推肩胛骨，揉大椎，推揉膻中，推下七节骨，清天河水，推桥弓。

3. 缓解期　扶正固本，调理肺脾肾。补脾经，补肺经，补肾经，运土入水，揉外劳宫，黄蜂入洞，揉肺俞，揉脾俞，揉肾俞，揉三焦俞。

每日治疗1次，6次为一疗程。

支气管肺炎

支气管肺炎，又称小叶性肺炎。按病理改变可分为一般性支气管肺炎和间质性肺炎。多发于冬春寒冷季节。该病属中医的“风温”、“喘咳”等范畴。

【病因病机】

中医学认为小儿形体未充，脏腑娇嫩，抵抗力差。肺又为娇脏，易为风寒，风热之邪所袭，使肺气失宣，气道受阻，则病咳喘。现代医学认为支气管肺炎大部分是由于肺炎球菌感染所致，间质性肺炎由病毒感染而造成。婴幼儿呼吸系统发育不全，气管、支气管管腔狭窄，粘液分泌少，纤毛运动差，肺弹性组织发育差，血管丰富，易于充血，间质发育旺盛，肺泡数少，肺含气量亦少，易为粘液填塞。同时此年龄段免疫能力弱，防御功能未充分发展，故易发生本病。

【临床表现】

支气管肺炎是以热、咳、喘和肺部中、小水泡音为主要症状与体征的一种全身性疾病。化验检查：白细胞及中性粒细胞增多；X线检查：早期仅肺纹理增多，以后可见散在的小点片状阴影，以肺下野及心膈角处较显著。中医辨证多分为三种类型。

1. 风热犯肺　发热微汗出，鼻流黄涕，咽喉痛痒，咳嗽气促，口干而渴，舌尖红赤，苔薄黄，脉浮数。指纹鲜红于风

关。

2. 痰热闭肺　持续高热，咳嗽频繁，喉中痰鸣，咳痰黄稠，难于咳出，气急喘促，鼻翼扇动，唇青口干，口渴，烦躁不安，舌质红，苔黄腻或黄燥，脉滑数。指纹紫红。

3. 肺脾气虚　低热或不热，面色㿠白无华，易出汗，咳嗽无力，喉中痰鸣，动则气喘，精神萎靡，消瘦乏力，食欲不振，大便溏薄，苔白滑，舌质淡，指纹淡红，脉细无力。

【处方配穴】

1. 风热犯肺　疏风清热，宣肺止咳。清天河水，清肺经，开天门，推眉弓，运太阳，分手阴阳，分推膻中，揉乳根，揉乳旁，按揉天突，水底捞月。

2. 痰热闭肺　清热宣肺，涤痰定喘。清肺经，清板门，清脾经，清天河水，退六腑，揉掌小横纹，清大肠，运内八卦，水底捞月，揉天突，推揉膻中，揉乳根，揉乳旁。该型在疾病发展过程中，根据其转归，必要时可配合适当治疗措施，以免延误病情。

3. 肺脾气虚　健脾益肺，佐清热止咳。补脾经，清肺经，运内八卦，揉掌小横纹，揉二马，揉肾顶，摩中脘，推揉膻中，揉肺俞，揉脾俞，揉胃俞。

感　冒

感冒又称上呼吸道感染，一年四季均可发生，但以冬春二季多见。上呼吸道感染主要是因感染病毒或细菌而致。正常人的鼻、咽部有病毒或细菌存在，由于小儿鼻腔短小，没有鼻毛，粘膜血管丰富，若受寒后，则鼻咽部粘膜血管收缩，局部血液循环障碍而抵抗力降低，病毒和细菌得以大量繁殖，乘虚

而入为病。

【病因病机】

由于小儿脏腑娇嫩，腠理疏松，卫外能力差，寒暖不能自调，若气候突变，冷热失宜，护理不当，或营养不良，缺乏锻炼，风寒、风热之邪乘虚侵袭而为患。

感冒主要由风邪侵袭所致，故有风寒、风热之分。

【临床表现】

1. 风寒感冒　恶寒重，发热轻，无汗，鼻塞，喷嚏，流清涕，咳嗽，痰清稀，苔薄白，脉浮紧。指纹红。

2. 风热感冒　发热重，恶寒轻，微汗出，鼻塞流浊涕或脓涕，痰黄，咽红，舌尖红，苔薄黄，脉浮数。指纹鲜红。

【处方配穴】

1. 风寒感冒　疏风散寒解表。推攒竹，推坎宫，运太阳，揉耳后高骨，揉二扇门，推三关，拿风池，拿合谷，揉迎香，凤凰展翅。

2. 风热感冒　疏风清热解表。清天河水，清肺经，开天门，推眉弓，揉太阳，黄蜂入洞，揉总筋，推脊，推六腑，推揉膻中，揉肺俞。

夹痰者加揉天突，揉乳根，揉乳旁，擦胸，擦背法（图161），以宣肺祛痰；夹惊者加：清肝经，掐老龙，掐揉五指节，掐小天心，水底捞月，以镇惊安神；夹滞者加：揉摩中脘，清补脾经，摩腹，以健脾消食化滞。

每日1次，3～6次为一疗程。

【病案举例】

杨某，男，3岁。1992年5月3日诊。

主诉：发热，鼻流清涕1天。

病史：患儿昨晚睡眠受凉后，至晨起时鼻流清涕，连续喷嚏，伴发热，鼻塞，时有咳嗽，咳痰清稀，二便调，来诊。

查体：患儿手足不温，畏寒无汗，测体温 38.5℃，鼻流清涕，心肺（－），腹软，舌苔薄白，指纹红。

图 161　擦背法

诊断：感冒（风寒型）。

治疗：按拟定方法推拿 1 次约 10 分钟后，嘱患儿喝温开水半杯，约 2 小时后头面及全身微汗出，嘱其避风寒。测体温降至 37.1℃，次日又治疗 1 次，发热已退至正常，鼻流清涕等症消失。3 日后随访病愈。

顿　咳

顿咳又称百日咳，是小儿常见的一种呼吸道传染病。本病以 2～5 岁的小儿为多见，好发于冬春二季，病程较长，可迁延到 6 周以上，甚至持续 2～3 个月。患病后可获终身免疫力。

【病因病机】

该病因外感时行风邪，袭于肺卫，则肺失清肃，痰浊阻于气道，肺气不宣，肺气上逆而顿咳。病久则伤肺脾，肺气不纳，脾气亏虚。婴幼儿脏腑娇嫩，神气怯弱，若为痰热内蕴，蒙蔽心窍，可见动风惊厥。

现代医学认为本病是由病原体（百日咳嗜血杆菌）侵入所致。

【临床表现】

初期似感冒，出现发热，咳嗽，流涕，偶有喷嚏，1～2天后上述症状逐渐减退，但咳嗽却日渐加重。一般日轻夜重，此期传染性最强。

咳嗽呈阵发痉挛时，便是痉咳期开始。咳声短促，连续十数声而无吸气的间隙，继之咳嗽暂停，伴以深长吸气，同时发出一种特殊的极似鸡啼的吼啸声。紧接着又是一连串的咳嗽，如此反复多次，直到排出大量呼吸道分泌物和胃内容物，而阵咳暂时停止。痉咳期约为3周，是最严重的阶段，以后阵发性的咳嗽逐渐减轻，吼啸声亦逐渐消失。病程可延长至2～3个月，发病第2周后白细胞总数及淋巴细胞明显增高。

【处方配穴】

清肺降气，镇咳化痰。清肺经，清天河水，揉掌小横纹，掐揉小天心，运内八卦，清胃经，推揉膻中，推天柱骨，按弦走搓摩。飞经走气法。

加减：发病初起见发热、无汗、流涕等症，加掐揉二扇门，推攒竹，推坎宫；体虚面色㿠白，多汗者，加补脾经，补肾经，揉肾顶。

在推拿的同时，若配合中西药物，则效果更佳。

【注意事项】

1．发现百日咳患者，应立即隔离，一般隔离时间为40天。隔离室要空气流通，日光充足。

2．对易感儿童注意营养和健康，在流行季节不去公共场所，注意备带口罩。

第三节　泌尿系统病症

遗　　尿

遗尿是指3岁以上的小儿在睡眠中不知不觉的将小便尿在床上，醒后方觉的一种疾病，又称“尿床”。3岁以下的儿童，由于脑髓未充，智力未健，或正常的排尿习惯尚未养成，而产生尿床者，不属病理现象。本病必及早治疗，如病延日久，到十几岁，经久不愈，就会影响小儿的精神生活、身心健康与生长发育。

【病因病机】

1. 下元虚寒　肾气不足不能温养膀胱，膀胱气化功能失调，闭藏失职，不能制约水道而致遗尿。

2. 肺脾气虚　肺主一身之气，有通调水道、下输膀胱的功能；脾主运化水湿，性喜燥，恶湿能制水；肺脾功能正常，则水液的输布和排泄则正常，若肺脾气虚，上虚不能制下，致使无权约束水道，则小便自遗。

3. 肝经郁热　肝主疏泄，调畅气机，通利三焦，肝经郁热，热郁化火，迫注膀胱而致遗尿。

【临床表现】

1. 肾气不足　睡中经常遗尿，多则一夜数次，醒后方觉，面色无华，精神萎靡，智力欠佳，腰腿酸软，小便清长，舌质淡，脉沉细。

2. 肺脾气虚　尿频而量少，经常小便自遗，消瘦乏力，神疲懒言，食欲不振，大便溏薄，自汗出，舌质淡红，苔薄白，脉象细弱。

3. 肝经湿热　遗出之尿量不多，但尿味腥臊，尿色较黄，或夜间梦语龂齿，口角糜烂，口苦，平素烦躁不安，舌红，苔黄腻，脉象滑数。

【处方配穴】

1. 肾气不足　温阳补肾，固涩小便。补肾经，补脾经，掐揉二马，推三关，运内八卦，揉肾俞，揉关元，按揉百会，揉外劳，捏脊。

2. 肺脾气虚　补益肺脾，固涩小便。补脾经，补肾经，补肺经，推三关，揉关元，揉肾俞，揉脾俞，揉肺俞，擦八髎，揉百会，捏脊。

3. 肝经湿热　清泻肝经湿热。清肝经，清脾经，清大肠，清小肠，清心经，分手阴阳，推箕门。

每日1次，6次为一疗程。

【注意事项】

1. 已发生遗尿者，要积极的治疗和合理的营养，并注意休息；临睡前两小时，最好不要喝水，少吃或不吃流质一类食品。

2. 夜间入睡后，家长应定时叫其起床排尿。

3. 使儿童养成按时排尿的卫生习惯及安排合理的生活制度，不使其过度疲劳。

【病案举例】

邹某，男，4岁。1985年8月9日诊。

主诉：尿床6个月。

病史：患儿于半年前开始尿床，每晚1～3次不等，每当喝水多、吃稀饭及疲劳后，尿床次数增多，曾服中药及针刺等治疗，无明显疗效，来诊。

查体：患儿发育营养可，精神萎靡，面色㿠白无华，心肺（－），腹软，舌质淡，苔薄白，脉沉细无力。畏寒，手足不温。

诊断：遗尿（肾气不足）。

治疗：按肾气不足型遗尿，治疗6次痊愈。

尿 潴 留

尿潴留属于中医学的“癃闭”范畴。是指膀胱蓄有大量尿液，而小便闭塞不通的一种病症。

【病因病机】

本病多由湿热下注，水道闭阻或肾阳不足，命门火衰，使膀胱气化不利而致。

现代医学认为，本病常见于支配膀胱的神经功能失调，致使膀胱松弛，排尿困难，膀胱括约肌相对紧张而致。严重的尿道梗阻，过多的使用冬眠灵药物或阿托品等也可导致尿潴留。

【临床表现】

小腹胀满疼痛，有强烈尿意，而小便不得排出，或伴有大便不畅，口渴不欲饮，舌苔黄腻，指纹色紫。

【处方配穴】

清利下焦湿热，助膀胱气化，开通闭塞。按揉丹田，清小肠，推箕门，按揉三阴交，揉小天心。

加减：若小便不通，面色㿠白，怕冷，肾阳不足，命门火衰者，去清小肠、揉小天心，加推三关、补肾经、擦腰骶部、捏脊，以温阳补肾；大便秘结者，加清大肠、推下七节骨，以调理下焦利小便。

【病案举例】

鞠某，男，3岁半。1984年5月7日初诊。其母代述。

主诉：小便点滴不畅1天。

病史：患儿于昨日开始小便点滴不畅通，伴下腹胀满作痛不适，于今晨起症状加重，小腹部膨胀微痛，欲小便而小便不通，前来急诊。

查体：患儿表情痛苦，烦躁貌，碾转不安，小腹膨隆胀满，压之微痛，舌苔黄腻，指纹紫，脉滑。

诊断：尿潴留。

治疗：清膀胱湿热，助膀胱气化。摩揉丹田，推箕门，揉小天心，清小肠，按揉三阴交，治疗15分钟后，小便排出，腹胀满等症状消失。

第四节 伤科病症

小儿桡骨头半脱位

小儿桡骨头半脱位，又称“牵拉肘”，俗称“肘错环”。幼儿桡骨头发育尚不完全，头颈几乎相等，环状韧带松弛，故在外力作用下易发生半脱位。该病多发于4岁以下的幼儿，为临床常见的肘部损伤。

【病因病机】

多因幼儿在肘关节伸直时，腕部受到牵拉所致。如穿衣、走路跌倒时腕部被成人握住，由于肘部突然受牵拉力，肱桡关节间隙加大，关节内负压骤增，关节囊和环状韧带被吸入肱桡关节间隙，桡骨头被环状韧带卡住，阻碍回复而形成桡骨头半脱位。

【临床表现】

患儿上肢有被牵拉的损伤史。患儿肘部疼痛，肘关节微屈曲，前臂呈旋前位，不敢旋后，前臂不敢作高举动作，握取物障碍。桡骨小头处压痛。局部无明显肿胀或畸形。X 线检查常不能显示病变。

【手法复位】

家长抱患儿正坐，医者与患儿相对。以右侧为例，医者左手拇指按放于桡骨头外侧处，右手握其腕部，并慢慢地将前臂拔伸旋后，一般半脱位在旋后过程中即可复位（图 162），若不能复位，则右手拔伸（牵引）至肘关节伸直旋后位，左手拇指加压于桡骨头处，然后屈曲肘关节，常可听到或拇指下感到轻微的入臼声（图 163）。一般 1 次即可复位。

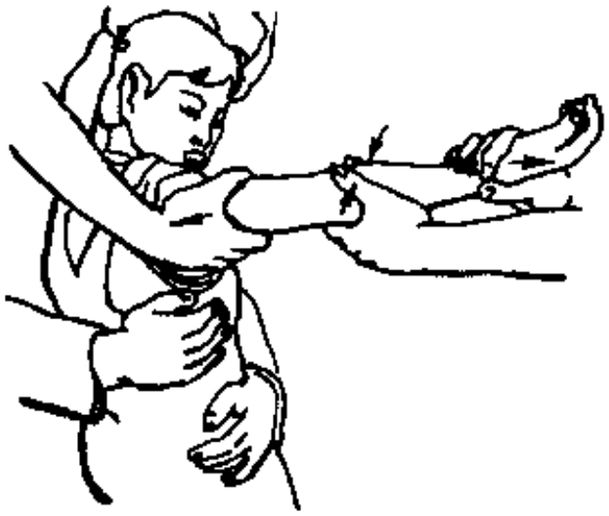

图 162　桡骨头半脱位复位法

【复位后处理】

复位后肘部疼痛立即消失，停止哭闹，手能高举取物，肘部活动自如。复位后嘱其家长在给小儿穿脱衣服时多加注意，避免过度牵拉患肢，以防再次发生而形成习惯性脱位。若经常脱位者，在手法复位后可用颈腕吊带悬挂于屈肘位 2～3 天。

若桡骨头半脱位1～2天未予正复，或经人重力按揉，局部有肿痛者，术后往往不能立即恢复正常，需用轻揉法或加热敷2～3天后恢复正常。

图163　桡骨头半脱位手法复位

【病案举例】

米某，女，1岁。1996年9月23日诊。其母代述。

主诉：右肘拉伤后疼痛，活动障碍1天。

病史：患儿之母于昨日不慎牵拉其右腕部后引起肘部疼痛，随之右肘关节呈旋前位，肘关节微屈曲，不敢高举，右手取物时疼痛哭闹，前来就诊。

查体：患儿发育营养正常，右侧肘关节半屈曲呈旋前位，右前臂高举取物受限，桡骨头处压痛（+）。

诊断：右侧桡骨头半脱位。

治疗：按上述手法复位1次，右侧肘关节疼痛立即消失，肘关节屈伸活动自如。

小儿肌性斜颈

小儿肌性斜颈是指以头向患侧斜、前倾，颜面旋向健侧为特点。临床上，斜颈除极个别为脊柱畸形引起的骨性斜颈、视力障碍的代偿姿势斜颈和颈部肌麻痹导致的神经性斜颈外，一般系指一侧胸锁乳突肌挛缩造成的肌性斜颈。

【病因病机】

肌性斜颈的病理主要是患侧胸锁乳突肌发生纤维性挛缩，起初可见纤维细胞增生或肌纤维变性，最终全部为结缔组织所代替。其主要病因有以下几方面。

1. 产伤　分娩时一侧胸锁乳突肌受产道或产钳挤压受伤出血，血肿肌化形成挛缩。

2. 胎位不正　分娩时胎儿头位不正，阻碍一侧胸锁乳突肌血运供给，引起该肌缺血性改变，造成缺血性肌挛缩。

3. 宫内异常压力　胎儿在子宫内头部向一侧偏斜，或脐带绕颈，对颈部长期加压，影响颈部肌肉血液的供给，发生缺血性纤维病变，使胸锁乳突肌在子宫内已经挛缩，因此患儿出生时无产伤，虽系剖腹产，也有畸形发生。

【临床表现】

在出生后，颈部一侧可发现有梭形肿物（有的经半年后，肿物可自行消退），以后患侧的胸锁乳突肌逐渐挛缩紧张，突出如条索状，患儿头部向患侧倾斜而颜面旋向健侧（图 164）。少数患儿仅见患侧胸锁乳突肌在锁骨的附着点周围有骨疣样改变的硬块物。

若不及时治疗，患侧颜面部的发育会受影响，健侧一半的颜面部也会发生适应性的改变，使颜面部不对称。对晚期病

例，一般伴有代偿性胸椎侧凸。

【处方配穴】

舒筋活血，软坚消肿。手法：拿法、捏法，按揉法，捻法等。取穴：风池，风府，耳后高骨，风门，大椎，肺俞，桥弓（见图 77）。

图 164　肌性斜颈

操作：患儿取侧卧或坐位，使患侧向上。医者先用拿、捏法由上而下往返操作 2～3 分钟；按揉以上穴位各 0.5 分钟、手法先轻渐重；再轻轻按揉颈椎棘突，由上而下往返 10～15 遍；捻胸锁乳突肌 2～3 分钟；然后医者一手扶住患侧肩部，另手扶其头顶侧，使患儿头部渐渐向健侧肩部倾斜，逐渐拉长患侧的胸锁乳突肌，反复进行 3～5 遍。最后用掌擦或鱼际擦法擦至局部温热、充血为度。

每日或隔日治疗 1 次。

【注意事项】

1．嘱家长在患儿睡眠、喂奶、或抱患儿时，注意头向健侧扭转，以助矫正畸形。

2．经常用有响声或色泽鲜艳的玩具向健侧逗引患儿。

3．家长平时可用轻快柔和的手法在患处按揉、提拿，使该肌经常放松。

【病案举例】

皋某，女，3 个月。1995 年 6 月 19 日诊。其母代述。

主诉：歪脖 3 个月。

病史：患儿于分娩时因用产钳助产，出生 10 天后，发现

头歪向右侧，未加重视，两个月后头歪逐渐加重，发现右侧颈部有一条块状肿物而来诊。

查体：患儿发育营养正常，五官端正，头歪向右侧，下颌转向健侧，右侧颜面较健侧略小，右侧胸锁乳突肌处可触及条索状肿物，其下端近锁骨处较坚韧，不红不热，按之不痛，心肺（－），苔薄白，指纹淡红。

诊断：肌性斜颈。

治疗：按拟定方法每日治疗1次，当治疗10天后，右侧胸锁乳突肌变软，头歪减轻；治疗30天后，右胸锁乳突肌明显变软，头颈左右活动基本正常。为巩固疗效，继隔日治疗1次，当治疗2个月后，条索状肿物消失，头颈活动自如。

臂丛神经损伤

婴儿出生时因其臂丛神经干或根受损伤而引起上肢麻痹，亦称为产伤麻痹或产瘫。

【病因病机】

产妇生产时，助产人员过猛过重牵拉婴儿头部，使一侧颈部和肩部过度分离，易造成臂丛的牵引和撕裂损伤；或胎位不正，发生难产或滞产时，受产钳挤压或外力牵拉，损伤神经而引起麻痹。最常见的是上臂麻痹，其次为前臂麻痹，严重者为全臂麻痹。

【临床表现】

1．上臂麻痹　当三角肌、冈上肌、冈下肌、小圆肌、部分胸大肌、旋后肌等不同程度受累，故主要表现为患肢下垂，肩部不能外展，肘部微屈和前臂旋前。

2．前臂麻痹　手指的屈肌和手部的伸肌受累，由于症状

不明显，往往在出生后相当时间才被发现，手的大小鱼际肌均萎缩，屈指肌力也较弱，常有臂部感觉障碍。

3．全臂麻痹　患儿出生后即发现上臂、前臂或全臂不能自主运动，锁骨上窝可能因出血而有肿胀；一般上肢内收、内旋肌挛缩，肱骨头有半脱位或肩峰下垂现象，并可出现前臂桡侧部感觉消失。

第5、6颈神经损伤而致上臂麻痹，第8颈神经与第1胸神经损伤可引起前臂麻痹；臂丛神经束损伤则产生全臂麻痹。

【处方配穴】

治宜通经活络，行气活血。掐揉五指节，掐老龙，揉大椎，揉肩井、秉风、天宗、肩髃、曲池、手三里、合谷，拿极泉。并配合做肩、肘、腕关节的摇、屈、伸等活动。

操作：

1．患儿取坐位。医者以拇指端自大椎循肩井、天宗、肩贞、肩髃等部位往返按揉5～6分钟。用力由小渐大，以柔和轻快、着力深透为宜。

2．按揉肩髃、臂臑、曲池、手三里，外关、合谷等，上下往返5分钟。

3．用食、中、无名指摩中府、云门，并转向极泉处，往返1～2分钟。

4．医者以左手拇、食指固定患儿肩、肘、腕关节处，做适当的屈、伸、摇被动运动各5～10次。

【注意事项】

运用手法时，忌粗暴用力；做被动运动时，动作要缓和，切忌硬扳强拉。

髋关节扭伤

小儿髋关节扭伤，又称“外伤性髋关节炎”。多见于6～12岁的儿童。

【病因病机】

儿童时期股骨头发育不成熟，关节囊和周围的韧带比较松弛，髋关节活动幅度比成人大。当从高处坠下或摔跤跌倒时，髋关节过度外展、内收、屈曲等，均可造成髋关节的损伤。如髋关节过度外展时，股骨头从髋关节内被拉出一部分，由于关节腔内的负压作用，可将髋关节内侧松弛的关节滑膜吸收入关节间隙，当股骨头恢复原位时，部分滑膜被嵌顿于关节间隙，股骨头不能完全恢复原来位置而引起关节疼痛，活动受限。

【临床表现】

患儿大多有蹦高、跳下、滑倒等外伤史，伤后髋部疼痛，下肢不能着地，走路时跛行，常以足尖着地，患儿下肢略呈外展、外旋状。休息时不显任何症状。若走快时，跛行明显，身体晃动，主动或被动内收、外旋髋关节时疼痛加剧，髋关节前内侧有明显压痛。X线摄片髋关节骨质及间隙均正常。

【处方配穴】

舒筋通络，活血止痛。接法，掌根揉法，按法，弹拨，拔伸法等。配穴：居髎，环跳，风市，阳陵，阿是，髀关，伏兔。

操作：患儿仰卧。医者位于患侧，先用接法、掌根揉法于髋关节周围往返施术3～5分钟；继之按揉以上俞穴，使之“酸、麻、胀、痛”得气为度；再弹拨紧张之筋，以解除痉挛。

患儿仰卧，助手用两手分别插入患儿两腋下，医者用双手

呈前后握持患侧下肢，左手在大腿前侧，右手于小腿后侧为助手做相对抗牵引（图 165），继而强屈髋关节至最大限度，最后将髋放入 90°屈曲位，向上提拉牵引（图 166），在牵引下外旋、外展并伸直其髋关节（图 167）。最后医者用双手掌置患腿内外侧，自上而下做相对搓揉动作 2～3 遍结束。

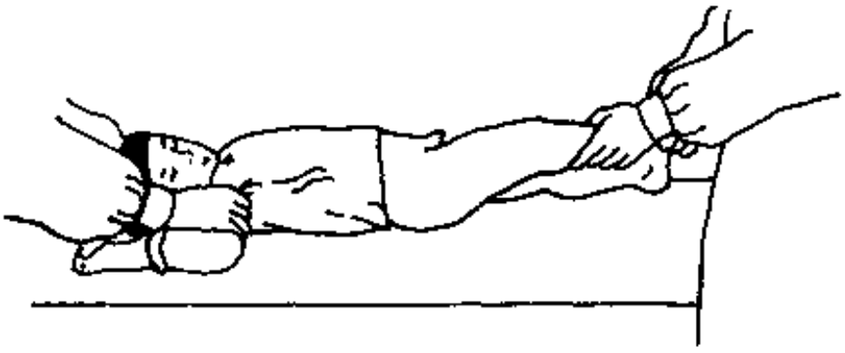

图 165　髋关节相对抗牵引

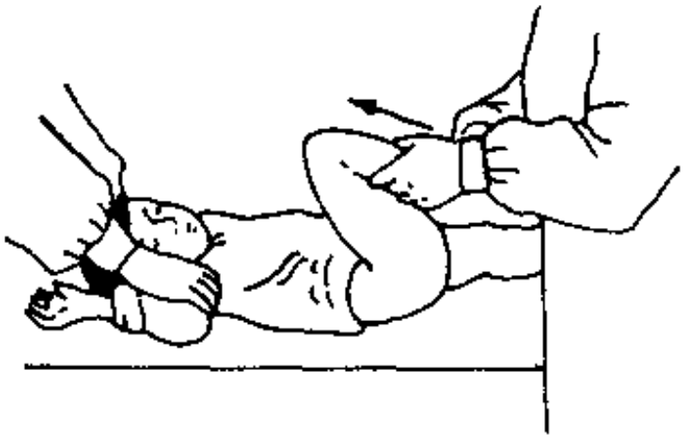

图 166　向上提拉牵引

每日或隔日 1 次。

【病案举例】

孙某，男，5 岁。1995 年 10 月 28 日初诊。

主诉：右髋摔伤疼痛 3 天。

病史：患儿于3天前从1米高处跳下引起右髋部疼痛，伴行走困难，走路时髋关节痛甚，静止时无明显不适。曾在家贴伤湿止痛膏及热敷等治疗效不佳来诊。

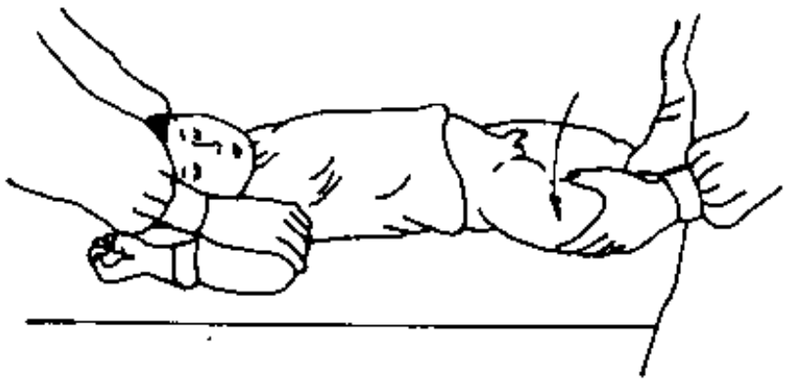

图167　牵引下外旋、外展并伸直髋关节

查体：患儿行走跛行，以右足尖着地，快走时跛行加重，右髋关节屈曲、内收、外旋时疼痛加剧。“4”字试验（+）。髋关节正侧位片报告无异常。

诊断：右髋关节扭伤。

治疗：按拟定方法治疗1次后，右髋关节疼痛减轻，跛行亦明显减轻；治疗8次后，髋关节疼痛消失，“4”字试验（-），髋关节屈伸内收、外旋等活动自如。

踝关节扭伤

踝关节扭伤是临床上常见的一种损伤，属于中医学的“踝部伤筋”范畴。

踝关节是由胫腓骨下端关节面与距骨上关节面组成。踝关节周围主要的韧带有内侧副韧带、外侧副韧带与下胫腓韧带。外侧副韧带较薄弱，且腓骨细长，外踝位置较内踝偏低，因此多易发生外踝（内翻）扭伤。

【病因病机】

多因在不平的路面行走、跑步、跳跃或下楼梯时，踝跖屈位，足突然向内或向外翻转，踝外侧或内侧韧带受到强大的张力作用而致。损伤后韧带扭伤或部分撕裂（图 168），出现出血、水肿、粘连等病理改变。

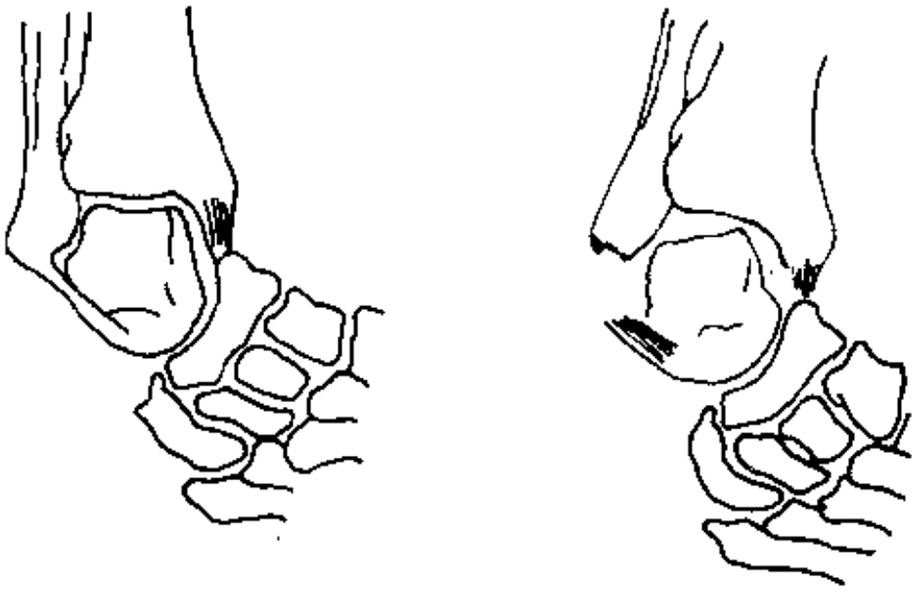

图 168　踝关节扭伤

【临床表现】

踝关节扭伤后，踝部出现明显肿胀，疼痛，足跟不能着地，皮肤呈青紫色。外踝伤者，将其踝关节内翻时外踝疼痛加剧，外侧关节囊及腓前韧带损伤时，肿胀主要在关节外侧和外踝前下方。内踝扭伤时，可能伴有外踝骨折，因此内、外踝均肿胀、疼痛，应仔细检查。若有踝部骨折时，压痛主要在踝骨断端，可闻及骨摩擦音，脱位者踝部有明显畸形。推拿适应于踝关节软组织损伤者。

【处方配穴】

在扭伤的急性期（24～48 小时内），手法宜轻柔灵巧，以

免加重局部损伤性出血；恢复期手法用力宜稍大，特别对血肿机化、产生粘连、踝关节功能障碍的患儿，应以较重手法及被动活动，促使其功能恢复。

摩法、揉法、按法、拔伸法、摇法、扳法、擦法等。

配穴：风市、解溪、足三里、太溪、昆仑、公孙、悬钟、太冲等。

操作：患者仰卧，医者用摩、揉手法于伤处局部周围及小腿部施术2～3分钟，继之按揉以上穴位各半分钟，以酸胀"得气"为度；然后医者用右手握紧患儿足趾并向上牵引，先外翻以扩大踝关节内侧间隙，同时以左手食指压入间隙内（图169），仍在牵引下内翻足部，扩大踝关节外侧间隙，以拇指压入关节间隙内，使拇指夹持踝关节，右手在牵引下将患足左右轻轻摇摆、内翻（图170）、外翻（图171）各1～2次，然后再背屈，同时夹持踝关节的拇、食指下推上提两踝，背屈时下推，跖屈时上提。

图169　医者左手压入间隙内

对伴有肌痉挛、关节粘连的患儿，医者用一手握跟腱，一手握前足，并嘱患儿放松踝部，先予拔伸、跖屈（图172），再做突然背屈动作（图173），手法用力不宜过猛，然后外翻（图174）、内翻足背（图175），继之做踝关节摇法3～5遍

(图 176)。最后用擦法于局部透热为度。

每日或隔日 1 次。

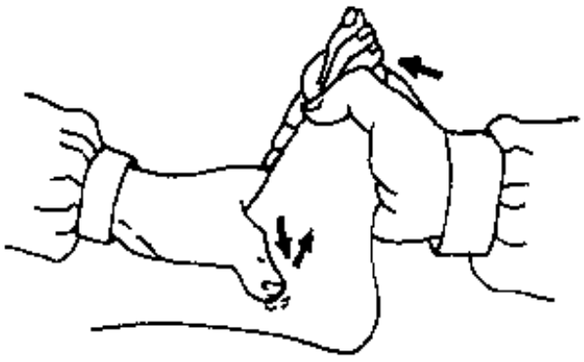

图 170　在牵引下内翻患足

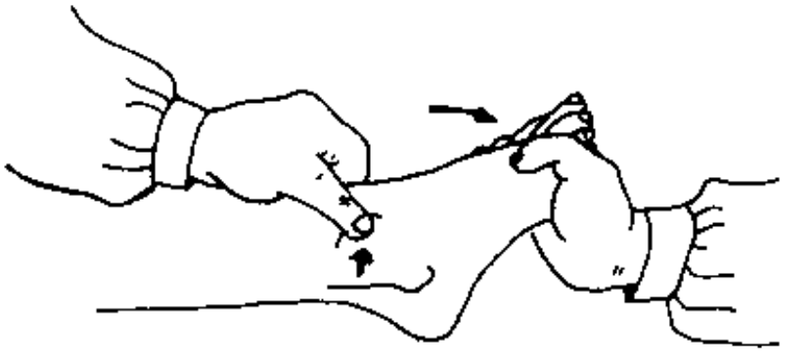

图 171　在牵引下外翻患足

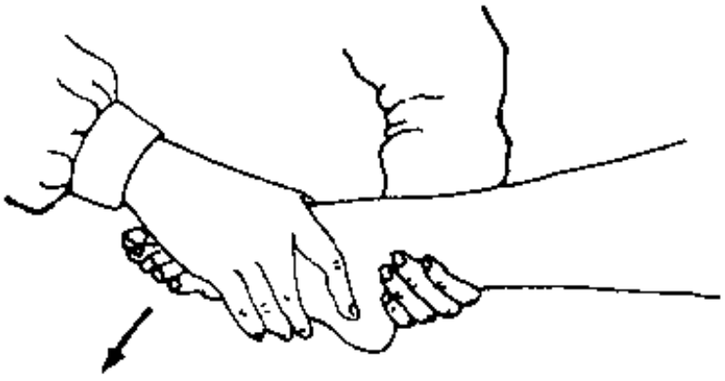

图 172　拔伸、跖屈

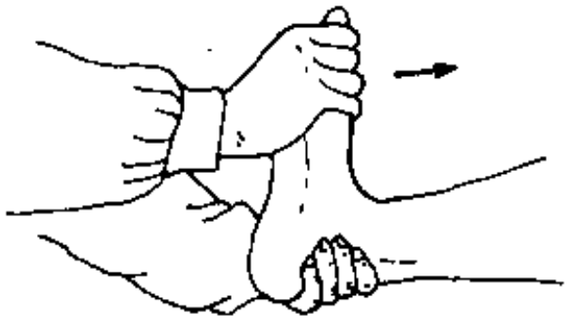

图 173　突然背屈

图 174　外翻足背

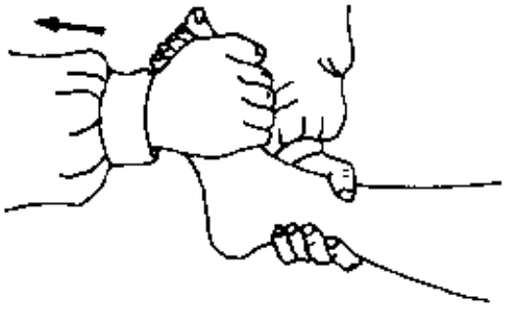

图 175　内翻足背

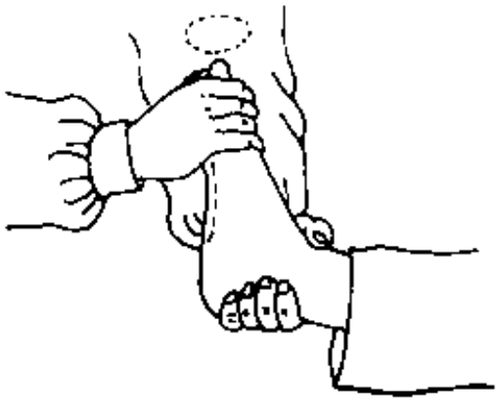

图 176　踝关节摇法

【病案举例】

患儿马某，男，6 岁。1991 年 3 月 18 日诊。

主诉：右踝关节扭伤 2 天。

病史：患儿于 2 天前下楼梯时，不慎扭伤右踝引起疼痛，足不敢着地，夜间痛甚，影响睡眠，曾贴伤湿止痛膏，效果不佳来诊。

查体：患儿发育营养正常，痛苦表情，右外踝处可见散在青紫瘀斑，右踝前下方肿胀，压痛（+），踝关节内翻时痛剧，跖屈背伸受限。踝关节正、侧位片未见异常。

诊断：急性踝关节扭伤。

治疗：按拟定方法治疗1次后，右踝关节疼痛减轻，夜能入睡；治疗6次后，右踝关节疼痛基本消失，肿胀消退，青紫瘀斑变为淡黄色，右外踝前下方仅轻度压痛，踝关节屈伸基本正常。为巩固疗效，继守法治疗3次，诸症消失，踝关节屈伸活动自如。

第五节　五官科病症

近　　视

近视是指视近物清楚而视远物模糊为特征的一种屈光不正的眼疾。有先天性者，系父母有高度近视遗传而来，此类较少；有后天性者，系少年儿童时期过用目力，或学习阅读环境光线昏暗，偏食而体质较差等原因逐渐形成。故临床上有真性近视与假性近视之分。推拿对后者效果较好。

【病因病机】

本病多由于不适当的使用视力，如长时间的近距离在光线暗淡，姿势不正等情况下看书，使眼内睫状肌疲劳，不能调节晶状体的屈光能力。真性近视是指眼轴发育过长，超过了屈光间质所能调节的范围，外界光线仅能射在视网膜前面，因此病人只能看近物，对远处物体模糊不清。必须借助配戴眼镜才能矫正。该病中医称“能近怯远症”，高度近视称“近觑”。

【临床表现】

本病以视远物模糊不清、视近物正常为特征。眼易疲劳，看书时间长时眼酸痛，伴有头晕脑胀，有的病人兼有失眠、健忘、腰酸，按压睛明、四白等穴有明显的酸胀或热感，甚者眯目视物或将目标移近眼前。做目测及眼底镜、验光检查，可明

确诊断。

【处方配穴】

分额法（图 177），捏眉法（图 178）、抹法（图 179）、按揉眼眶法（图 180）、揉眉弓法（图 181）、拿颈法（图 182）。

图 177　分额法

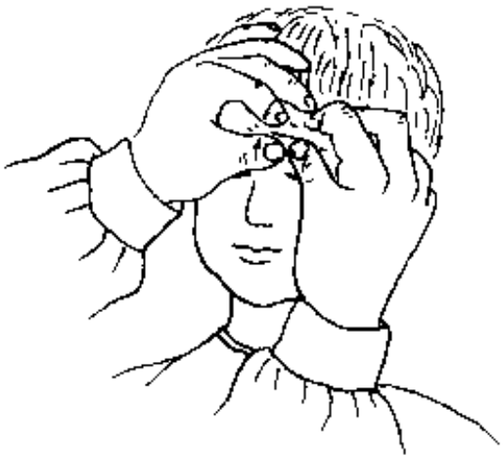

图 178　捏眉法

图 179　抹法

配穴：睛明，印堂，太阳，鱼腰（图 183）风池，肝俞，合谷，揉肾纹（见图 112）。

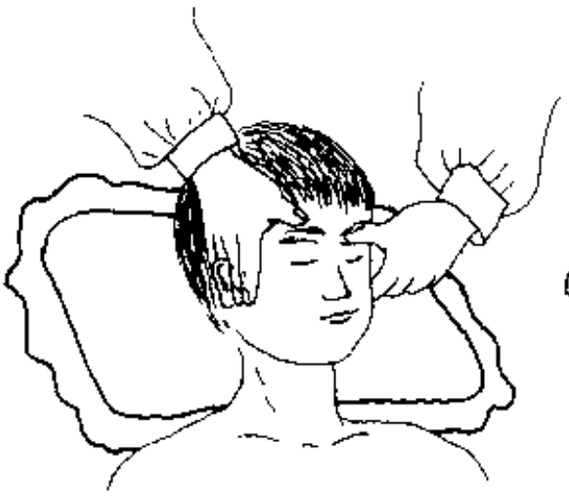

图 180　按揉眼眶法

图 181　揉肩弓法

图 182　拿颈法

图 183　鱼腰

每日 1 次，6 次为一疗程，可连续治疗 2～3 个疗程。

【病案举例】

韩媛，女，11 岁。1994 年 6 月 19 日诊。

主诉：视远物模糊不清 2 个月。

病史：患儿于 2 月前开始感觉视物疲劳感，伴模糊不清，看远物时症状加重，伴头晕、脑胀。曾到市某医院就诊测视力左眼 4.7，右眼 4.6，配戴眼镜纠正视力，效果不佳来诊。

查体：裸视左眼 4.3，右眼 4.2，睛明、鱼腰、四白穴压痛（+）。舌质淡红，苔薄白，脉象沉细。

诊断：近视（假性近视眼）。

治疗：按拟定方法治疗 12 分钟后，自感双目有神，轻松舒适，头晕、眼胀缓解，眼睛明亮感，视物清晰；当连续治疗 5 次后，视远物较清，看书时头晕脑胀症状消失。测视力（裸视）左眼 5.1，右眼 5.0。为巩固疗效，继每日治疗 1 次，又连续治疗 6 次，共 12 次后，视物恢复正常，测视力双眼均达 5.2。2 个月后随访，视物正常，感觉良好。

鹅口疮

该病是由于小儿口腔、舌上布满白屑，状如鹅口，故称“鹅口疮”；又因其色白如雪片，故又称“雪口”。多发于婴幼儿。

【病因病机】

1. 心脾积热　先天胎热内蕴，或孕妇平素喜食辛热、炙浑之品，或产道感染，出生后不注意口腔卫生而致。脾脉络于舌，心脾积热，循经上炎，熏灼口舌发生鹅口疮。

2. 虚火上炎　患儿先天禀赋不足，后天护理失调，或久病久泻，身体虚弱，阴虚阳亢，虚火上浮，白屑积于口舌而致。

现代医学认为，本病是由白色念珠菌感染引起，该菌有时可在口腔中找到，当患儿营养不良，身体衰弱时即可发病。

【临床表现】

1. 心脾积热　口腔、舌面或咽部布满乳白色略高起的斑膜，形似奶块。无痛，擦去斑膜后，可见下方有不出血的红色创面，斑膜面积大小不等，甚者口腔粘膜大部或全部均被斑膜覆

盖，或伴有大便秘结，小便黄赤，舌质红，指纹紫，脉滑数。

2. 虚火上炎　口腔舌面白屑稀疏，周围红晕不著，或口舌糜烂，形体消瘦，面白颧红，神气困乏，小便黄赤，舌红，脉象细数，指纹淡紫。

【处方配穴】

1. 心脾积热　清心脾之热。清心经，清脾经，清板门，揉小天心，按揉小横纹，掐揉四横纹，揉总筋，清天河水，退六腑，推下七节骨，摩腹（泻法）。

2. 虚火上炎　滋补脾肾，引火归元。揉二马，补肾经，掐揉小横纹，掐揉四横纹，清天河水，水底捞月，揉涌泉。

每日治疗1次，6次为一疗程。

【病案举例】

董某，男，2个月。1996年8月19日诊。其母代述。

主诉：口腔内布满白色斑膜4天。

病史：患儿于1周前高烧，流涕，口舌面有白屑散布。曾到省某医院给予静滴青霉素等药物治疗，高热已退，但口内白屑未愈，且唇内、颊腭也出现白屑，经在家给于冰硼散外敷治疗，无明显效果，来诊。

查体：患儿精神佳，体温正常，舌面、颊及唇内布满白色斑膜，形似奶块，流涎粘稠，伴腹胀，便秘，小便黄赤，舌红，指纹紫。

诊断：鹅口疮（心脾积热型）。

治疗：按心脾积热型处方治疗4次全愈。

【注意事项】

1. 患该病后应注意隔离和哺育的消毒，以防传播。

2. 加强营养，特别适量增加维生素B_2和维生素C。

3. 使用抗生素可加重病情，促其蔓延。

流 涎 症

流涎症是指小儿唾液过多而引起口涎外流的一种常见症状，早期推拿治疗，效果良好。

【病因病机】

该症多由于食母乳过热或嗜食辛辣之物，以致脾胃湿热，熏蒸于口；或先天不足，后天失养，脾气虚弱、固摄失职，以致唾液从口内外流而发病。

现代医学认为，该症多由于小儿口、咽粘膜炎症引起。

【临床表现】

1. 脾胃湿热　流涎粘稠，口气臭秽，食欲不振，腹胀，大便秘结或热臭，小便黄赤，舌红，苔黄腻，脉滑数，指纹色紫。

2. 脾气虚弱　流涎清稀，口淡无味，面色萎黄，肌肉消瘦，懒言乏力，饮食减少，大便稀薄，舌质淡红，苔薄白，脉虚弱，指纹淡红。

【处方配穴】

1. 脾胃湿热　清脾胃湿热。清脾经，清胃经，清大肠，清天河水，掐揉四横纹，掐揉小横纹，揉总筋，摩腹（泻法）。

2. 脾气虚弱　健脾益气，固摄升提。补脾经，补肺经，补肾经，运内八卦，推三关，摩腹（补），揉足三里，揉百会，捏脊。

每日1次。3～6次为一疗程。

【注意事项】

1. 患该症后，大人不宜用手戳捏患儿腮部。

2. 患儿下颌部及前颈、胸前部宜保持干燥。

牙　痛

小儿牙痛多由牙齿及牙周疾病引起。中医将牙痛分为虚实两大类，实症多因胃火上炎引起，虚症多由肾虚所致。

【病因病机】

该病多由于胃内有热，牙体及齿龈不健，复感风热之邪侵犯，致火热上蒸齿龈；或小儿先天气血两亏，肾阴不足，虚火上炎扰及齿龈；或平素膏粱厚味，过食糖质，牙齿污秽，以致牙体被蛀蚀所引起。

【临床表现】

患儿牙齿疼痛，遇冷、热、酸、甜等刺激加剧，由胃火引起者，常伴有牙龈红肿，口臭，口渴，大便秘结，小便短赤，舌红，苔黄腻，脉象滑数。由肾虚引起者，表现为牙痛隐隐，牙龈微红，午后及咬物时痛甚，伴咽干颧红，盗汗，形体消瘦，舌质红，苔少或无苔，脉象细数。

牙齿不断遭受侵蚀出现蛀孔，饮食时食物嵌塞于龋洞或受冷热刺激引起疼痛为龋齿牙痛。

【处方配穴】

指揉法，指按法。

配穴：颊车（牙关），此穴在上下齿咬紧时，在隆起的咬肌高点处（图 184）；下关，该穴在颧骨弓下凹陷处，当下颌骨髁状突的前方，闭口取穴；合谷；牙痛穴（本穴位于掌面第 3、4 掌骨间距掌横纹 1 寸处）；耳门。

加减：胃火牙痛者，加清胃经，清天河水、清大肠，退六腑，清小肠，揉总筋，打马过天河。虚火牙痛者，加揉二马，水底捞月，揉涌泉，清天河水，揉小横纹，清大肠。

每日治疗1次。

【注意事项】

睡前刷牙，保持口腔卫生，不宜过食糖块及甜性食物；减少冷热刺激，发现龋齿应及早治疗。

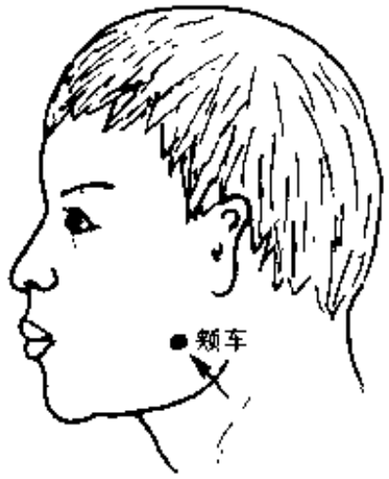

图184　颊车

鼻　炎

鼻炎临床上有急、慢性之分。急性鼻炎，以鼻粘膜的急性炎症为特点，俗称“伤风鼻塞”。慢性鼻炎，因其粘膜肿胀，分泌物增多，而使鼻窍不利，窒息不通，故属“鼻窒”范畴。

【病因病机】

本病多由于感受风寒或风热之邪侵袭所致。肺开窍于鼻，司呼吸而主皮毛，故风寒外袭皮毛，内犯于肺，或风热上侵，多先犯肺，二者均可导致肺气不宣，肺失清肃，以致邪毒停留于鼻而发病。

【临床表现】

急性鼻炎表现为鼻粘膜肿胀，鼻塞流清涕，伴有头痛，发热，恶风，舌质红，苔黄腻，脉象浮数。

慢性鼻炎则表现为鼻粘膜弥漫性充血，肥厚或萎缩，分泌物多，流脓涕，鼻塞加重，伴有鼻音，鼻粘膜干燥，鼻腔变宽，嗅觉减退，舌质红，苔黄，脉数。

【处方配穴】

搓揉鼻两侧，指揉迎香、印堂、鼻准、风池、肺俞、合谷穴，各0.5～1分钟，拿颈法（见图182）

加减：偏风寒者，加开天门，推眉弓，揉风池，揉风门，推天柱骨，推三关，擦背部膀胱经透热为度；风热者，加清天河水，揉曲池，揉大椎，擦背部膀胱经微红为度。

【病案举例】

秦某，男，8岁。1996年3月19日诊。

主诉：交替性鼻塞，流粘涕1个月，加重5天。

病史：患儿于1996年2月2日，夜眠受寒后出现鼻塞，喷嚏，涕多而清稀，伴发热（体温37.5℃），咽痛，当时未就诊治疗，5天后症状基本缓解，以后每因受寒即交替性鼻塞，夜间加重，伴有头部微胀痛。同年2月25日到市某医院就诊，给予滴鼻净，氯麻液外用治疗，效果不佳。近来症状加重，前来就诊。

查体：患儿发育营养一般，体温37.8℃，鼻涕多而黄稠，微恶风寒，伴嗅觉减退，面色萎黄，倦怠乏力。五官科查体所见：鼻粘膜充血肿胀，鼻甲肥大，色潮红，舌尖红，苔薄黄，脉象浮数。

诊断：慢性鼻炎急性发作（风热型）。

治疗：按拟定方法治疗15分钟后，鼻塞减轻，头胀痛顿感缓解。继守法治疗5次，鼻塞已通畅，流涕消失，已无头痛，鼻粘膜基本正常。为巩固疗效，继守法隔日治疗2周，诸症消失，嗅觉灵敏。半年后随访，病愈，未复发。

第六节　其他病症

发　热

发热即体温异常升高，是小儿常见的一种病症。正常小儿

腋下体温一般为 36℃～37℃。当小儿在喂奶、哭闹、衣被过厚、室温过高、运动等，均可使体温暂时升高达 37.5℃左右，尤其为新生儿或小婴儿更易受以上条件影响；反之在饥饿、保暖条件不佳时，体温可下降至 35℃以下。一般测腋温应以 5 分钟为准。

【病因病机】

1. 外感发热　由于小儿体质较弱，抗病邪能力不足，加以冷热不能调节，家长护理不周，易为风寒外邪所侵，邪气侵袭体表，卫外之阳被郁而致发热。

2. 阴虚内热　小儿先天不足或后天营养失调，或久病伤阴而致肺肾不足，阴液亏损引起发热。

3. 肺胃实热　多由于外感误治或乳食内伤，以致肺胃壅实，郁而化热。

4. 气虚发热　小儿体质素弱，后天失养，脾阳亏损，阳浮于外而致。

【临床表现】

1. 外感发热　发热，头痛，无汗，怕冷，鼻塞，流清涕，苔薄白，指纹鲜红，为风寒；发热，微汗出，口干，咽痛，鼻塞流黄涕，苔薄黄，指纹红紫，为风热。

2. 阴虚发热　午后发热，手足心热，形瘦，盗汗，食欲减退，舌质红，少苔或苔剥、无苔、指纹淡紫。

3. 肺胃实热　高热，面赤，气促，不思饮食，便秘烦躁，渴而引饮，小便黄赤，舌质红，苔黄燥，指纹紫。

4. 气虚发热　低热，消瘦，懒言乏力，气短自汗，面色㿠白、食欲不振，四肢倦怠，舌质淡红，苔薄白，脉象沉细无力或虚弱，指纹淡红。

【处方配穴】

1. 外感发热　清热解表，发散外邪。推攒竹，推坎宫，揉太阳，清天河水，清肺经。

加减：偏风寒者，加推三关，拿风池，掐揉二扇门。偏风热者，加推脊，多推天河水（300次以上）。

2. 阴虚内热　滋阴清热。揉二马（上马），清天河水，运内劳宫，补脾经，补肺经，揉足三里，推涌泉。

3. 肺胃实热　清泻里热，理气消食。清肺经，清胃经，清大肠，运板门，运内八卦，清天河水，打马过天河，退六腑，揉天枢，推下七节骨。

4. 气虚发热　补益中气，佐以清热。补脾经，补肺经，推三关，摩腹（补），运内八卦，清天河水，按揉足三里，捏脊。

每日1次，3～6次为一疗程。可连续治疗1～2个疗程。

【病案举例】

谷某，男，3岁。1995年4月27日诊。

主诉：发热1天。

病史：患儿于昨日受寒后出现发热，体温38℃，伴鼻塞流清涕，懒言少动，自觉怕冷，曾在家口服小儿退热片等药治疗，效果不佳。来诊。

查体：患儿精神不振，发育营养佳，体温39℃，无汗，鼻塞、怕冷，伴鼻流清涕，手足不温，心肺正常，腹软，舌苔薄白，指纹红。

诊断：外感发热（风寒型）。

治疗：按拟定方法（风寒型）治疗1次约10分钟后，精神转佳，额面微汗出，2小时后测体温为37.9℃，下午又守法

治疗1次，翌日体温恢复正常，诸症缓解。

夜　啼

夜啼是指小儿经常在夜间哭啼不眠，甚至通宵达旦，白天如常，入夜则哭啼，或每晚定时啼哭者，称“夜啼”。民间俗称“夜啼郎”、“哭夜郎”。有的阵阵啼哭，哭后仍能入睡。患此症后，持续时间少则数日，多则经月。本病多见于6个月以内的婴幼儿。

若各种皮肤病、蛲虫病、佝偻病等身体不适或瘙痒等引起的哭叫，不属于本节讨论的范围。

【病因病机】

1．脾寒　婴儿素体虚弱，脾常不足，至夜阴盛，脾为阴中之阴，若护理失调，寒邪内侵，脾寒内生，夜属阴，阴胜脾寒愈盛，寒邪凝滞，气机不通，故入夜腹痛而啼。

2．心热　乳母平日恣食辛辣肥甘，或常服用焦炙动火之食物，或贪服性热之药，火伏热郁，积热上炎。心主火属阳，阳为人生之正气，至夜则阴盛而阳衰，阳衰则无力与邪热相搏，正不胜邪，则邪热乘心，心属火恶热，而至夜间烦躁哭啼。

3．惊吓　小儿神气不足，心气怯弱，如目触异物，耳闻异声，使心神不宁，神志不安，常在梦中哭而作惊，故在夜间惊啼不寐。

4．伤食　婴儿乳食不节，内伤脾胃，“胃不和则卧不安”，因脾胃运化失司，乳食积滞，入夜而啼。

【临床表现】

1．脾寒（脾脏虚寒）　弯腰而啼，睡喜伏卧，四肢欠温，

食少便溏，面色青白，口唇舌质淡白，苔薄白，脉象沉细，指纹青红。

2. 心热（心经积热） 睡喜仰卧，见灯火则啼哭愈甚，烦躁不安，小便短赤，或大便秘结，面色赤，唇红，舌质红，苔黄，脉数有力，指纹紫红。

3. 惊吓（惊骇恐惧） 睡中突然惊啼不安，紧抱母怀，面色乍青乍白，山根色青，毛发直立，夜则脉来弦数，指纹青。

4. 伤食（伤食积滞） 夜间阵发啼哭，脘腹胀满，呕吐乳块，大便酸臭，舌苔厚腻，脉象滑，指纹紫。

【处方配穴】

1. 脾脏虚寒 温中健脾。补脾经，推三关，摩腹，揉中脘，揞揉小天心，揉足三里，捏脊。

2. 心经积热 清心安神。清心经，清天河水，清小肠，揉总筋，揉内劳宫，揞揉小天心。

3. 惊吓 镇惊安神。推攒竹，清肝经。掐揉五指节，揞揉小天心，运内八卦。

4. 乳食积滞 消食导滞。清补脾经，运板门，运内八卦，清大肠，摩腹、揉中脘，揉天枢，揉足三里，揉脐，推下七节骨。

每日1次，3～6次为一疗程。

【病案举例】

郝某，男，3岁。1995年8月26日诊。其母代述。

主诉：睡眠中突然惊啼3天。

病史：患儿在3天前因突然受巨大声响刺激引起哭闹，于当晚夜眠中突然惊醒哭啼，紧依母怀，然后渐渐入睡，每晚发

作1～2次，在家口服小儿至宝丹治疗，效果不佳。近来症状加重来诊。

查体：患儿发育营养可，心肺（－），山根色青、毛发竖立，苔薄白，指纹色青。

诊断：夜啼（惊骇恐惧）。

治疗：按拟定方法推拿治疗2次痊愈。

落　枕

落枕又叫“失枕”，是指小儿睡眠醒后，颈项患侧肌肉痉挛、疼痛、强直、酸胀、头转动失灵为主要特征。轻者2～3天自愈，重者可延至1周以上。推拿治疗本病疗效甚佳。

【病因病机】

小儿睡眠枕头高低不适，躺卧姿势不良，感受风寒，或因颈部突然扭转，以致颈项肌肉（如胸锁乳突肌、斜方肌、肩胛提肌）痉挛，或关节滑膜嵌顿而发生本病。

【临床表现】

颈项部一侧，少数两侧胸锁乳突肌痉挛、僵硬、疼痛，颈部活动受限。患儿头向患侧倾斜，患处肌肉紧张、压痛明显，颈椎棘突两侧可找到局限性压痛点。

【处方配穴】

滚背法（图185），揉风池、拿风池，揉颈椎两侧膀胱经，摇颈法，拿肩井。

每日治疗1次。

【病案举例】

黄某，男，8岁。1996年9月29日诊。

主诉：颈项僵硬、疼痛，活动障碍2天。

病史：患儿自述于5天前睡眠起床后感到颈项疼痛，强直，转颈困难，曾在家贴伤湿止痛膏治疗，效果不佳。来诊。

图185　掖背法

查体：颈椎呈前倾位，左侧斜方肌紧张，压痛明显，颈4、5、6椎旁压痛（+），舌苔薄白，脉象弦。

诊断：落枕。

治疗：按拟定方法治疗10分钟后，颈项疼痛立刻缓解，颈椎活动较灵活。次日又巩固治疗1次，病愈。

暑　热　症

暑热症又称夏季热（疰夏），是婴幼儿时期的一种常见季节性疾病。以发热（38℃～40℃），口渴、多饮、多尿、汗闭，或少汗为特征。多发生于1～3岁的患儿。

该病的发生与气候关系密切。发病季节多在6～8月份，至秋凉后症状多数自行消退。在发病期如无其他兼症，一般预后良好。

【病因病机】

该病多由于小儿先天禀赋不足或后天失调，气血不足，发

育营养较差，气阴不足，入夏后阳气旺盛，小儿阳常有余，阴常不足，不耐炎热气候的熏蒸，易患夏季热。

【临床表现】

1. 婴幼儿在夏季发热不退，体温多达38℃～40℃，气温越高发热也越高，热程可达1～3个月，秋凉后体温逐渐下降，次年可复发，但症状较轻。

2. 多饮多尿。每日饮水量可达2000毫升以上，小便次数多达10余次以上，且小便清长。

3. 无汗或少汗。患儿灼热不出汗或少汗出，皮肤干燥。若逐渐汗出是病情好转的先兆。

4. 全身情况一般良好，体检无特殊异常。病久则形体消瘦，面色少华，精神萎靡等。

实验室检查：淋巴细胞增高，其他均正常。

【处方配穴】

清热解暑。清胃经，清肺经，清天河水，退六腑，推脊，揉二马，揉肺俞，揉足三里。

加减：腹胀、厌食者加补脾经、摩腹（顺时针）、运内八卦；大便秘结者加清大肠、推下七节骨，按揉膊阳池；睡眠不佳者加捣揉小天心，推攒竹；胆怯易惊者加掐揉五指节。

每日1次，6次为一疗程。可连续治疗1～2个疗程。

【注意事项】

1. 夏季炎热季节，多饮用绿豆汤、西瓜汁，以清热解暑。

2. 食易消化之食物，少吃辛辣肥甘之物。

3. 室内宜通风，有条件时可用温水洗浴，每日1～2次，每次10～20分钟

4. 必要时可口服藿香正气水，每日 2 次，每次 1/4～1 支，温水送下。

佝 偻 病

佝偻病是婴儿时期一种慢性营养缺乏症，多见于 3 岁以下的小儿，以 6～12 个月乳幼儿发病率较高。中医早有记载，如有关五迟（立、行、发、齿、语迟）、五软（头、手、足、口肌肉痿软）、鸡胸、龟背等论述。

【病因病机】

本病主要由于胎中失养，先天不足，调护不当，营养失宜，脾肾亏损。肾主骨生髓，脾主运化。脾气不足，运化失司，气血亏虚；肾气不足，则生长发育迟缓，骨骼软弱。

现代医学认为，本病主要是由于户外活动少，日光照射不足，营养失调，维生素 D 缺乏，钙、磷代谢紊乱，而引起骨骼、肌肉、神经等系统异常所致。

【临床表现】

1. 脾胃虚弱　虚胖懒动，头颅骨软，囟门宽大，久不闭合，发稀色黄，面色无华，神情呆滞，肌肉松弛，四肢倦怠，不能挺立，虚弱多汗，夜眠不安，易受惊惕，大便较稀，舌质淡，苔薄白，脉缓，指纹淡红。

2. 肾气不足　形体瘦弱，头颅方大，面色无华，数岁不语或言语不清，牙齿、头发生长迟缓，或有鸡胸、龟背（脊柱后凸），腹大（腹膨隆），下肢弯曲，发育迟缓，骨骼明显畸形（如肋串珠（图 186）、“O”型腿（图 187）、“X”型腿（图 188）等。舌质淡，苔薄白，脉沉细无力或虚弱，指纹淡红。

图 186　肋串珠

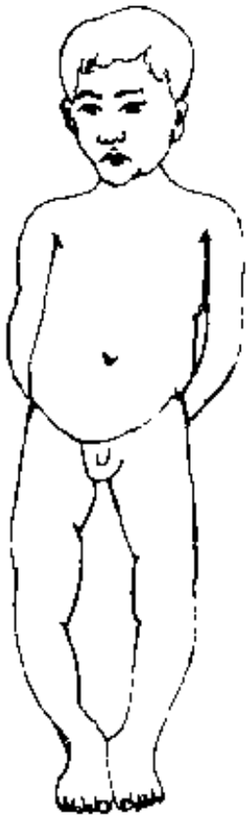

图 187　"O"形腿

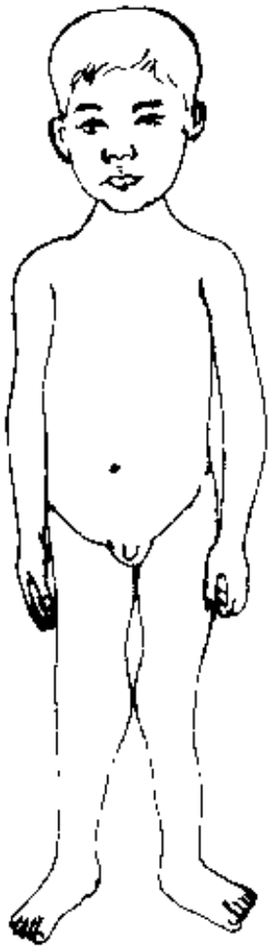

图 188　"X"形腿

【处方配穴】

1. 脾胃虚弱　健脾和胃。补脾经，补胃经，运内八卦，运水入土，推三关，摩腹，揉中脘，揉脾俞，揉胃俞，按揉足三里，捏脊。

2. 肾气不足　补肾益气。补肾经，补脾经，补肺经，推三关，摩腹，揉足三里，揉脾俞，揉肾俞，捏脊。

每日治疗1次。

【注意事项及预防】

1. 妊娠期应多在户外接触日光照射，妊娠期后3个月，最好口服鱼肝油预防量。

2. 新生儿期要坚持母乳喂养，及时添加辅食（如蛋黄等）。

3. 让患儿多在室外活动，以接触日光。

解　颅

解颅是指患儿囟门扩大，颅缝裂开，到一定年龄应闭合而不闭合，其目珠下垂，如落日状。

现代医学认为，本病是由于脑脊液分泌及吸收失去平衡，绝大多数为脑脊液循环发生障碍，引起脑积水所致。此病多同时伴有五迟、五软等症。

【病因病机】

本病多由于先天不足，元阳亏虚，肾气虚弱。肾主骨生髓充脑，肾虚则骨之成长受限，囟门不能如期闭合，以致囟门宽大，颅缝裂解；或因病后肾虚，水不胜火，火气上蒸，其髓则热，髓热则解而颅缝分开。

【临床表现】

小儿生后囟门逾期不闭合，反而逐渐加宽、开解，头颅明显增大，头皮光亮，青筋暴露，目珠下垂，白多黑少，头大颈细，头颅不立，身体瘦弱，发育迟缓落后，神识呆钝，舌质淡，苔薄白，脉虚弱或沉细无力，指纹淡红。

【处方配穴】

补益肾气。补肾经，补脾经，推三关，运内八卦，揉百会，揉神聪（该穴又叫四神聪，位于百会穴左、右、前、后各旁开1寸处），揉二马，摩腹，揉肾顶，揉足三里，捏脊。

每日治疗1次。

惊　风

惊风又称惊厥，是小儿常见的病症之一。以肢体抽搐，两目上视和意识不清为其特征。临床上分为急惊与慢惊两种，急惊来势凶急，处理不当，可使脑组织和局部机体缺氧，遗留后遗症状，严重者可引起窒息，发生呼吸困难和循环衰竭，因此治疗一定要及时。

现代医学认为，惊风是中枢神经系统功能紊乱的一种表现，引起的原因很多，本节是指小儿时期最为常见的因高热和中枢神经系统感染引起的惊风而言。

【病因病机】

中医认为，风、热、痰、火之邪，或惊吓、食滞等，是惊风最常见的病因。小儿由于体属纯阳，感受六淫外邪，化热极速，热盛生风，风热相扇，煎熬津液，凝结为痰，痰热壅闭。或因乳食不节，积滞痰热内壅，气机逆乱，清窍蔽塞，发为惊风。另一方面津液亏损，阴血不足，筋脉失其濡养，以致肢体拘急、抽搐、角弓反张而发作。

慢惊风多因急惊失治或突受惊吓，或久泻久痢，大病后正气亏损、津血耗伤，筋脉失于滋养而致。

现代医学认为，小儿中枢神经系统发育不完善，每当高热或炎症刺激时，易发惊风。

【临床表现】

急惊风者，高热达39℃以上，面赤唇红，气急鼻扇，烦躁不安，继而出现神志昏迷，两目上视，牙关紧闭，脊背强直，四肢抽搐，颤动等症状。

因痰湿内阻者，可兼有痰声漉漉，咳吐不利，呼吸气急，舌苔白腻等症。

因伤食积滞而引起惊风者，可兼有脘腹胀满，便秘，苔厚腻，脉象滑。

慢惊风者，可见面色苍白，嗜睡无神，两手握拳，抽搐无力，时作时止，有的在沉睡中突发痉挛，四肢厥冷。

【处方配穴】

1．急惊风　急则治其标，先以开窍镇惊，然后分别予以清热，或导痰，或消食以治其本。

开窍：掐人中，掐十宣，拿合谷，掐端正，掐老龙，掐山根，掐承浆，掐威灵，掐精宁。掐少商，掐中冲，掐少泽，掐皮罢，掐甘载，拿仆参，以上穴位可选择应用。

止抽搐：拿合谷，拿曲池，拿肩井，拿百虫，拿膝眼，拿前承山，拿后承山，拿委中，掐解溪，拿昆仑，二龙戏珠（见图48）。

导痰化痰：清肺经，推、揉膻中，揉天突，揉中脘，搓摩胁肋，揉肺俞，分推肩胛骨，开旋玑，合推大横纹。

消食导滞：运板门，清大肠，补脾经，揉中脘，揉天枢，

摩腹，按揉足三里，运外八卦，推下七节骨。

清热：清肝经，清心经，清肺经，清胃经，退六腑，清天河水，推脊，掐商阳，掐关冲，揉曲池，苍龙摆尾（见图47）。

2．慢惊风　急性发作时可按急惊风处理。治宜培补元气，熄风止搐。补脾经，补肾经，清肝经，推三关，拿曲池，按揉百会，摩中脘，摩腹，按揉足三里，拿委中，捏脊法（见图97，图189）

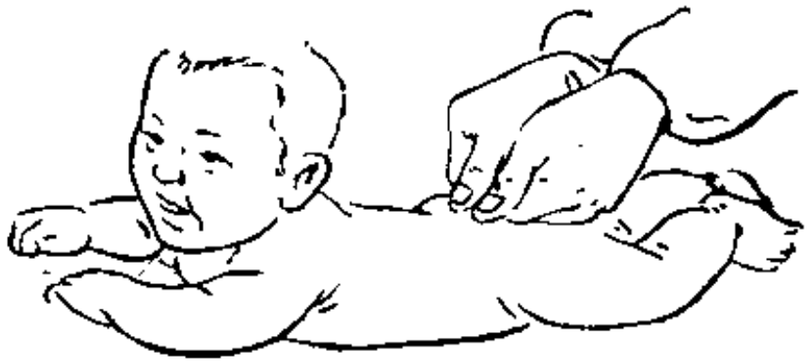

图189　捏脊法

急惊风者掐醒即止，慢惊风者每日1次。

【病案举例】

王某，男，3岁。1988年3月11日诊。其母代述。

主诉：发热3天，两目上视5分钟。

病史：患儿于3天前发热，体温37.6℃～38℃，伴鼻塞流涕，厌食，精神不振，昏昏沉沉，曾在家口服小儿安，退热片等治疗，效果不佳。第3天突然两目上视，邻居急邀余就诊。

查体：病情危急，面唇青紫，口吐白沫，两眼上翻，昏迷不醒，指纹色紫。

诊断：急惊风。

治疗：急以开窍醒神，掐人中，掐合谷、掐十宣，掐承浆，交替用之，约1分钟后，患儿“哇”的一声啼哭，神态、呼吸恢复正常，面唇红润，转危为安。随之测体温高达39.2℃，急以酒精为介质，予以清天河水，退六腑，清肝经，清胃经，推下七节骨，推脊，配以物理降温，以泻其热。1小时后体温降至37.8℃，经推拿3次后体温恢复正常。

痄　腮

痄腮是由风温邪毒引起的急性传染病，以发热，耳下腮部漫肿疼痛为其主要临床特征。一年四季均可发生，但以冬春二季易于流行，学龄儿童发病率较高，一般预后良好，但年长儿童可并发睾丸肿痛（腮腺炎性睾丸炎）等病。

该病相当于现代医学中的流行性腮腺炎，是由腮腺炎病毒引起。患病后可获得终身免疫。

【病因病机】

外感风温邪毒从口鼻而入，侵袭少阳经脉郁而不散，结于腮部。足少阳之脉，起于目外眦，上行至头角，下耳后绕耳而行。邪入少阳，经脉壅滞，气血流行受阻，故耳下腮颊漫肿而疼痛；足少阳与足厥阴互为表里，病变相互传变，足厥阴之脉循少腹环阴器，若受邪重，较大儿童可并发睾丸肿痛及少腹痛。若温邪炽盛，热极生风，扰乱神明，则出现高热，甚至惊厥等病变。

【临床表现】

1. 风热轻症　发热恶寒较轻，一侧或两侧耳下腮部漫肿疼痛，咀嚼不便，伴咽红，舌红，苔薄白或薄黄，脉浮数。

2. 风热重症　高热恶寒，腮部漫肿，胀痛拒按，头痛，咽红肿痛，大便秘结，小便黄赤，舌红，苔薄黄，脉滑数，或浮数。

【处方配穴】

1. 风热轻症　疏风清热，消肿散结。清天河水，清板门，分推大横纹，揉牙关，揉耳门，清肺经，拿风池，揉耳后高骨。

2. 风热重症　清热解毒，软坚散结。退六腑，打马过天河，清天河水，清胃经，水底捞月，揉大椎，推脊，合推大横纹，揉曲池，揉合谷，推涌泉。

每日治疗1次。若高热者可每日推拿2次。

【注意事项】

1. 患儿应卧床休息，给予对症治疗，必须隔离，直至腺肿完全消退为止，若并发睾丸炎患者应延长卧床休息时间。

2. 病期给予半流质或软食，保证充足的液体入量，避免酸性饮料。

3. 保持口腔清洁，经常用温水或复方硼酸溶液漱口。

4. 若腮腺及头痛较甚者，可适当采用解热镇痛药。但磺胺药及抗生素对本病无效。

5. 局部外涂药紫金锭1枚，用醋研细末，外涂腮肿部位，每日1～2次。

小儿麻痹后遗症

小儿麻痹后遗症属中医学的“痿症”、“痿躄”等范畴。以肢体瘫痪，不能站立行走，失去自主活动能力为主症。大多发生于1～5岁小儿，以夏秋季节发病为多。推拿治疗本病效果

良好，不但能增强肌力，并能纠正骨骼畸形。

【病因病机】

本病是由风、热、暑、湿时行疫毒之邪，从口鼻入侵，首先犯肺，肺失清肃，故出现类似感冒的发热，身痛、咽红、咳嗽等症；胃失和降则呕吐腹痛或腹泻等消化道症状；邪毒流窜经络、四肢百骸则肢体疼痛，出现麻痹；病久损及肝肾则肢体痿软，肌肉萎缩及骨骼畸形等后遗症状。

现代医学认为，本病是由特异性嗜神经病毒引起的急性传染病，病变主要发生在脊髓（也可累及延脑、桥脑、中脑及小脑），累及脊髓前角的运动神经细胞，故临床表现为相应组织的弛缓性麻痹。

【临床表现】

小儿麻痹症的临床表现可分为三个阶段：

1. 急性发作期（前驱期）　在出现肢体瘫痪前，先有发热，食欲不振，或伴有呕吐、腹泻、咳嗽、咽红、全身不适等呼吸与消化道症状，2～3天后常可热退，诸症消失。

2. 瘫痪前期（瘫痪期）　在热退后1～6天，常可再次发热，并出现烦躁不安，易出汗，肢体疼痛等症状，几天后逐渐出现部分肢体瘫痪。随着热度的减退，其他症状逐渐消失，瘫痪也不再发展。瘫痪的特点呈弛缓型，分布不规则，不对称，常见于四肢，以下肢瘫痪最多。若颈、胸部脊髓神经受损，可出现膈肌、肋间肌麻痹。延髓受损时可发生咽部肌群麻痹，出现呼吸障碍等危重症状。

3. 恢复期（后遗期）　瘫痪有自动恢复的趋势，热退后1～2周，开始逐渐恢复。恢复的快慢常与神经受损程度有关，一般在1～6个月内如不能完全恢复，常遗留残余症状，称为

后遗症。这时肌肉明显萎缩，肢体常出现各种畸形，如口眼歪斜，头向左右倾倒，脊柱侧凸，肩关节如脱臼状，膝后凸或外展，足内翻、足外翻、马蹄形、仰趾足等畸形。

【处方与配穴】

通经活血，柔筋养肌，矫正畸形。

面部：取坐位，用推揉法自攒竹（在眉毛内侧端，当内眦的上方，图 190）斜向瞳子髎（在目外眦外侧，当眶骨的外缘，图 191）、颊车（见图 78）、地仓穴（在巨髎下方，噘角的外侧定穴，图 192），往返治疗 5～6 遍。

图 190　攒竹

图 191　瞳子髎

颈及上肢部：取坐位。用推法自天柱（在后发际上 0.5 寸，平哑门，当斜方肌的外侧，图 193）至大椎、肩井等处往返数次，再推揉肩关节周围，然后用拿法自三角肌、肱二头肌至肘部，再下沿前臂到腕部，往返数次。婴幼儿可配用摇肘肘、摇洪池，3～5 次。

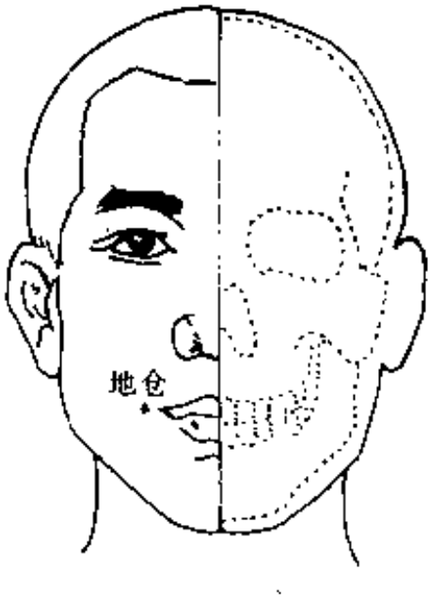

图 192　地仓

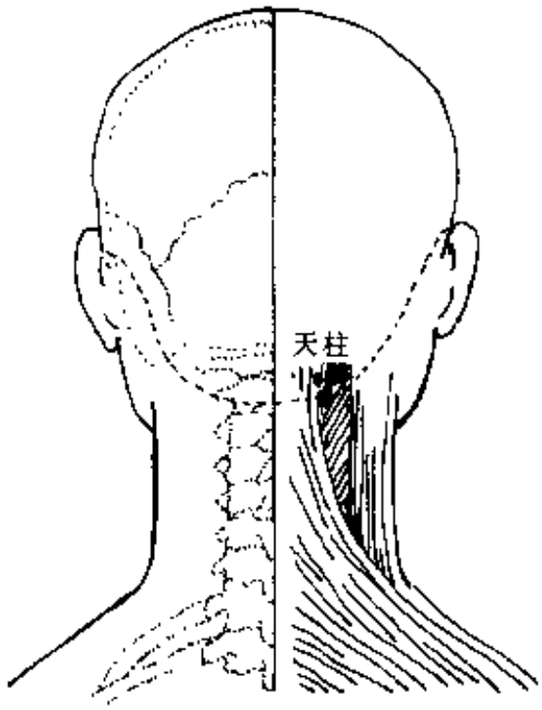

图 193　天柱

腰及下肢部：取俯卧位。用㨰法或配合小㨰法，从腰部起向下至骶尾部、臀部，循大腿后侧往下至足跟，往返数次，配合按揉肾俞、腰阳关、命门、八㨰（图 194），拿委中。接着取仰卧位，用㨰法自股前至小腿外侧往返数次，配合按揉足三里、风市（直立垂手时中指尖所指处）、阳陵泉（在腓骨小头前下缘凹陷中取穴）、悬钟（在外踝高点上 3 寸处，腓骨前缘取穴）（图 195）、解溪（在足背踝关节的横纹中央，拇长伸肌腱与趾长伸肌腱之间凹陷中，约与外踝高点相平）（图 196）穴等。同时配合髋关节、踝关节摇法。

每日或隔日治疗 1 次。

麻　疹

麻疹是小儿最常见的发疹性传染病，多流行于冬春季节，

传染性强，病愈后，免疫力强，一般终身不再感染。本病多见于6个月以上的婴幼儿，为儿科麻、痘、惊、疳四大症之一。

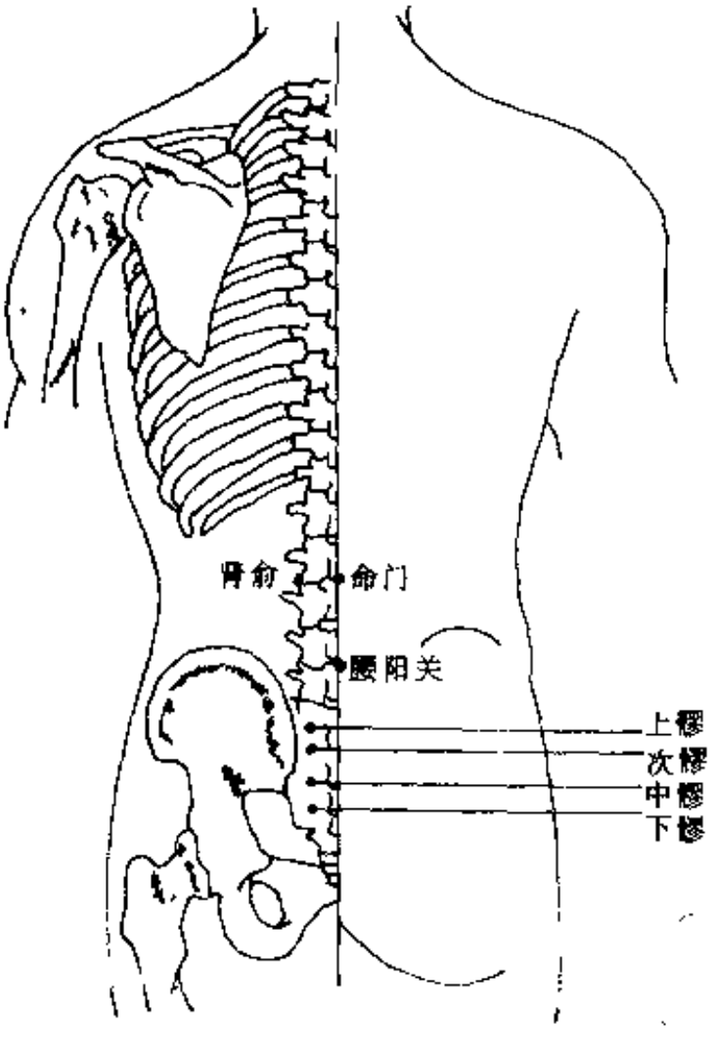

图194　肾俞、腰阳关、命门、八髎

【病因病机】

本病多由于外感时邪病毒，从口鼻而入，侵犯肺、脾两经。肺主皮毛，脾主肌肉，故疹点隐隐于皮肤之下，累累于肌肉之间。

现代医学认为，本病病原为麻疹病毒，由飞沫传染而引起。

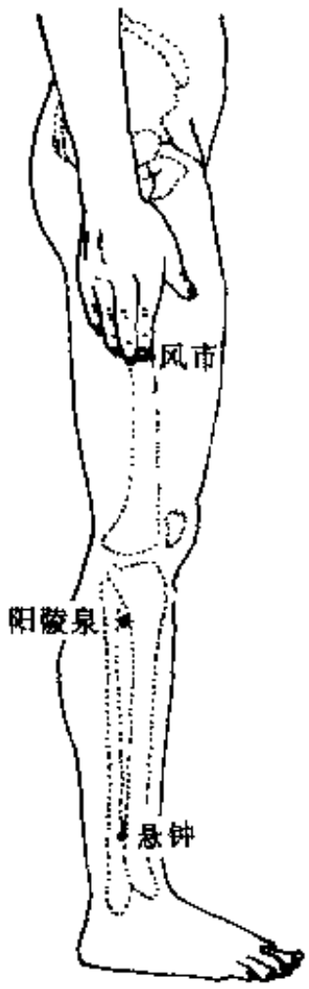

图 195　风市、阳陵泉、悬钟

图 196　解溪

【临床表现】

本病在临床上分为疹前期、出疹期、恢复期。且有顺逆之辨：疹前期可见发热、眼泪汪汪，鼻流清涕，发热 3 天左右可见遍体出现红色疹点，稍见隆起，扪之碍手，状如麻粒，口腔内可见粘膜斑。出疹从耳后发际开始，继则面部，延及颈部、躯干，最后至四肢直至手足心底，退疹程序与出疹相同，先出先退，后出后退，出疹较快，一般 3 天左右出齐，回疹较慢，在鼻尖与面颊部疹子较多，此为顺症，预后良好。逆症则见疹点透发不爽，或隐而不现，或稀疏不齐，疹色紫黯，或见疹点

骤然消退，且伴有并发症，并发症以肺炎为多，症见体温升高，咳嗽气急，寒战胸痛，痰声噜噜，甚至面色苍白，唇甲青紫等。

【处方与配穴】

根据麻疹分期的不同而有所侧重。

1. 疹前期　解肌透表。推攒竹，推眉弓，揉太阳，清肺经，揉肺俞，揉风门（在第2胸椎棘突下旁开1.5寸），推三关。

2. 出疹期　清热解毒，透疹达邪。清天河水，揉小天心，揉一窝风，掐揉二扇门，清胃经，清肺经，揉肺俞，推脊。

若见疹色紫赤，稠密成片，身热烦渴为热毒炽盛，宜加退六腑，多清天河水；并发肺炎宜加推揉膻中，分推肩胛骨，多清天河水、揉肺俞、清肺经，以加强宣肺解表，清热解毒之作用。若高热抽搐者加掐人中、掐老龙，以开窍醒神、止抽搐。

3. 恢复期　养阴补虚。补脾经，补肺经，补肾经，揉上马，揉板门，揉中脘，揉足三里，捏脊，清天河水。

每日推拿1次。

【注意及预防】

1. 患儿应卧床休息，避免直接吹风，保持口腔及眼鼻清洁。

2. 室内空气要流通，随气候变化而勤换衣服，免受风寒。

3. 避免接触麻疹患者，防止传染。

4. 注射麻疹减毒活疫苗，进行免疫。

第五章　小 儿 保 健

第一节　喂养与保健

一、提倡母乳喂养

母乳是最好的天然营养品，它含有适量的糖、脂肪和容易消化的蛋白质，还有丰富的维生素、消化酶以及一定浓度的免疫球蛋白。另外，由于母乳不会被病菌感染，直接喂母乳可避免胃肠病，有利于孩子的健康发育。经临床观察，由母乳喂养的孩子发病率明显低于人工喂养的发病率。其哺乳方法如下。

1．时间：正常产的新生儿出生后不立即喂奶，只喂少量水，使母子均能休息。8～12 小时后开始喂奶，以后每 3 小时喂 1 次，夜间停喂 1 次，一昼夜 6～7 次，4～5 个月后可减为 5 次。随年龄的增长逐渐延长至 3.5～4 小时喂 1 次。每次喂奶时间 15～20 分钟，但以吃饱为宜。小儿吃饱后往往是吐出奶头或入睡，或玩耍。喂奶次数要有规律，不定时哺乳不利于小儿的消化。但也不能机械执行，如果未到 3 小时婴儿饥饿哭叫亦可适当提前喂奶。在哺乳期间，乳母应加强营养，多吃鸡蛋、肉类及小米汁等，以利乳汁的补充。

2．方法：哺乳时应将小儿斜抱起。哺乳后将婴儿抱起轻拍其背部，使吸入的空气徐徐排出，以防止溢乳。哺乳时最好每次吸完一侧再吸另一侧，下次再先吸上次未排空的一侧，这

样可保证乳腺排空，有利于刺激乳汁分泌。

3. 断乳：母乳喂养虽适宜，但随年龄的增长而感不足。又因婴儿消化机能的发育和牙齿的长出，对食物的质和量提出了新的要求，因此在一定时间需添加一部分辅助食物，一方面为补足营养的需要，同时亦为断乳做好准备。断乳应逐渐进行，一般在1岁或迟至1岁半应完全断奶。断乳时若逢夏天，可延至秋凉，母乳不足者应提早；母乳量多或体弱儿可适当延迟。断乳开始，每日减少哺乳1次，并以辅食代替，以后逐渐增加辅食次数，减少哺乳次数。若过长母乳喂养，小儿易发生营养缺乏病，母亲得不到休息，对母子双方均有弊无利。

二、人工喂养与混合喂养

在母乳不足时，可根据婴儿的月龄和奶量缺乏情况添加代乳品及辅食。两三个月的婴儿可采用牛奶加米汤，但必须喂完奶后再补充牛奶。因奶瓶的奶汁容易吮出，如果先喂牛奶再喂母奶，婴儿吃不饱就不再吃母奶了。4～6个月的孩子可添加蛋黄、米粥或菜泥等。

母乳无奶时要采用人工喂养。首先喂牛奶，半个月以内的婴儿要选用鲜牛奶，再加1/2或1/3开水或稀米汤，逐渐改为1/3～1/4米汤，满月以后加1/4的米汤。婴儿到1个月后可以用全奶。在用奶时可以加适当的糖。羊奶的成分差不多与牛奶相同。豆浆营养成分也较好，含有大量蛋白质，但以鲜豆浆为最好。喂的时候，1匙豆粉加8匙温水及少量炒米粉和糖煮沸即可。1匙奶粉加4匙水后与全奶一样。

采用人工喂养时，要注意奶的质量和人工喂养用具的消毒。人工奶头孔不要过大，一般掌握在6个月以后的婴儿，每

次在 10～15 分钟左右能吸完较为合适。

辅食的添加应根据年龄来选择和调配，见表 2。

表 2　　各年龄辅食添加表

1～3 个月	维生素 A、C、D 菜汤、果汁、鱼肝油等
4～6 个月	蛋黄、鸡蛋糕，煮烂的胡萝卜、苹果泥，糊状米粥、代乳粉等
7～9 个月	饼干、馒头片、面片、面条、烂饭、熟土豆及地瓜、芋头、鸡蛋、窝窝头等
10 个月以后	各种软食、豆制品、蔬菜、鱼、肉末、带馅食品等

断奶后的饮食。此时婴儿的乳齿将出齐，咀嚼能力加强，活动量增加，因此食物种类要多样化。除不宜给过多脂肪、糖类，以及酸辣或不易消化的食品外，成人用的食物均可食用。添加食物要循序渐进，不宜过多、过快，即使年龄逐渐增大，饮食也不可饥饱无度，以免损伤脾胃，造成营养不良。

第二节　预防接种保健

许多传染病在人的一生中只得一次。因为病原（细菌或病毒）刺激身体免疫系统（包括胸腺、骨髓、淋巴结等）产生抗体与抗原结合，使其失去致病力。每种抗原只能产生相应的抗体，预防接种就是将对人体危害性强的某些病原，采用人工处理使其毒性减低或杀死细菌，或只用它的毒素，即“生物制品”，把它接种到小儿身体内后，同样可以激发免疫力，达到不生这种传染病的目的。有计划地广泛开展预防接种，以提高人们的免疫水平，是预防和消灭传染病的重要措施。

一、目前常用计划免疫苗

现在常用的免疫苗有抗结核病的卡介苗，抗百日咳、白喉、破伤风毒素的联合疫苗，还有抵抗麻疹、脊髓灰质炎、脑膜炎、乙脑的疫苗等，见表3。

表3　　小儿常用自动免疫接种表

免疫剂	初种年龄	免疫形成时间	免疫期	复种时间	备　注
结核菌苗（活苗）	初生2个月内	6～8周	2～4年	3～4岁、7～8岁、10～14岁 各1次	复种前先做结核菌素试验，阴性者复种
百日咳菌苗	3个月后（每隔4周注1次，共3次）	1个月	1～3年	1～3年再注1次	
三联疫苗（百日咳、白喉、破伤风）	3～6个月（每隔4周注1次，共3次）	1个月	2～3年	1～2岁、3～4岁、5～6岁 各1次	
牛痘活疫苗	2～6个月及逾期未种者	3周	5～10年	6～7年1次	初种未出者，再种一次
麻疹减毒活疫苗	6～10个月易感儿	16天	4年以上	4～5岁	
脊髓灰质减毒活疫苗（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型）	2～6个月（每隔4周1次，共2次，第一次Ⅰ型1粒，第二次Ⅱ、Ⅲ型各1粒	2个月	1年	1～2岁、2～3岁 各1次	与其他疫苗接种应间隔1个月以上

（续表）

免疫剂	初种年龄	免疫形成时间	免疫期	复种时间	备　注
乙型脑炎活疫苗	6个月以后(7～10天1次，共2次)	3周	1年	1年1次至12岁	
流脑死菌苗	6个月以后(3～4周1次，共2次)	20～30天	1年	1年1次	
波状热活疫苗	牧区波状热菌素反应阴性	2～3周	1年	1年1次	

二、对接种疫苗后发生反应的处理

大多数疫苗接种后是没有反应的，只有少数小儿有反应，如接种后局部红肿、疼痛，有的出现发烧、头痛和全身不适等症状。这些反应只要多休息，细心护理，发高烧时服点退热药，多喝点温开水，一两天会自然好的。反应重的应报告注射医生或到医院就诊。

三、预防接种应注意的几个问题

1．空腹饥饿时不易注射预防针，以防血糖过低引起严重反应。

2．患有感冒、发热、扁桃体炎和其他慢性疾病，如肺结核、心脏和肾脏病未恢复健康者暂不宜接种。

3．患有过敏性疾病，如荨麻疹、气管炎、哮喘等病时不宜接种。

4．患有皮肤病不宜接种疫苗。

预防接种对控制小儿传染病的发生，保证小儿健康成长起着极为重要的作用。为了减少传染病的发生，注意不要让小儿

跟患病儿接触，不携带小儿去探望病人，不到人员拥挤、商场、电影院的地方去。家长如发现小儿得了传染病，应立即与健康儿隔离，使他们注意预防，实行检疫，以免再扩散传播。

第三节　健脾胃保健法

中医学认为，“脾胃为后天之本，气血生化之源”、“小儿脾常不足”。由于小儿生长发育快，需要的水谷精微较成人迫切，但因小儿脏腑形态发育未全，运化功能也未健全，易为饮食所伤而出现厌食、腹泻、呕吐等脾胃症状。因此注意调理脾胃，使其正常运转是儿童健康成长的基本保证。

运用有关推拿保健穴位，具有健脾和胃，增强食欲，调理气血，增强抗御疾病能力的作用。

【处方配穴】

补脾经500次，摩腹3～5分钟（顺时针、逆时针各操作半数），揉足三里（双侧）各50～100次，捏脊3～5遍。

每日1次，6次为一疗程，疗程间休息3天，再行下一疗程，一般在清晨或饭前操作。

若急性传染病期间可暂停，待病愈后再进行。

第四节　眼睛保健法

眼睛是人体的重要器官，保护视力对生活起居、工作学习、保持充沛的精力有密切的关系，故须从小养成保护眼睛的好习惯。通过保健按摩手法对穴位的刺激，达到疏通经络、调和气血、增强周围肌肉的血液循环，改善眼部神经的营养，使

眼肌的疲劳得以解除。

【处方配穴】

推攒竹 50 次，以指端由下而上交替直推（图 197）；揉鱼腰 50 次（见图 183）；揉睛明 50 次，（图 198）；揉太阳 50 次（图 199）；揉眉弓（见图 179）；浴目 30 次，轻闭双眼，两手四指擦热后，由目内眦推向目外眦轻摩（图 200）；按揉颈部棘突 5～10 遍；以两手食指腹按揉四白 50 次（图 201）；拿风池、曲池、合谷、肩井各 3～5 次。每日操作 1～2 次。

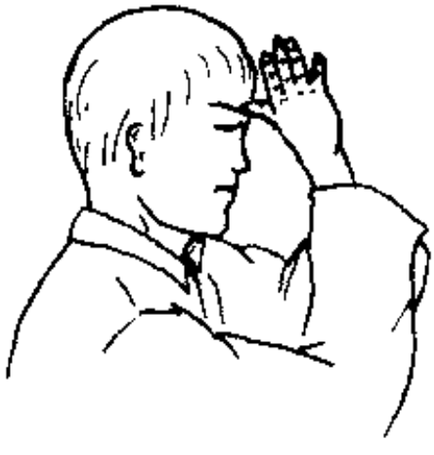

图 197　推攒竹

图 198　揉睛明

图 199　揉太阳

图 200　浴目

图 201　按揉四白

【注意事项】

1. 本法对 7～12 岁的儿童最为适宜，每天可在课间或作业后进行。

2. 按揉穴位要正确，手法要轻缓，以轻微酸胀为度，不宜过分用力，以免擦伤皮肤。

3. 要经常督促学生剪短指甲，保持双手清洁。

4. 推拿毕可以视远处绿色植物。

5. 尽量减少甜食。

第六章　小儿推拿歌赋选

在小儿推拿著作中，除了对小儿病症的诊断、穴位、手法和病症的治疗方法有较多记述外，且在各方面以歌赋形式著述者甚多，这些歌赋大都内容朴实，便于学习记忆。兹辑录如下，以供临床学习参考。

小儿无患歌（《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》）

孩童常体貌，情志自殊然，
鼻内干无涕，喉中绝没涎。
头如青黛染，唇似点朱鲜，
脸若花映竹，颊绽水浮莲。
喜引方才笑，非时手不撒，
纵哭无多哭，虽眠未久眠。
意同波浪静，性若镜中天，
此候俱安吉，何愁疾病缠。

认色歌（《按摩经》）

眼内赤者心实热，淡红色者虚之说，
青者肝热浅淡虚，黄者脾热无他说，
目无精光肾虚诀。

儿子人中青，多因果子生，
色若人中紫，果食积为痞。
人中现黄色，宿乳蓄胃成，
龙角青筋起，皆因四足惊。
若然虎角黑，水扑是真形，
赤色印堂上，其惊必是人。
眉间赤黑紫，急救莫沉吟，
红赤眉毛下，分明死不生。

面部五位歌（《按摩经》）

面上之症额为心，鼻为脾土是其真，
左腮为肝右为肺，承浆属肾居下唇。

面色图歌（《按摩经》）

额、印堂、山根：

额红大热燥，青色有肝风，
印堂青色见，人惊火则红。
山根青隐隐，惊遗是两重，
若还斯处赤，泻燥定相攻。

年寿：

年上微黄为正色，若平更陷夭难禁，
急因痢疾黑危候，霍乱吐泻黄色深。

鼻准、人中：

鼻准微黄赤白平，深黄燥黑死难生，
人中短缩壮因病，唇口黑候蚓必倾。

两太阳：

太阳青色凉方始，红色赤淋萌蓐起，

要知死症死何如，青色从兹生入身。

两脸：

两脸黄为痰色咽，青色客忤红风热，

伤寒赤色红主淋，二色请详分两颊。

辨小儿五色受病症：

面黄青者，痛也。色红者，热也。色黄者，脾气弱也。色白者，寒也。色黑者，肾气败也。

哭者，病在肝也。汗者主心，哭者主脾而多痰，啼者主肺有风，睡者主肾有亏。

分补泄左右细详秘旨歌（《幼科推拿秘书》）

补泄分明寒与热，左转补兮右转泻，

男女不同上下推，子前午后要分别。

寒者温之热者凉，虚者补之实者泻，

手足温和顺可言，冷厥四肢凶莫测。

十二经中看病源，穴真去病汤浇雪。

保婴赋（《幼科推拿秘书》）

人禀天地，全而最灵，

原无夭札，善养则存。

始生为幼，三四为小，

七龠八龀，九童十稚。

惊痫疳癖，伤食中寒，

汤剂为难，推拿较易。

以其手足，联络脏腑，

内应外通，察识详备。
男左女右，为主看之，
先辨形色，气现虚实。
认定标本，手法祛之，
寒热温凉，取效指掌。
四十余穴，有阴有阳，
十三手法，至微至妙。
审症欲明，认穴欲确，
百治百灵，万不失一。

手法同异多寡宜忌辨明秘旨歌（《幼科推拿秘书》）

小儿周身穴道，推拿左右相同，
三关六腑要通融，上下男女变通。
脾土男左为补，女补右转为功，
阴阳各别见天工，除此俱该同用。
急惊推拿宜泻，痰火一时相攻，
自内而外莫从容，攻去痰火有用。
慢惊推拿须补，自外而内相从，
一切补泻法皆同，男女关腑异弄。
法虽一定不易，变通总在小心，
本缓标急重与轻，虚实参乎病症。
初生轻指点穴，二三用力方凭，
五七十岁推渐深，医家次第神明。
一岁定须三百，二周六百何疑，
月家赤子轻为之，寒火多寡再议。
年逾二八长大，推拿费力支持，

七日十日病方离，虚谁医家难治。
禁用三关手法，足热二便难通，
渴甚腮赤眼珠红，脉数气喘舌弄。
忌用六腑手法，泻青面㿠白容，
脉微呕吐腹膨空，足冷眼青休用。
小儿可下病症，实热面赤眼红，
腹膨胁满积难通，浮肿痄腮疼痛。
小便赤黄壮热，气喘食积宜攻，
遍身疥疮血淋漓，腹硬肚痛合用。
不可下有数症，囟陷肢冷无神，
不时自汗泄频频，气虚干呕难忍。
面白食不消化，虚疾潮热肠鸣，
手焦神困脉微沉，烦躁鼻寒咳甚。

用汤时宜秘旨歌（《幼科推拿秘书》）

春夏汤宜薄荷，秋冬又用木香，咳嗽痰吼加葱姜，麝尤通窍为良；加油少许皮润，四六分做留余，试病加减不难知，如此见功尤易。四季俱用葱姜煎汤，加以油麝少许推之。

推拿代药赋（《幼科铁镜》）

前人忽略推拿，卓溪今来一赋。寒热温平，药之四性；推拿揉掐，性与药同。用推即是用药，不明何可乱推。推二三关，代却麻黄肉桂；退下六腑，替来滑石羚羊。水底捞月，便是黄连犀角；天河引水，还同芩柏连翘。大指脾面旋推，味似人参白术，泻之则为灶土石膏；大肠侧推虎口，何殊诃子炮姜，反之则为大黄枳实。涌泉右转不揉，朴硝何异；一推一揉

右转，参术无差。食指泻肺，功并桑皮桔梗；旋推止嗽，效争五味冬花。精威拿紧，岂羡牛黄贝母；肺俞重揉，慢夸半夏南星。黄蜂入洞，超出防风羌活；捧耳摇头，远过生地木香。五指节上轮揉，乃祛风之苍术；足拿大敦鞋带，实定掣之勾藤。后溪推上，不减猪苓泽泻。小指补肾，焉差杜仲地黄。涌泉左揉，类夫砂仁藿叶。重揉手背，同乎白芍川芎。脐风灯火十三，恩符再造。定惊元宵十五，不啻仙丹。病知表里虚实，推后重症能生，不谙推拿揉掐，乱用便添一死。代药五十八言，自古无人道及，虽无格致之功，却亦透宗之赋。

面部推拿次第歌（《推拿捷径》）

第一先推是坎宫，次推攒竹法相同。
太阳穴与耳背骨，三四全凭运动工。
还有非推非运法，掐来以爪代针锋。
承浆为五颊车六，聪会太阳七八逢。
九至眉心均一掐，循循第十到人中。
再将两耳提三下，此是推拿不易功。

认虚实二症歌（《按摩经》）

实症：

两腮红赤便坚秘，小便黄色赤不止，
上气喘急脉息多，当行冷药方可治。

虚症：

面光白色粪多青，腹虚胀大呕吐频，
眼珠青色微沉细，此为冷痰热堪行。

看食指定疾诀（《幼科推拿秘书》）

虎口有三关，紫热红伤寒，青惊白是疳，黑即人中恶，黄者是脾端，三关者即风气命三关也。

推拿三字经注释

徐谦光——徐宗礼字谦光。

奉萱堂——母亲患病不能服药，于是习练推拿。

药无缘——服药即吐，无法治疗。

推拿恙——患病的母亲接受推拿后不药而愈。按母亲之意这样做是孝尽。

自推手——从此以推拿作为治病的手段。

辨渚恙——辨别疾病的性质、类型，然后决定使用的手法。

定真穴——找出有效的穴位。

画图章——摸清人身上的穴位，并画出图表，以备忘记。

上疗亲——在上治疗亲属、朋友或高贵人的疾病。

下救部——在下可解救贫民百姓的疾苦。

推求速——推大人速度要快，手法要重，速度快可以使气血循行加快，驱除外邪；推小儿速度也要快，但手法要轻柔。

惟重良——推拿就像采用其他良方一样，只要弄清什么病，辨明用什么穴，依法推拿，立刻见效。

独穴治——独穴是指一个穴位而言，推拿时间要长，速度要快。

有良方——良方是指推后立即见效。只要配穴适当，无不应手而愈。

大三万——16岁以上为大。此时小儿血气旺盛，所以推拿次数要多，不能拘泥于死数。

小三千——5～10岁为小，男则气血未强，女则天癸未至，发育还不成熟，所以推拿次数宜少。

婴三百——1岁以内为婴儿，血气细弱，所以推拿次数更要减少。

加减良——人的身体有强弱之分，年龄大小不等，病情轻重差异，临床推拿时要酌情施治方可取得良好效果。

分岁数——分清病人的年龄大小。

轻重当——依据病的轻重程度，施治恰当。

从吾学——学习只要熟读，善于思考，即求学可成。

立验方——不断总结有效的穴位，确立有效的治病方法。

宜熟读——要认真读书，不熟读就不能灵活应用。

勿心慌——不宜粗心大意，应认真踏实，否则学不好推拿。

治急病——治疗急性病。

一穴良——只要认真推拿，有的病一穴就能治愈。

大数万——大人需推拿数万次。

立愈恙——只要选穴准确，病能立即痊愈。

幼婴者——1～3岁的小儿。

加减良——根据年龄的大小和病情的轻重，确定推拿次数的多少。

治缓症——多指病久不能自愈的外感、痨伤或内伤等症。

各穴良——选好穴位，认真操作，无不奏效。

虚冷补——虚冷者为寒气亏，当用补法治疗。

热清当——热病当用泻法治疗。

大察脉——大人要察看脉象，分清色泽，要弄清何色与何脏腑有关。

理宜详——病因病理要详细分析。

浮沉者——浮脉主表证，轻手可得；沉脉主里证，重按可取。

表里恙——要辨别是表证还是里证。

迟数者——迟脉主寒证，一息三至；数脉主热证，一息六至。

冷热分——要分清寒热之证是由内因还是外因引起的。

推无恙——只要辨明何病，分清表里，弄清寒热，推后立愈。

虚与实——通过脉象辨别疾病的虚实。

仔细详——脉的虚实，要仔细推详。

字廿七——脉有二十七种。

脉诀讲——治病虽讲脉诀，但也有脉与病不相符者，应细心体会。

明四字——弄清脉的浮、沉、迟、数四种常见脉象。

治诸恙——多数疾病不外乎四脉，一般病多为此四脉。

小婴儿——小儿之脉用指诊断，先明迟还是数。迟为寒，数属热。

看印堂——小儿脉短小，以看印堂为宜。

五色纹——即青、赤、黄、白、黑五种肤色。

细心详——印堂穴处用水洗干净，观察其肤色，分清红、白、黄、黑、青五色，以色确诊。

色红者——左两目之间，睛明之上出现红色者，是心肺内热所致。

心肺恙——色紫者热较甚，因肺与心相连，凡有红筋，多为心肺疾患引起。

俱热证——色红者都是热证。

清则良——热病用泻法，病速痊愈。

清何处——只要分清小儿印堂五色纹，便知病在何处，选用何穴。

心肺当——以清心、清肺为主。

退六腑——色紫者为热重，须加退六腑穴。

即去恙——即可退心、肺经之热证。

色青者——多指肝风引起（肝的本色）。

肝风张——若肤色青，则多由肝风内动或惊吓而引起。

清则补——清补者必须辨明虚实，虚则补之，实则清之，虚实夹杂的要攻补兼施。

自无恙——清补得宜，自能祛病。

平肝木——肝为将军之官，可平不可补。虚则补其母，即补肾达到补肝的目的。

补肾脏——补肾即补肝，肾为肝之母，古人言水生木即指此而言。

色黑者——色黑一般是风盛，指肾中有寒。

风肾寒——风入肾经，使肾的外在表现发黑，必是寒证。

揉二马——揉二马（上马）穴能补肾中水火，清除寒邪，使全身发热。

清补良——若上热下寒，必须清上温下。

列缺穴——诸风，诸惊，必须拿列缺穴，肾寒久拿出汗，风邪自解。

亦相当——列缺穴能解寒，并能解痉止痛，是用之有效的

穴位。

色白者——白色主肺，是肺的表现。

肺有痰——印堂色白者，多为肺中有痰。

合阴阳——自阴池、阳池处向中间合推。

天河水——此穴能清上焦之热，重推可去痰。

色黄者——印堂肤色黄者，为脾胃之症。

脾胃伤——小儿多指脾胃症状。印堂处发黄多是食积损伤脾胃。

若泻肚——如果小儿腹泻，多因脏腑功能未发育成熟，加之久泻损伤小儿正气，使肠胃失调而作泻。

推大肠——大肠与肺相表里，其穴在食指桡侧边缘。

来往忙——往返多次推拿，效果才佳。

言五色——指红、青、黄、白、黑五色。

兼脾良——脾为心之子，因小儿饮食不节，多损伤脾胃，所以治腹泻多加用补脾经。

曲大指——大指桡侧属脾，用补法时必须微曲指向里推拿。

补脾方——脾为万物之母，后天之本。主治脾虚引起的消化道症状。

内推补——屈指向内推为补法。

外泻详——伸拇指向外推为泻法，来回推为清补法。

大便闭——是脾经有热所致。

外泻良——伸直大拇指，向外推为泻脾。

泻大肠——大肠与肺相表里，肠结是肺燥所致，肺燥大肠亦燥，必须用泻法以清热通大便。

立去恙——脾肺为母子之脏，若燥用泻法立愈。

兼补肾——肾为先天之本，在用上方的同时加用补肾。

愈无恙——用推法治愈者，一般无反复。

若腹痛——小儿腹痛多因寒邪或伤食所致。

窝风良——一窝风穴能治寒气。

效在万——一窝风穴专治寒邪，尤其治腹痛应手而愈。

立无恙——推后很快止痛病愈。

流清涕——鼻流清涕者，多因风寒而得，多揉一窝风立愈。

风感伤——因外感风邪而致病。

蜂入洞——用食、中二指轻入鼻孔，上下推揉之为黄蜂入洞。

鼻孔强——鼻为肺之窍，左右旋揉。

若洗皂——以食、中两指分开在鼻翼两旁上下推揉，或屈两拇指，以拇指桡侧缘贴紧迎香穴做往返上下摩擦，局部热则止。

鼻两旁——洗皂穴的位置在鼻两旁。

向下推——屈食、中指或屈两拇指桡侧，由上向下推。

和五脏——调和五脏之气。

女不用——女子不用此穴。

八卦良——不用洗皂穴，用八卦穴代之，也能调和五脏之气。

若泻痢——如泻肚和痢疾病症。

食指侧——食指桡侧面为大肠之真穴。

上节上——食指外侧由指根至指端第三节。

来回推——用轻快柔和之力量来回推，其数可根据病之轻重程度而变化。

数万良——病重者推的时间要长。

牙痛者——指阴虚火旺，虚火上炎所致牙痛。

骨髓伤——肾精耗损，水不济火，虚火上炎。

补肾水——补肾水能滋水潜阳，治虚火上炎。

推二穴——若推二马和肾经穴不见效，反而痛甚者为实火，重推六腑治愈为止。

治伤寒——伤寒汗出而解，自感冒后久治不愈则传里。

拿列缺——重推列缺穴，毛孔俱汗，汗出而解。

出大汗——用力久拿，必出大汗，自头至足方可为佳。

受惊吓——小儿受惊吓时先掐五指节，每节各掐揉3～5次。

拿此良——拿此穴即愈。

不醒事——昏迷不省人事。

亦此方——神志昏迷，目闭口紧者拿此穴必醒。

或感冒——指伤风、伤寒等一切外感之症。

急慢惊——急惊风和慢惊风等病。

非此穴——非拿列缺穴不可，故称“仙掌妙穴”。

忌风扬——推拿后汗出要忌风，以防风邪乘虚而入。

霍乱病——即上吐下泻病。此病有很强的传染性。

暑秋伤——发病于暑后秋前，因中暑气又中寒气所致。

若止吐——上吐者为阳霍乱及受暑过重，胃气不降所致。

清胃良——清胃经对止吐有良效。

大指根——大鱼际的外侧缘（从手腕至大拇指根的桡侧赤白肉际处）。

震艮连——为八卦穴中的两个方位。

黄白皮——胃穴上为黄白之皮肤时，自艮向外推为清。

真穴详——赤白肉际处为胃之真穴。

凡吐者——凡是呕吐的病人都要从里向外推，不仅指霍乱病。

俱此方——病人呕吐是胃气上逆而不降，所以要清胃以降胃气。

向外推——凡治气逆可用泻法，以便使气下降，呕吐自止。反之使气上逆。

倘肚泻——泻肚者为肠胃不和或感受暑热寒邪所致。

仍大肠——仍来回清补大肠，利小便，腹泻即止，故能立愈。

吐并泻——吐泻病人可见于霍乱，此病多由于感受瘟疫所引起。

板门良——板门穴属胃经，此穴能健脾助运，止吐泻，通达上下之气。

揉数万——吐泻较重患者，推拿次数应多。

立愈恙——板门多揉之，能很快痊愈。

进饮食——吐泻停止，病愈后则能进饮食。

亦称良——板门穴属胃经，不仅治上吐下泻，又能治心下痛（胃痛），故称良穴。

瘟疫者——瘟疫伤寒，两脉细而数，虽汗不解为瘟疫。

肿脖项——指痄腮而言，耳垂下红肿疼痛，现称腮腺炎。

上午重——此病一般表现上午发热病重，下午较轻。

六腑当——重推六腑治愈为止。此穴大凉犹如生石膏、羚羊之寒性。

下午重——下午属阴，多为寒证。

兼六腑——兼退六腑穴，以泄热清腑解毒。

立消亡——只要用此穴病很快治愈。

分男女——取穴时男女不一样。

左右手——男用左手，女用右手。

男六腑——男孩多用左手六腑，方法是向下推，此称退六腑。

女三关——女孩多用右三关穴，方法是向上推。

此二穴——指六腑与三关穴。

俱属凉——左六腑和右三关，男女相反而穴相同，只是有阴阳不同。

男女逆——男女不同。

左右详——男女阴阳有别，故左右手穴位也相反，应分清。

脱肛者——直肠脱出肛门，多为肺脾气虚，阴寒之气不足所致。

肺虚恙——因肺虚引起的疾病。

补脾土——中医认为，土生金，脾为肺之母，肺为脾之子，肺虚可以补脾，以培土生金，脾气足，肺气亦足。

二马良——二马为补肾滋阴要穴。若肺虚日久可影响及肾，金（肺）生水（肾），故掐揉二马以补肾可取显效。

补肾水——补肾水就是滋水补肾阴，肾阴足则水火相济，阴阳平衡，身体强壮。

推大肠——大肠为肺之腑，若肠虚而不能升提，下陷之气使直肠脱出肛门难愈。今用推补法，使肠健而肺气旺盛，肺气旺则能升提下陷之气，病则痊愈。

来回推——来回推大肠能固大肠而利小便，和血顺气，故治疗脱肛、痢疾、腹泻等病症。

久去恙——此病恢复较慢，故推拿时间应该长。

或疹痘——一般说疹出于腑，痘出于脏。

肿脖项——疹痘结于项间，必须男推六腑女推右三关。以泻热解毒。

仍照上——依照腮腺炎的方法治疗。

午别恙——根据上下午得病时间分辨阴阳。

诸疮肿——无论什么疮症皆有阴阳之分，治法也不同，阳症用寒穴，阴症用热穴，半阴半阳用清补法以平补平泻。

明此详——一定要辨别发病的时间，然后选择推拿的穴位和时间的长短。

虚喘嗽——这是肾虚咳嗽，咳声无力，呼多吸少，张口抬肩，动则咳喘甚。

二马良——掐揉二马（上马）穴能补肾、壮命门之火，故效果显著。

兼清肺——肺虚则必气逆，在治疗上必须兼以清肺经。

兼脾良——补脾土就是补肺虚，补二马的同时兼补脾则疗效显著。

小便闭——小便蓄于膀胱不能解，是由膀胱气化不利，温化失调所致。

清膀胱——应利尿洁腑，使小便通畅，选用清热利尿之穴。

补肾水——肾水得补而气壮，使温化作用加强。

清小肠——清小肠穴有清热利小便之作用。小肠为分清降浊之机关，浊者归大肠，清者归膀胱，分利有条，小便畅利。

食指侧——食指外侧（桡侧）是大肠穴，大肠为粪便排出的通道。

推大肠——直肠是大肠之末节，下连肛门皆为大肠。

尤来回——小肠下口分别清浊水分，渗入膀胱，粪渣移入大肠，来回推能分别清浊。

轻重当——手法轻重要适当，力量均匀，推数一致。

倘生疮——若身体生疮。

辨阴阳——必须辨清是阴症还是阳症。

阴者补——阴证当用补法。

阳清当——阳证用清法方为恰当。

紫陷阴——凡生疮平塌，白色或紫，而陷者当为阴证。

红高阳——疮色红而焮肿，烦痛高起者，当为阳证。

虚歉者——虚歉者为冷寒所致，是阳毒盛不能外越，寒极生热现象。

先补强——先补者为佳，使邪外出不盘踞于内。

诸疮症——各种疮症属纯阴或半阴者皆有，均以先补为佳。

兼清良——补中兼用清法，使阴邪外出。

疮初起——疮的初起，不分阴阳，大多为气滞血瘀。

揉患上——重揉疮顶之上。

左右旋——向左右各旋100～300数，不可偏数。但脓血已成不可旋揉之。

立消亡——疮顶肿硬旋揉，立刻消亡。

胸膈闷——肝在膈下，肺在膈上，胸肺相连，若五脏之气不调，则胸膈满闷不舒。

八卦详——运内八卦穴（顺时针操作）能宽胸利膈，除胸闷，和血顺气，调和五脏之气。

男女逆——运八卦穴男女有别，男左掌顺运，女右掌逆

运。

左右手——男女逆推分左右手，因阴阳不同，故穴位相反。

运八卦——男自左手小指侧（乾卦）开始往大鱼际侧运至兑卦为顺运，女用右手起相返。

离宫轻——近中指根部属心穴（离卦），运八卦时不能推动中指根（离卦），因离卦属心，小儿纯阳之体，心火旺盛，推动后易动心火，损伤心气，故运至离宫（离卦）时宜轻轻而过。

痰壅喘——痰涎壅滞，气血不和则喘。

横纹上——重揉四横纹和血顺气而喘止。

左右揉——顺时针和逆时针交替揉动。

久去恙——凡是虚证日久不能治愈者，必须推的次数多，方可治愈。

治歉症——气虚为歉，血亏为痨，虽不咳却为痨症。

并痨伤——痨在五脏，故为五痨，往往和歉症相并出现。

歉弱者——歉病多为气血亏虚，力不足为歉症。

气血伤——辨气血之症，要看脉准不准，以观察其形体如何。

辨此症——一般气亏作冷，血亏作热。

在衣裳——用衣裳辨别即知，不用多问。

人着袷——人穿着袷衣感到冷时为气虚。

伊着棉——病人穿着棉衣仍觉寒冷为阳气虚，阳气虚故不耐寒冷。

亦咳嗽——作咳嗽不愈者伤于痨症，又名亏痨，为气血双亏所致。

名七伤——此症指七情所伤。

补宜多——歉者多有内伤，是饥饱、痨后所伤，必须重用补法治疗。

清少良——以补多清少为佳。

人穿袷——正常人穿袷衣时，而病者穿单衣。

他穿单——病者虽穿单衣，还觉烦热。

名五痨——伴咳嗽无时，名为五痨，是血亏不能制气。

肾水伤——水停不能制火，故不觉寒冷，是伤于肾气。

分何脏——痨症有五种，须辨明何脏以及为哪种痨症。

清补良——必须多清少补、正好适合病情为好。

在学者——细心诊断，认真研究。

细心详——辨症准确，取穴精当就能治愈。

眼翻者——在急慢惊风时，两眼可上翻或斜视。

上下僵——上下左右翻而不动，两目直视。

揉二马——此穴大补肾中水火。

搗天心——小天心在大小鱼际交接处，用搗法治疗。

翻上者——两眼上视的病人。

搗下良——眼向上视，自小天心往手心方向搗之。

左搗右——往左斜视向右搗之。

右搗左——往右斜视向左搗之，向两旁翻者从两旁向天心搗之。

阳池穴——阳池穴又称膊阳池穴，在腕关节背侧横纹中（一窝风）后3寸处。

头痛良——头痛患儿要以指端揉之，治愈为止。

风头痛——风头痛者乃外感风寒所致。

蜂入洞——指黄蜂入洞，手法同前。

左旋右——由左向右推，不必拘数。

立无恙——用此推法，立刻祛病。

天河水——天河水为通心穴，若心火旺盛，口舌生疮，烦躁弄舌，推此穴能清心泻火，因舌为心之苗。

口生疮——以心脾之火为多，故用天河水以清热泻火。

遍身热——脾生肉，心生火，手热者多系心脾火旺，故清心补脾。清天河水能清心火。

多推良——天河水穴多推为佳。

中气风——中气风为内伤，由外感风邪所致。

男女逆——逆推是指男用右手，女用左手。

右六腑——推手六腑能祛风开郁化痰。

男用良——男用此穴后立刻痊愈，而且不会反复。

左三关——左手三关穴属热性，祛风开郁化痰。

女用强——女逆用左三关方可有效。

独穴疗——凡独穴而不可用二穴，多用则有害。

数三万——凡用独穴必须推三万数，数少则不验。

多穴推——如果病情重，应多选穴，但要分清穴位的主次，不可乱用。

约三万——对慢性病推的时间要长，次数应多。

遵此法——诸症遵此推法，无不见效，不可妄用其他穴位。

遍身潮——遍身潮热，无皮肤无滑腻感觉是汗脉运动在一起。

分阴阳——用两大拇指从总筋向两侧分推为分阴阳。

拿列缺——重拿列缺穴，即用拇、食二指相对用力拿住穴位。

汗出良——汗出即愈。

五经穴——即五指端纹，来回推，能运动五脏之气，治疗腹中疾病。

肚胀良——治疗腹胀效果好。

水入土——运水入土，土者脾胃，水者肾水。

不化谷——五谷不化推运水入土，使脾胃和，脾气不虚。

土入水——运土入水，使阴阳相济而止泻。

肝木旺——肝火旺盛往往损伤脾胃，影响脾胃的升降功能。

小腹寒——凡受风寒冷气者，则小腹疼痛。

外劳宫——此穴在手背，属热穴，能祛风散寒。

左右揉——在穴位上左右揉动。

久揉良——推揉的次数越多越好，直至小腹寒痛止。

嘴唇裂——脾开窍于口，其华在唇。脾伤则唇裂、肿痛或口内外生疮，皆为脾症。

脾火伤——因脾火太盛而受伤。

眼泡肿——上眼皮肿属脾，下眼皮肿属胃，眼泡肿乃脾胃火盛。

脾胃恙——虽属脾胃之火，但也与肝肾有关。

清补脾——伸拇指来回推之，治疗湿热留恋日久不退。

俱去恙——以上病症均能治愈。

向内补——向内推为补，治虚症。

向外清——向外推为清，治实症。

来回推——来回用力推之，可和血顺气，虚实皆治。

清补双——平补平泻，用于虚实夹杂症。

天门口——此指天门入虎口穴。用大指面自命关处推向虎

口后，再用大指端掐揉虎口。

顺气血——天门入虎口则顺气和血，使气血畅通。

五指节——此穴舒筋和血通络。主治惊风抽搐，惊吓。

惊吓伤——小儿伤于肝胆则惊吓，伤脾久者则出现腹泻。

不计次——不必计算次数和顺序。

揉必良——掐揉之均能取得良效。

腹痞积——小儿腹内有痞积之症，或左或右，或软或硬，均属此例。

时摄良——每天按时推拿，则气滞得消。

一百日——坚持治疗100天。

即无恙——只要坚持就一定能治愈。

上有火——上有火者，下焦必寒。

下有寒——下有寒者，上焦必热。

外劳宫——此穴位于手背属大热穴，揉之能祛寒风冷。

下寒凉——下部有寒症，推拿此穴能温下元，去虚寒。

六腑穴——左手六腑穴属大凉穴，推之能去上焦之火。

去火良——若上火下寒，必兼推此穴。

左三关——左手三关穴，也属大热穴。

去寒恙——推上三关，能去上焦之寒。

右六腑——右手六腑穴。

亦去恙——也能治疗疾病。

虚补母——如肺虚可补脾，脾为肺之母，肺为脾之子。

实泻子——实症可泻其子，如脾热可泻肺经。

日五行——昼夜二十四时都有五行存在。

生克当——正常情况下，五行相生相克是有一定规律的。

生我母——生我者为母，指五行的相互生理关系。

我生子——我生者为子，如金生水。

穴不误——辨证准确，选穴精当无错误。

治无恙——只要选穴正确就一定有疗效。

古推书——古代的推拿书。

身手足——是经过在人体各个部位反复实践得出的结论。

执治婴——推拿以小儿为最多。

无老方——没有固定的穴位、方法，应以辨证取穴，灵活运用。

皆气血——都是气血。

何两样——不分老少男女。

数多寡——根据患者的岁数，决定推拿次数的多少。

轻重当——手法的轻重要恰当。

吾载穴——我记载的穴位与古人的不同，大多数是以独穴为主。

不相商——经验多次，验之有效。

少老女——凡男女老少均可推用。

无不当——无论男女老幼，凡疾病皆可用推拿治疗。

遵古推——遵照古老推法，男女分左右手。

男女分——古代推法分男女。

俱左手——男女俱推左手。

男女同——穴位治疗没有差别，作用一样。

手当试——通过实践，左右手作用相同。

关去恙——都一样能祛病。

凡学者——希望学推拿者，细心研究，精心体会。

意会方——弄清实质，掌握各穴功能，运用时变化无穷，得心应手，运用自如。

加减推——选穴时必须分清寒热虚实，当加则加，当减则减。

身歉状——人身气血虚弱，根据歉状之症，决定手法轻重和取穴次数的多少。

病新久——病有新久、轻重之分，症有虚实，临证时要辨证论治，取穴精当。

细思详——要细心考虑，详细辨症。

推应症——所推之穴要与症相符，才能取得良效。

无苦恙——推拿无痛苦，也无副作用。

传后世——将此推拿法留传于后世。

救人良——为了解除病人的疾苦，拯救患者的性命，为后人做了件好事。

附　　录

一、常用穴位表

该表说明穴位的位置、推拿法、操作方向、功用、主治等，以便于学习掌握。

常用穴位

分类	穴名	位　置	推拿法	操作方向	功　用	主　治
头面部穴位	攒竹（天门）	两眉中间（印堂）至前发际成一直线	推攒竹（开天门）	自下向上	发汗解表，镇惊安神，止头痛	头痛、感冒、发热、烦躁不安、无汗等
	坎宫（眉弓）	自眉头起，沿眉向眉梢成一横线	推坎宫（推眉弓）	自印堂向两侧分推	发汗解表，醒脑明目，止头痛	感冒、头痛、头晕、目赤痛
	太阳	在眉梢与目外眦之间，向外约1横指处凹陷中	运太阳（泻）	向耳后转	解表止头痛	感冒、头痛
			运太阳（补）	向眼前转	固表止头痛	感冒、自汗、头痛
	耳后高骨	在耳后乳突骨下凹陷处	运耳后高骨	旋转	发汗解表镇惊除烦	感冒、头痛、烦躁不安、惊风
	人中	在人中沟正中处	掐人中	垂直	开窍醒神	惊风、昏迷
	百会	后发际正中直上7寸，从两耳尖直上，头正中线取之	揉、按百会	旋转、垂直	升阳举陷安神镇静止头痛	遗尿、脱肛、夜寐不安，头痛眩晕等
	天柱骨	在颈后，自风府至大椎成一直线	推天柱骨	自上向下	止呕吐，散风寒	呕吐、恶心、项强、落枕、咽痛

（续表）

分类	穴名	位置	推拿法	操作方向	功用	主治
头面部穴位	风池	在枕骨下缘，胸锁乳突肌与斜方肌之间凹陷处	拿风池，掐风池	左穴对右眼，右穴对左眼方向用力	发汗解表，止头痛	感冒、头痛、项僵、无汗等
	印堂	在两眉头正中处	掐印堂	垂直	清脑、止头痛	感冒、头痛、惊风等
	囟门	前发际正中直上2寸，百会前骨陷中	推囟门	囟门未闭者沿其边缘由下而上	镇惊，安神，通窍	头痛、鼻塞、头晕、惊风
	山根	在两目内眦正中处	掐山根	垂直	定惊、开窍，安神	惊风、抽搐、昏迷
	准头	在鼻尖中央	揉准头	旋转	通鼻窍，开窍醒神	鼻塞不通、惊风抽搐
	牙关（颊车）	在耳下，咬牙时咬肌隆起处	按牙关	垂直	开窍通络止牙痛	牙关紧闭口眼歪斜、牙痛等
	迎香	在鼻翼外缘0.5寸鼻唇沟中	揉迎香	旋转	宣肺气，通鼻窍	鼻塞、流涕，急、慢性鼻炎，口眼歪斜
	承浆	在下嘴唇下，正中凹陷处	掐承浆	垂直	祛风开窍，通络醒神	惊风、口眼歪斜、抽搐、面瘫、三叉神经痛
	耳门（耳风门）	在耳屏上切迹之前方，张口凹陷处	揉耳门	旋转	镇惊开窍，聪耳，止牙痛	惊风抽搐、耳聋耳鸣、口眼歪斜、牙痛等
	桥弓	在颈部两侧，沿胸锁乳突肌成一线	抹桥弓	自上而下	舒筋活络，调和气血，平肝潜阳，降低血压、平喘	肌性斜颈、颈项强痛、高血压、惊风、哮喘等
胸腹部穴位	天突	在胸骨上窝正中凹陷处	按天突	向后下方	降逆平喘，理气化痰，止呕吐	咳喘胸闷、痰壅气急、恶心呕吐等
	膻中	在胸骨中线上，两乳之间	推揉膻中	先分推然后揉	宽胸理气，宣肺止咳，化痰	胸闷、咳嗽、气喘、胸痛、呕吐

（续表）

分类	穴名	位置	推拿法	操作方向	功用	主治
胸腹部穴位	乳旁	乳头外旁开0.2寸	揉乳旁	旋转	宽胸理气，止咳化痰	胸闷咳嗽、痰鸣呕吐
	乳根	在乳下0.2寸	揉乳根	旋转	宣肺止咳，理气化痰	喘咳、胸闷、痰鸣
	中脘	在肚脐正中直上4寸处	揉中脘	旋转	健脾开胃，消食和中	腹胀、食积、腹痛、呕吐腹泻、食欲不振
	腹	腹部	分推腹阴阳	自中脘至脐两旁，分向推动	降逆止呕，和胃消食	伤食呕吐、腹胀厌食
			摩腹	环转	健脾和胃，止吐泻	腹泻、呕吐、便秘等
	胁肋	在腋下两胁至天枢处	搓摩胁肋	自上而下	顺气化痰，除胸闷，开积聚	胸闷、腹胀、痰喘气急、痞积、胁痛、肝脾肿大
	天枢	在肚脐旁开2寸处	揉天枢	旋转	疏调大肠，理气消滞	便秘、腹胀、腹痛腹泻、食积
	神阙（脐）	肚脐	揉肚脐	旋转	温阳散寒，益气血，健脾胃，消食导滞	腹泻、便秘、腹痛、痞积等
	丹田	在小腹部脐下2.5寸	按丹田	内下方	培肾固本，温补下元，泌别清浊	小腹胀痛、尿潴留、小便短赤、遗尿等
			摩丹田	旋转		
	肚角	脐下2寸（石门）旁开2寸大筋处	拿肚角	向外	止腹痛	腹痛、泻痢
	气海	腹正中线脐下1.5寸	揉气海	旋转	散寒，止腹痛	虚寒腹痛、腹泻、遗尿、脱肛、疝气
	关元	在腹正中线脐下3寸处	揉关元	旋转	温肾壮阳，培补元气	虚寒腹痛、腹泻、遗尿等

（续表）

分类	穴名	位置	推拿法	操作方向	功用	主治
腰背部穴位	肩井	在大椎与肩峰连线的中点	拿肩井	向后上方	宣通气血，通经活络	感冒、劲项强痛、上肢痹痛等
	大椎	在第7颈椎棘突下	揉大椎	旋转	清热解表，通经活络	发热、感冒、项强、咳嗽等
			挤捏大椎	自两侧向中间挤		
	风门	第2胸椎棘突下旁开1.5寸	揉风门	旋转	疏风解表，宣肺止咳	风寒感冒、咳嗽、项强等
	肺俞	第3胸椎棘突下旁开1.5寸	揉肺俞	旋转	调肺气，补虚损，止咳嗽	咳嗽气喘、痰鸣胸闷、久咳不愈、胸痛等
			分推肩胛骨	由上而下		
	脾俞	第11胸椎棘突下旁开1.5寸	揉脾俞	旋转	健脾胃，助运化祛水湿	脾虚厌食、腹泻、疳积、慢惊风等
	胃俞	第12胸椎棘突下旁开1.5寸	揉胃俞	旋转	和胃健脾，理中降逆	胃脘痛、呕吐腹胀、消化不良等
	肾俞	第2腰椎棘突下旁开1.5寸	揉肾俞	旋转	滋肾壮阳，补益肾气	肾虚腹泻、遗尿、气喘、便秘等
	腰俞	第3腰椎棘突下旁开3.5寸凹陷中	揉腰俞	旋转	通经活络	腰痛、下肢瘫痪等症
	脊柱	大椎至长强成一直线	捏脊	自下向上	培元气，补虚损，强壮身体	疳积、腹泻、食积、腹痛、便秘、呕恶
			推脊	自上向下	清热	发热
	七节骨	第4腰椎至尾骨端成一直线	推上七节骨	自下向上	温阳止泻	腹泻、痢疾、脱肛
			推下七节骨	自上向下	泄热通便	便秘、痢疾
	龟尾	在尾椎骨端	揉龟尾	旋转	调理大肠	腹泻、便秘、脱肛等

（续表）

分类	穴名	位置	推拿法	操作方向	功用	主治
上肢部穴位	脾经	在拇指桡侧边缘，指尖至指根成一线	补脾经	自指尖向指根	健脾胃，补气血	腹泻、便秘、厌食、体虚、消积等
			清脾经	自指根向指尖	清热利湿，化痰涎	呕吐、便秘、黄疸痢疾
			清补脾经	来回用力	和胃消食，增食欲	食积、腹胀、呕吐等
	肝经	在食指末节罗纹面	清肝经	向指尖推	平肝泻火，解郁除烦，熄风镇惊	惊风抽搐、烦躁不安、目赤肿痛、口苦等
	心经	中指末节罗纹面	清心经	向指尖	清热退心火	发热面赤、口舌生疮、小便短赤
			补心经	向指根	养心安神	气血虚弱、心烦不安。本法较少用
	肺经	在无名指末节罗纹面	清肺经	自指根向指尖	宣肺清热，止咳化痰	感冒发热、咳嗽、气喘、痰鸣
			补肺经	向指根方向	补益肺气	肺气虚损、面白、自汗畏寒、咳喘
	肾经	在小指掌面稍偏尺侧，自小指尖直至掌根成一线	补肾经	自掌根向指尖	滋肾壮阳，强健筋骨	先天不足、久病体虚、遗尿泄泻、喘咳等症
			清肾经	自指尖向掌根	清利下焦湿热	膀胱蕴热、小便短赤等
	大肠	食指桡侧缘，指尖至虎口成一直线	补大肠	自指尖向指根	温中止泻，涩肠固脱	虚寒腹泻、痢疾、脱肛
			清大肠	自指根向指尖	清热利湿，通大便	大便秘结、赤白痢疾
	小肠	在小指尺侧边缘，自指尖至指根成直一线	清小肠	自指根向指尖	清热利尿泌别清浊	小便短赤，水泻等
			补小肠	自指尖向指根	滋阴补虚，利小便	阴虚火旺，小便短赤

（续表）

分类	穴名	位置	推拿法	操作方向	功用	主治
上肢部穴位	肾顶	在小指顶端	揉肾顶	旋转	收敛元气，固表止汗	自汗、盗汗、解颅、大汗淋漓不止等
	肾纹	手掌面，小指第2指间关节横纹处	揉肾纹	旋转	祛风明目，散瘀结，清热	目赤肿痛、鹅口疮、热毒内陷等
	掌小横纹	在掌面小指根下，尺侧掌纹头	揉掌小横纹	旋转	清热散结，宽胸宣肺，化痰止咳	痰热咳喘，口舌生疮、肺炎、百日咳等
	小横纹	在掌面食、中、无名、小指的掌指关节横纹处	推小横纹	依次来回用力推	退热、消胀、散结	唇裂、口疮、发热烦躁腹胀等
	四横纹	掌面食、中、无名、小指的第1指间关节横纹处	掐揉四横纹	依次掐揉	和气血，退热除烦	气血不和、疳积、腹胀腹痛、消化不良、惊风、气喘
			推四横纹	来回推之		
	运土入水	自脾经沿掌缘至肾经成弧线形	运土入水	自脾经向肾经	清脾胃湿热，利尿止泻	腹胀便秘、痢疾、腹泻
			运水入土	自肾经向脾经	健脾助润，运燥通便	身弱腹胀、食欲不振、泻痢
	胃经	在大鱼际肌桡侧，赤白肉际处	清胃经	自掌根向指根	清脾胃湿热，和胃降逆	恶心呕吐、腹胀、口臭、便秘、食欲不振等
	板门	在手掌大鱼际平面	运板门（揉板门）	旋转	健脾和胃，消食化滞	乳食停积、腹胀腹泻、食欲不振等
			板门推向横纹	自拇指根向掌根	止泻	泄泻
			横纹推向板门	自掌根向拇指根	止呕吐	呕吐、恶心
			清板门	来回用力	清胃热	口疮、牙龈肿痛

（续表）

分类	穴名	位置	推拿法	操作方向	功用	主治
上肢部穴位	内劳宫	在掌心中，屈指当中指尖之中点处	揉内劳宫（运内劳宫）	旋转	清热除烦，熄风凉血	发热、五心烦热、口舌生疮、烦渴、齿龈糜烂
	内八卦	在手掌，自内劳宫至中指根内2/3处为半径画一圆，八卦即分布在此圆上。坎穴对小天心，离穴对中指根，震穴在桡侧半圆的中点，兑穴在尺侧半圆的中点，再于每两穴之间按顺序排好乾、艮、巽、坤	运八卦（顺运八卦）	自乾穴顺运向兑穴	宽胸理气，止咳化痰行滞消食	咳嗽、气喘、胸闷腹胀、食欲不振、腹痛、腹泻等
			逆运八卦	自兑穴逆运向乾穴	降胃气，止呕叶，平喘	气喘咳嗽、恶心呕吐
	小天心（鱼际交）	在掌面大小鱼际交接处凹陷中	掐揉小天心	垂直掐，旋转揉	清热，镇惊，利尿，明目	心经火热、口舌生疮、目赤肿痛、小便短赤、夜啼、惊风等症
			揭小天心	垂直方向		
	总筋	在掌后腕横纹之中点	揉总筋	旋转	清心热，散结	心经热、口舌生疮、夜啼、潮热等
	大横纹（阴阳）	仰掌，掌后横纹。近拇指侧为阳池，近小指侧为阴池	分阴阳（分推大横纹）	向两侧分	平衡阴阳，调和气血，行滞消食	寒热往来、乳食停滞、腹胀腹泻、呕吐、痢疾
			合阴阳	从两侧向中点	行痰散结	痰结喘嗽、胸闷等
	十宣	在十指尖端指甲内赤白肉际处	掐十宣	垂直	清热，醒神，开窍	高热惊风、抽搐昏迷、两目上视、烦躁不安等

（续表）

分类	穴名	位置	推拿法	操作方向	功用	主治
上肢部穴位	二扇门	在手背中指根本节两侧凹陷处	掐揉二扇门	垂直掐，旋转揉	发汗透表，退热平喘	伤风感冒、发热无汗、痰喘气粗、口眼歪斜、急惊风等
	二人上马（上马、二马）	手背无名指与小指的掌指关节后凹陷中	揉二马	旋转	滋阴补肾，顺气散结，利尿通淋	虚热咳喘、小便短赤、遗尿、脱肛、睡时磨牙等
	外劳宫	在手背中，与内劳宫相对处	掐外劳，揉外劳宫	垂直掐，旋转揉	温阳散寒，升阳举陷，兼能发汗解表	风寒感冒、鼻塞流涕、腹痛肠鸣、遗尿、脱肛
	五指节	在手指背面，拇、食、中、无名、小指的第1指间关节处	掐、揉五指节	垂直掐，旋转揉	祛风痰，通关窍，安神镇惊	胸闷、惊风、惊惕不安、风痰咳喘等
	威灵	在手背2、3掌骨歧缝间	掐威灵	垂直	开窍醒神	惊风抽搐、昏迷不醒
	精宁	手背4、5掌骨歧缝间	掐精宁	垂直	行气，破结，化痰	痰食积聚、气吼痰鸣、急惊昏厥等
	左端正	中指甲根桡侧，旁开1分处	揉左端正	旋转	升提中气，止泻	水泻、痢疾
	右端正	中指甲根尺侧，旁开1分处	揉右端正	旋转	降胃气，止呕吐	恶心呕吐、鼻衄等症
	合谷	在手背第1、2掌骨之间，近第2掌骨中点的桡侧	按揉合谷	垂直按，旋转揉	清热，通络，止痛	发热无汗、头痛、项强、面瘫、牙痛、口疮等
	外八卦	在手背外劳宫周围，与内八卦相对处	运外八卦	旋转	宽胸理气，通滞散结	胸闷、腹胀、便秘等症
	少商	拇指桡侧缘，距指甲角约0.1寸	掐少商	垂直	清热利咽，开窍	发热、咽喉肿痛、昏迷、窒息、口疮
	商阳	食指桡侧端，距指甲角约0.1寸	掐商阳	垂直	清热利咽	发热、咽喉肿痛、耳聋、面肿等症

（续表）

分类	穴名	位置	推拿法	操作方向	功用	主治
上肢部穴位	中冲	在中指尖端处	掐中冲	垂直	清热，通络，开窍	发热烦闷、五心烦热、口疮、弄舌等
	关冲	在无名指尺侧端，距指甲角后约0.1寸	掐关冲	垂直	清热止头痛，利咽喉	发热头痛、咽喉肿痛、结膜炎等
	少泽	在小指尺侧，距指甲角约0.1寸	掐少泽	垂直	退热，止痉，通络	身热无汗、癫疯、乳痛、头痛、口疮等
	一窝风	在手背腕横纹正中凹陷处	揉一窝风	旋转	温中行气，止痹痛，利关节	腹痛肠鸣、关节痹痛、风寒感冒等症
	膊阳池	在手背一窝风后3寸处	掐膊阳池，揉膊阳池	垂直掐，旋转揉	止头痛，通大便，利小便	大便闭结、小便短赤、感冒头痛等病症
	曲池	曲肘，在肘窝桡侧横纹头至肱骨外上髁中点	掐、揉曲池	垂直掐，旋转揉	解表退热，利咽喉	风热感冒、咽喉肿痛、上肢痿软、抽掣、咳喘、呕吐、泄泻等
	洪池	肘关节内侧，肘横纹中点	摇洪池	环转	调和气血，通调经络	气血不和、关节痹痛等症
	肘肘	在肘关节鹰嘴突处	摇肘肘	环转	通经活血，顺气生血，化痰	气血不和、痹痛、痞块、痰嗽、急惊
	拇腮	拇指背，距指甲根中点约1分处	掐拇腮，揉拇腮	垂直掐，旋转揉	降逆止呕	胃气上逆、呕吐恶心等
	皮罢（肝记）	拇指尺侧，大指甲根旁开约1分处	掐皮罢	垂直	降气平喘，醒神	哮喘、昏迷抽搐等症
	甘载	在手背合谷后，第1、2掌骨交接处凹陷中	掐甘载	垂直	开窍醒神	昏厥、不省人事，惊风抽搐

（续表）

分类	穴名	位置	推拿法	操作方向	功用	主治
上肢部穴位	三关	前臂桡侧，阳池至曲池成一直线	推三关	自腕推向肘	温阳散寒，益气活血，兼发汗解表	腹痛腹泻、畏寒、四肢乏力、病后体虚、风寒感冒等虚、寒症
	天河水（河水）	在前臂内侧正中，自腕横纹至肘横纹成一直线	清天河水（推河水）	自腕推向肘	清热解表，泻心火，除烦躁，润燥结	外感发热、身热、潮热、烦躁不安、口渴、弄舌、口舌生疮、惊风、咽痛、咳喘、夜啼等
	六腑	在前臂尺侧缘，腕横纹至肘横纹成一直线	推六腑（退六腑）	自肘向腕	清热，凉血，解毒	高热、烦渴、口渴、惊风、鹅口疮、咽痛、重舌、痄腮、便秘、热痢等症
下肢部穴位	箕门	大腿内侧膝盖上缘至腹股沟成直线	推箕门	自膝向大腿根部	利小便	小便短赤不利、尿潴留、水泻等
	膝眼	在膝盖骨之下两旁凹陷中	拿膝眼	内下相对	止惊，通络	惊风抽搐、下肢痿软、膝部疼痛、屈伸不利等
	百虫窝（血海）	膝上内侧肌肉丰厚处（髌骨内上缘2.5寸处）	拿百虫窝	对称	通经络，止抽搐	下肢痿软、瘫痪，痹痛，四肢抽搐等症
	三阴交	内踝上3寸处	揉三阴交	旋转	疏利下焦，通调水道，活经络，利湿热，健脾助运	癃闭，遗尿，小便频数、短赤不利，下肢痹痛，消化不良
	解溪	踝关节横纹中点，两筋之间凹陷处	揉解溪	旋转	舒筋活络，解痉，止吐泻	踝关节伤筋、踝关节屈伸不利及吐泻等

（续表）

分类	穴名	位置	推拿法	操作方向	功用	主治
下肢部穴位	足三里	外膝眼下3寸，胫骨前嵴外1横指处	揉足三里	旋转	健脾胃，助运化，强壮身体	脘腹胀满腹痛肠鸣、呕吐腹泻、食欲不振等
	前承山（条口）	外膝眼下8寸（上巨虚下2寸），距胫骨前嵴1横指	掐前承山，揉前承山	垂直掐，旋转揉	止惊，舒筋通络	急惊、抽搐、角弓反张、腓肠肌痉挛、关节疼痛等
	后承山	在腓肠肌腹（腿肚）下凹陷中（人字纹处），与前承山相对	揉承山，拿承山	旋转对称	止抽搐，通经络	惊风抽搐腿痛转筋下肢痿软腰痛麻痹，腹泻便秘
	委中	在腘窝中央，两大筋中间	按揉委中	旋转	通络，泻热，止抽搐	腰膝痛、背痛、惊风抽搐、下肢痿软、痹痛等症
	昆仑	外踝后缘与跟腱内侧的中间凹陷处	掐昆仑，按揉昆仑	垂直掐、旋转	止惊，通络	惊风抽搐、项强及踝部疼痛等
	涌泉	屈趾，足掌心前正中凹陷处	推涌泉，揉涌泉	向趾尖推，旋转	引火归元，退虚热	五心烦热、烦躁不安、呕吐腹泻等
	仆参	在足跟外踝下凹陷中	拿仆参	对称	醒神开窍	昏厥、惊风抽搐等症

二、复合手法（十三大手法）表

名称	方法	功用
打马过天河	医者左手握患儿手，以右手拇指运内劳。然后以食、中指顶端，自总筋、内关、间使、循河水穴一起一落打至洪池为1次	退热，活络
黄蜂入洞	医者以左手扶患儿头，右手食、中二指轻揉两鼻孔下揉之	通气，散风寒

（续表）

名　称	方　　法	功　用
水底捞月	医者以左手持患儿四指，右手拇指自患儿小指尖起，经鱼际交推运至内劳	退热
按弦走搓摩	医者以两手掌从患儿两胁搓摩至肚角处	顺气，化痰，消积
猿猴摘果	医者以食、中二指夹住患儿两耳尖，向上提；再捏两耳垂向下扯	定惊，祛寒
摇肘肘	医者先以左手拇、食、中三指托患儿肘肘，再以右手拇、食两指叉入虎口，中指按定小鱼际处，然后屈儿手上下摇动	顺气血，通经络
飞经走气	医者用右手握住患儿四指，以左手四指从曲池起，按之、跳之，到总筋处数次，再以左拇、中二指拿住患儿的阴池、阳池二穴不动，然后右手将患儿左手四指向上向外，一屈一伸连续活动	行气，清肺化痰
二龙戏珠	医者以左手握患儿手，使掌心向上；以右手食、中指自总筋起，交互向前点按至曲池	镇惊定抽，调和气血
苍龙摆尾	医者以左手托儿肘肘，右手握住患儿食、中、无名、小指，做左右摆动	退热，开胸，通便
揉脐及龟尾并擦七节骨法	先叫患儿仰卧，医者一手揉脐，一手揉龟尾，再叫患儿伏卧，推七节骨	止泻痢
赤凤点头	医者以左手托儿肘肘，右手捏提患儿中指，上下摆动。	消膨胀，定喘息，通关顺气
凤凰展翅	医者以食、中指固定患儿腕部，以两拇指掐精宁、威灵，上下摆动前臂	救暴亡舒喘胀，除噎，定惊
按肩井法（总收法）	医者以左手中指掐按患儿肩井，右手拇、食、中指拿患儿食指和无名指，使其伸直摆动	通行一身之气血

三、穴位作用归类总结

为了便于学习和临床辨证应用，现把穴位的推拿法分类归纳如下。

1. 解表类　开天门（推攒竹），推坎宫，运太阳（泻），运耳后高骨，黄蜂入洞，掐风池，挤捏大椎，揉大椎，揉迎香，推三关，拿肩井，清天河水，掐揉二扇门，凤凰展翅等。

2. 清热类　清肝经，清心经，清脾经，清肾经，清大肠，清小肠，清胃经，清天河水，退六腑，掐揉小天心，掐揉内劳宫，清板门，打马过天河，水底捞月，掐四横纹，推小横纹、揉掌小横纹，揉肾纹，推脊，推涌泉，掐十王，掐商阳，掐关冲，揉曲池，苍龙摆尾，运土入水。

3. 补益类　补脾经，补心经，补肺经，补肾经，补大肠，补小肠，揉二人上马，揉丹田，揉肾俞，推三关，摩腹（补），揉肚脐（补）、捏脊，揉中脘，揉足三里，揉肺俞，揉脾俞，揉胃俞，运水入土等。

4. 温阳散寒类　掐揉二扇门，揉一窝风，揉外劳宫，摩肚脐（补），推三关，揉丹田，揉二人上马等。

5. 消食化滞类　清补脾经，揉板门（运板门），顺运内八卦，分手阴阳，摩中脘，分腹阴阳，揉足三里，揉脾俞，揉天枢，猿猴摘果等。

6. 止泻类　推上七节骨，补大肠，板门推向横纹，运土入水，向上推按后承山，掐左端正，揉龟尾，捏脊，揉脐及龟尾并擦七节骨，摩肚脐，揉天枢，拿肚角，揉足三里，右揉涌泉等。

7. 止腹痛类　揉一窝风，拿肚角，拿后承山，按中脘，按足三里，按脾俞，按胃俞，摩腹等。

8. 通大便类　清大肠，掐、揉膊阳池，向下推按后承山，揉、摩肚脐（泻），推下七节骨，揉龟尾，运手背八穴（外八卦）等。

9. 止呕吐类　推天柱骨，横纹推向板门，分腹阴阳，掐揉右端正，左揉涌泉，逆运内八卦，清胃经，掐拇腮，按弦走搓摩，推中脘，揉天突等。

10. 利小便类　推箕门，清小肠，推按丹田，揉小天心，清肾经，揉膊阳池等。

11. 止咳化痰平喘类　推揉膻中，揉乳根，揉乳旁，揉肺俞，清肺经，顺运内八卦，揉、按天突，挤捏天突，掐皮罢，按弦走搓摩，揉掌小横纹，推小横纹，开旋玑，合推大横纹，分推肩胛骨，开璇玑，赤凤点头，飞经走气，扶桥弓等。

12. 理气类　顺运内八卦，顺时针摩腹，推揉膻中，搓摩胁肋，按揉足三里，擦胸背法。

13. 镇惊安神类　开天门，推坎宫，掐山根，掐印堂，揉囟门，按揉百会，捣、揉小天心，掐、揉五指节，清肝经，清心经，猿猴摘果，二龙戏珠等。

14. 醒神开窍类　掐人中，掐山根，掐十王，掐老龙，掐精宁，掐威灵，按合谷，拿仆参，掐甘载，掐少商，掐中冲等。

15. 通鼻窍类　揉迎香，黄蜂入洞，推囟门，揉准头，拿风池，清肺经。

16. 止抽搐类　按牙关，掐承浆，拿百蟾，按拿委中，拿前承山，拿后承山，拿曲池。

17. 固表止汗类　揉肾顶，运太阳（补）等。

18. 通经活络，调气血类　掐揉四横纹，按摇洪池，摇肘肘，揉一窝风，按肩井，天门入虎口等。